AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

SERIE AEE · PERFIL V3

REPASO FINAL

NEUROLOGÍA

Geriatría

26 temas · 1 página cada uno · **7** días de plan de repaso

Índice

Cómo usarlo. Un tema por página: lee «Lo que te preguntan», recorre el algoritmo y termina en las trampas y la regla de oro. Después haz las preguntas del Libro Gordo que indica el pie.

★★★ alta · ★★☆ media · ★☆☆ baja — según cuántas preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) hay en los códigos del tema.
Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento.

01 Enfermedad Cerebrovascular y Urgencias Neurovasculares

★★★ 10.1. Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES GES 4
★★★ 10.2. Ataque Isquémico Transitorio (AIT): Score ABCD2, Estratificación de Riesgo Precoz y Prevención Secundaria GES 6
★★★ 10.3. Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos GES 7
★★☆ 10.4. Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino GES 9
★★★ 10.5. Trombosis Venosa Cerebral: Factores Protrombóticos, Sospecha Clínica, Neuroimagen y Anticoagulación Plena 11

02 Cefaleas, Síndromes Convulsivos y Epilepsia

★★☆ 10.6. Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional 12
★☆☆ 10.7. Cefalea en Racimos (Cluster) y Neuralgia del Trigémino: Diagnóstico Diferencial, Manejo Agudo y Preventivo 14
★★☆ 10.8. Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES GES 15
★☆☆ 10.9. Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo GES 17
★★☆ 10.10. Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas 19

03 Trastornos del Movimiento y Enfermedades Neurodegenerativas

★★★ 10.11. Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras GES 20
★★☆ 10.12. Parkinsonismos Secundarios, Farmacológicos y Síndromes Parkinson-Plus 22
★☆☆ 10.13. Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos 23
★★★ 10.14. Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve GES 24
★★☆ 10.15. Demencia Vascular, Demencia por Cuerpos de Lewy y Demencia Frontotemporal GES 26

04 Patología Neuromuscular, Desmielinizante y Nervio Periférico

★★★ 10.16. Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo 27
★★☆ 10.17. Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma 29
★☆☆ 10.18. Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad GES 31
★★☆ 10.19. Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento 33
★★☆ 10.20. Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central: VPPB, Maniobras de Epley y Protocolo HINTS GES 34

05 Geriatría Clínica y Grandes Síndromes Geriátricos

★★★ 10.21. Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente 35
★★☆ 10.22. Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI) 37
★☆☆ 10.23. Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES GES 38
★★★ 10.24. Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor 39
★☆☆ 10.25. Cardiovascular en el Adulto Mayor: Hipertensión Arterial y Evento Coronario GES 40
★☆☆ 10.26. Cuidados Paliativos, Dolor Crónico y Final de Vida GES 42

Índice · continuación

Números que tienes que saber	43
Fármacos de primera línea	46
GES de la especialidad	47
Plan de repaso de 7 días	50
Índice por prioridad ★	51

BLOQUE 01 · ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR Y URGENCIAS NEUROVASCULARES

10.1 Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES

★★★ PRIORIDAD ALTA
15 preguntas reales 2013–2025

1.10.2.007 **Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)** Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: TAC de encefalo y columna · Prevención de factores de riesgo cerebrovascular · Enfermedad cerebro-vascular · Cuadros deficitarios de funciones cerebrales superiores (afasia, apraxia, agnosia, etc)

LO QUE TE PREGUNTAN

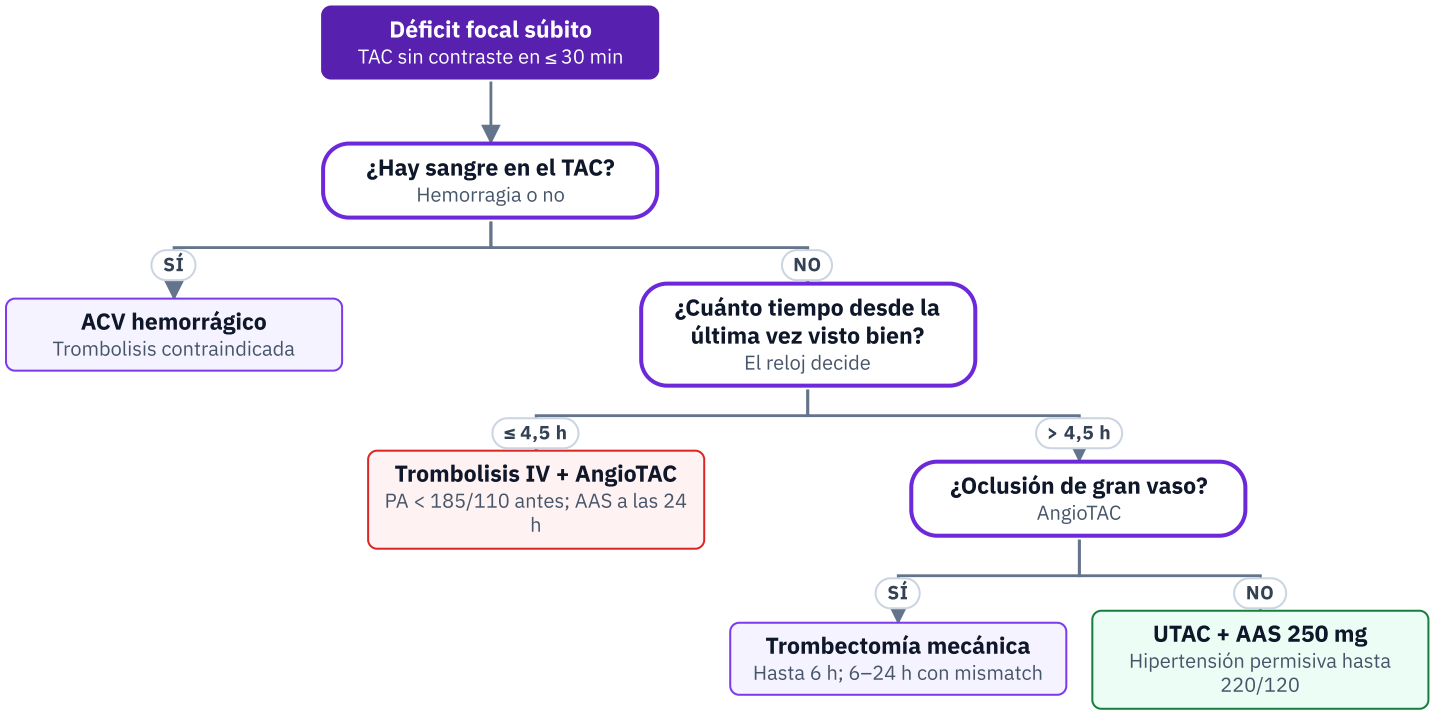
- Todo déficit neurológico focal agudo es una emergencia médica tiempo-dependiente: el TAC de encéfalo sin contraste debe realizarse e informarse en **≤ 30 minutos** desde el ingreso.
- El rol principal del TAC sin contraste en las primeras **4.5 horas** es descartar hemorragia intracerebral; un TAC normal confirma la sospecha de ACV isquémico y NO contraindica la trombolisis.
- La ventana para trombolisis endovenosa con Alteplase (**0.9 mg/kg**) o Tenecteplase (**0.25 mg/kg**) es de hasta **4.5 horas** desde el inicio de los síntomas o la última vez visto asintomático.
- **Criterio tensional pre-trombolisis estricto**: la PA debe reducirse a < 185/**110 mmHg** antes de iniciar el trombolítico con Labetalol o Nicardipino EV.
- Si el paciente NO es candidato a reperfusión, se adopta hipertensión permisiva: NO reducir la PA a menos que supere 220/**120 mmHg** para no hipoperfundir la penumbra isquémica.
- La trombectomía mecánica endovascular está indicada en oclusión de gran vaso (carótida terminal, ACM M1) hasta las **6 horas** de forma estándar, y hasta las **24 horas** en centros especializados con mismatch por perfusión (ensayos DAWN y DEFUSE-3).



SIGNOS PRECOCES
Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 62

ALGORITMO · ACV ISQUÉMICO AGUDO: REPERFUSIÓN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **3–8, 37** (págs. 10–11, 15) · solucionario págs. 23–25, 30.

Clase 10.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR Y URGENCIAS NEUROVASCULARES

10.1 Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES

★★★ PRIORIDAD ALTA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 10.1 · CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA TOAST Y TERRITORIOS VASCULARES EN ACV ISQUÉMICO

SUBTIPO / TERRITORIO	MECANISMO FISIOPATOLÓGICO	PRESENTACIÓN CLÍNICA CARDINAL	HALLAZGOS CLAVE DE EXAMEN
Arteria Cerebral Media (ACM)	Embolia arteria-arteria o cardioembolia a tronco principal (M1) o ramas (M2)	Hemiparesia y hemihipoestesia faciobraquial contralateral predominante + Desviación oculocefálica ipsilateral	Afasia de Broca/Wernicke/Global (hemisferio dominante) · Negligencia hemiespacial / Asomatognosia (no dominante)
Arteria Cerebral Anterior (ACA)	Oclusión embólica o trombótica de ramas prefrontales y parasagitales	Hemiparesia y hemihipoestesia crural contralateral (pierna > brazo) · Abulia, mutismo acinético, reflejos arcaicos	Incontinencia urinaria de origen frontal · Apraxia de la marcha · Pérdida de inhibición social
Arteria Cerebral Posterior (ACP)	Oclusión de ramas occipitales y temporomediales (frecuentemente cardioembólica)	Hemianopsia homónima contralateral con preservación macular · Alexia sin agrafia (lesión esplenio del cuerpo calloso)	Agnosia visual · Desorientación topográfica · Amnesia anterógrada si compromiso hipocámpico
Circulación Vertebrobasilar	Oclusión de arteria basilar, vertebrales o arterias cerebelosas (PICA, AICA, SUCA)	Síndrome cruzado (déficit de par craneal ipsilateral + hemiparesia/hemihipoestesia contralateral)	Vértigo central, ataxia severa, diplopía, disfagia, disartria, compromiso fluctuante de conciencia hasta coma
Infarto Lacunar (Pequeño Vaso)	Lipohialinosis y microateromatosis hipertensiva en arterias perforantes lenticuloestriadas	Síndromes lacunares puros: Hemiparesia motora pura (brazo posterior cápsula interna) o Sensitivo puro (núcleo VPL tálamo)	Ataxia-hemiparesia · Disartria-mano torpe · Ausencia característica de afasia, hemianopsia o negligencia

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Déficit focal súbito	TAC sin contraste en ≤ 30 min	Pedir resonancia primero
TAC normal a las 2 horas	Trombolisis IV	Pensar que no es un infarto
PA 200/115 y candidato a IVT	Labetalol hasta < 185/110 y luego IVT	Trombolizar con esa presión

REGLA DE ORO **TAC sin contraste en ≤ 30 min** — Busca sangre, no el infarto

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El ataque cerebrovascular (ACV) isquémico es la principal causa de discapacidad adquirida en el adulto y una de las mayores urgencias médicas en Chile (Garantía GES N° 37). En el cerebro isquémico, "tiempo es cerebro": se destruyen 1.9 millones de neuronas por minuto. La prioridad absoluta del médico de urgencia es descartar hemorragia mediante TAC sin contraste inmediato, estabilizar la presión arterial bajo 185/110 mmHg e iniciar trombolisis intravenosa dentro de 4.5 horas o derivar a trombectomía mecánica en oclusiones de gran vaso.

PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **3–8, 37** (págs. 10–11, 15) · solucionario págs. 23–25, 30.

Clase 10.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR Y URGENCIAS NEUROVASCULARES

10.2 Ataque Isquémico Transitorio (AIT): Score ABCD2, Estratificación de Riesgo Precoz y Prevención Secundaria

★★★ PRIORIDAD ALTA
16 preguntas reales 2013–2025

1.10.2.007 **Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)** Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Prevención de factores de riesgo cerebrovascular · Insuficiencia cerebro vascular · Embolia cardiogénica

LO QUE TE PREGUNTAN

- Un AIT se define actualmente por la ausencia de infarto en la neuroimagen (definición tisular); la persistencia de lesión en la RM reclasifica el caso como infarto cerebral.
- La mitad de los infartos que siguen a un AIT ocurren dentro de las primeras **48 horas**: el AIT es una urgencia médica absoluta.
- **El Score ABCD² estratifica el riesgo a corto plazo**: A (edad **≥ 60**: 1), B (PA **≥ 140**/90: 1), C (paresia unilateral: 2; habla sola: 1), D (duración **≥ 60 min**: 2; **10-59 min**: 1), D (diabetes: 1).
- Puntaje ABCD² **≥ 4 puntos** indica hospitalización inmediata obligatoria en una unidad de observación o UTAC.
- En AIT de alto riesgo no cardioembólico, la indicación de elección es doble antiagregación con AAS + Clopidogrel iniciada precozmente y mantenida por exactamente **21 días**.

ALGORITMO · ATAQUE ISQUÉMICO TRANSITORIO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

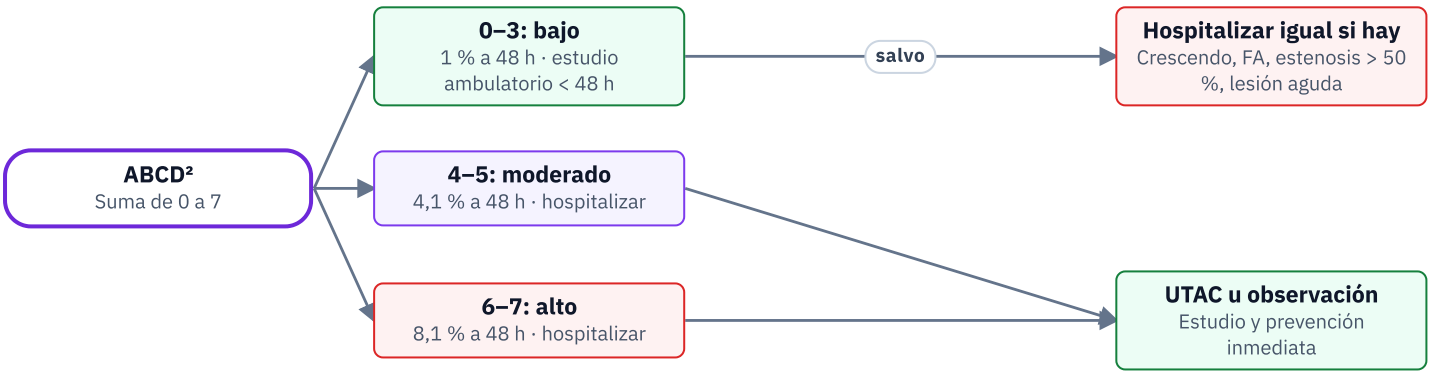


TABLA 10.2 · SCORE ABCD²: PUNTUACIÓN, ESTIMACIÓN DE RIESGO DE ACV A 48 H Y CONDUCTA CLÍNICA

FACTOR DE RIESGO	CRITERIO CLÍNICO EVALUADO	PUNTAJE ASIGNADO	RIESGO ACV A 48 H	CONDUCTA ASISTENCIAL OBLIGATORIA
Age (Edad)	Edad ≥ 60 años	1 punto	Bajo (0 – 3 pts): 1.0%	Estudio ambulatorio monitorizado en < 48 h (si no hay AIT en crescendo)
Blood Pressure	Presión arterial ≥ 140/90 mmHg	1 punto	Moderado (4 – 5 pts): 4.1%	Hospitalización inmediata en UTAC / camas de observación médica
Clinical Features	Hemiparesia o debilidad unilateral	2 puntos	Alto (6 – 7 pts): 8.1%	Hospitalización en UTAC + DAPT inmediata (AAS + Clopidogrel x 21 días)
Clinical Features	Alteración del habla sin debilidad motora	1 punto	Alto (con estenosis carotídea): > 15%	Hospitalización prioritaria + AngioTAC / Dúplex carotídeo de urgencia
Duration	Duración del déficit ≥ 60 minutos	2 puntos	Alto (con FA asociada): > 10%	Hospitalización inmediata + ECG continuo / Telemetría por 24-48 horas
Duration	Duración del déficit entre 10 y 59 minutos	1 punto	—	—
Diabetes	Diagnóstico previo de Diabetes Mellitus	1 punto	—	Iniciar Atorvastatina 80 mg/día de alta intensidad a permanencia

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
AIT resuelto, examen normal	Calcular ABCD² y estudiar en < 48 h	Alta con control ambulatorio
ABCD² ≥ 4	Hospitalizar en UTAC u observación	Estudio ambulatorio

REGLA DE ORO **AIT = sin infarto en la imagen** — Difusión positiva: es un infarto

PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **9–10** (pág. 11) · solucionario pág. 25.

Clase 10.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR Y URGENCIAS NEUROVASCULARES

10.3 Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos

★★★ PRIORIDAD ALTA
15 preguntas reales 2013–2025

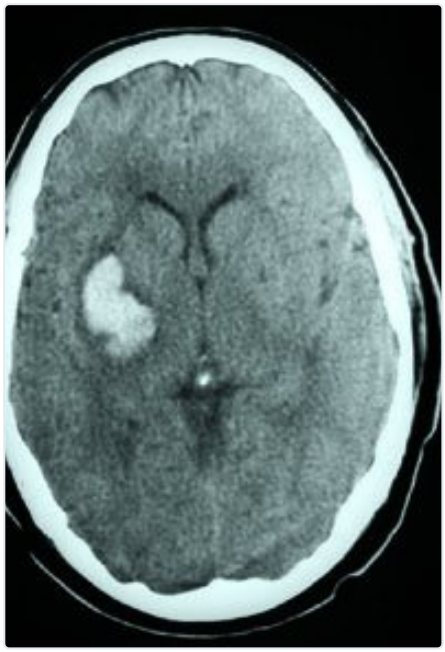
Muy Alta · Emergencia neurovascular crítica con toma de decisiones terapéuticas de minutos

1.10.2.007 **Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)** Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Hipertensión endocraneana · TAC de encefalo y columna

LO QUE TE PREGUNTAN

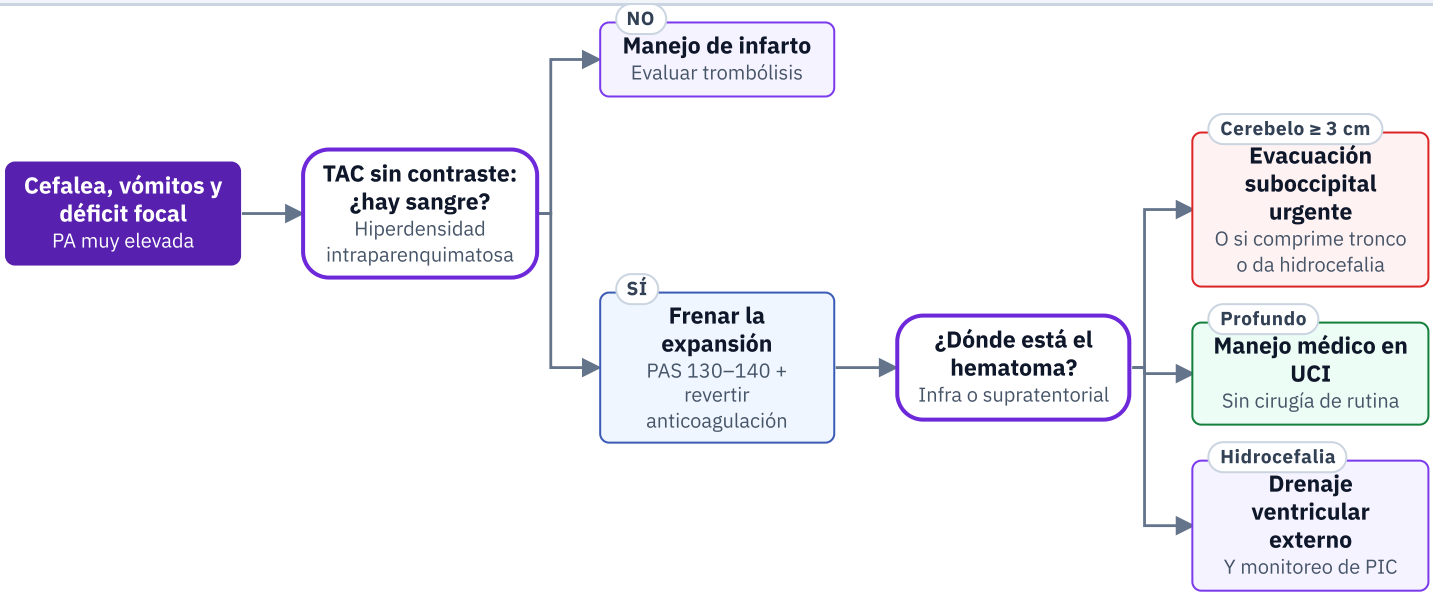
- La hemorragia intracerebral hipertensiva compromete predominantemente ganglios basales (putamen), tálamo, protuberancia y cerebelo.
- La angiopatía amiloide cerebral afecta a ancianos y produce hemorragias lobares (corticales/subcorticales) recidivantes.
- En la fase hiperaguda con PAS entre 150 y **220 mmHg**, la meta es reducir la PAS de forma suave pero rápida a **130-140 mmHg**; caídas < **130 mmHg** aumentan el daño renal y la isquemia cerebral.
- Ante una HIE bajo antagonistas de la vitamina K (acenocumarol), la reversión de primera línea es Complejo Protrombínico Concentrado (CCP 4F) + Vitamina K1 EV.
- **El plasma fresco congelado es muy inferior al CCP**: demora horas en infundirse, no normaliza rápidamente el INR y produce sobrecarga de volumen.
- Todo hematoma cerebeloso de diámetro **≥ 3 cm** o con compresión de troncoencefálico/hidrocefalia requiere evacuación quirúrgica suboccipital urgente obligatoria.
- La cirugía abierta de hematomas profundos (putaminales/talámicos) no demostró mejoría funcional frente al manejo médico intensivo en UCI.



HEMATOMA PROFUNDO
Manual CTO Neurología 14.ª ed., p. 42

ALGORITMO · HEMORRAGIA INTRACEREBRAL ESPONTÁNEA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **1, 11–15** (págs. 10–12) · solucionario págs. 23, 26–27.

Clase 10.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR Y URGENCIAS NEUROVASCULARES

10.3 Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★★ PRIORIDAD ALTA

TABLA 10.3 · SÍNDROMES CLÍNICOS TOPOGRÁFICOS EN HEMORRAGIA INTRACEREBRAL ESPONTÁNEA

TOPOGRAFÍA DE LA HIE	VASOS SANGRANTES	MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS CARDINALES	SIGNOS PUPILAR / OCULARES PATOGNOMÓNICOS
Putaminal (Ganglios Basales, 50%)	Ramas lenticuloestriadas profundas de la ACM	Hemiplejia faciobraquiocrural contralateral armónica · Hemihipoestesia contralateral · Afasia o hemiinatención	Desviación oculocefálica conjugada hacia la lesión ("mira la lesión") · Pupilas normales reactivas
Talámica (15 – 20%)	Ramas tálamo-perforantes y lenticuloópticas de la ACP	Hemihipoestesia profunda contralateral (predomina sobre déficit motor) · Dolor talámico crónico secundario	Ojos desviados hacia abajo y adentro ("miran la nariz") · Parálisis de la mirada vertical (Parinaud) · Pupilas mióticas arreactivas
Protuberancial / Pontina (10 – 15%)	Ramas perforantes mediales de la arteria basilar	Coma súbito precoz · Tetraparesia flácida o descerebración temprana · Paro respiratorio · Hipertermia maligna	Pupilas puntiformes (miosis extrema pero reactiva a la luz) · Ausencia de reflejos oculocefálicos/vestibulares
Cerebelosa (10%)	Arterias cerebelosas (PICA, AICA o cerebelosa superior)	Cefalea occipital súbita · Vértigo severo, vómitos explosivos · Ataxia ipsilateral e incapacidad para bipedestación	Nistagmo horizontal · Inicialmente SIN hemiparesia de extremidades · Pupilas normales hasta herniación
Lobar (Cortical/Subcortical, 15-20%)	Vasos corticales debilitados por Angiopatía Amiloide Cerebral (AAC)	Déficit focal restringido al lóbulo afectado (afasia en lóbulo temporal/frontal; hemianopsia en occipital)	Crisis epilépticas focales o generalizadas de inicio temprano · Cefalea localizada ipsilateral

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Hemorragia con PAS 150–220	Bajar a PAS 130–140 con labetalol o nicardipino EV	Tolerar hasta 220 como en el infarto
Descenso de presión	Suave y sostenido, nunca bajo 130	Caídas bruscas o nitroprusiato
Hemorragia con acenocumarol	CCP 4 factores + vitamina K EV	Plasma fresco de primera línea, o vitamina K sola

REGLA DE ORO **Profunda: HTA · lobar en anciano: amiloide** — Joven: buscar MAV o drogas

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La hemorragia intracerebral espontánea (HIE) representa el 15-20% de todos los ictus, pero concentra más del 50% de la mortalidad neurovascular. A diferencia del infarto isquémico, en la hemorragia el hematoma tiende a expandirse activamente en las primeras 3 a 6 horas. El éxito terapéutico descansa en dos medidas médicas impostergables de minutos: el control intensivo y seguro de la presión arterial (meta PAS 130-140 mmHg) y la reversión ultraprecoz de la anticoagulación previa, sumado a la identificación de hematomas cerebelosos tributarios de evacuación quirúrgica urgente.

PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **1, 11–15** (págs. 10–12) · solucionario págs. 23, 26–27.

Clase 10.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR Y URGENCIAS NEUROVASCULARES

10.4 Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino

★★☆ **PRIORIDAD MEDIA**
4 preguntas reales 2013–2025

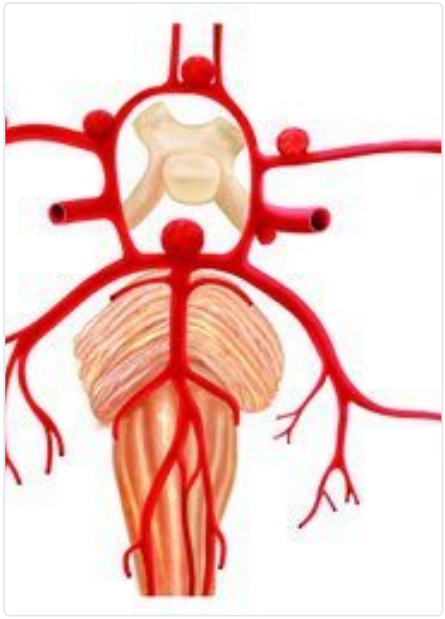
Máxima rentabilidad · Pregunta clásica de cefalea en trueno, análisis de LCR y manejo de complicaciones en UTI

1.10.2.008 **Hemorragia subaracnoídea** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

También: Cefalea aguda en urgencia · Punción lumbar · Examen de líquido cefaloraquídeo (citoquímico, bacteriológico) · Angiografía · Parálisis III par + midriasis

LO QUE TE PREGUNTAN

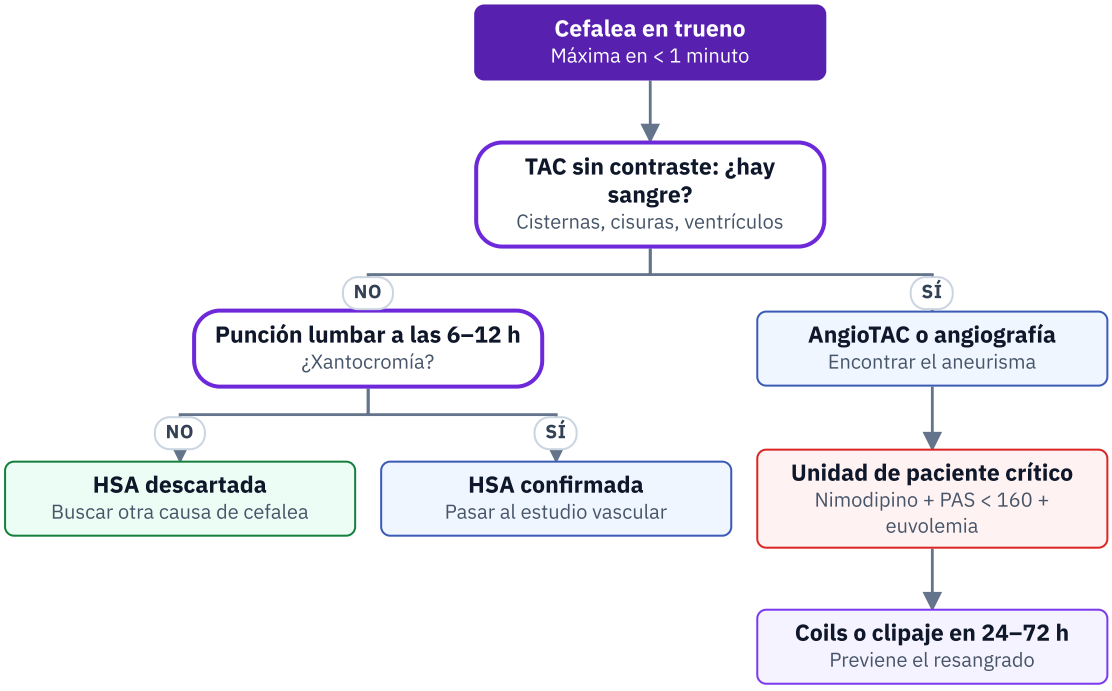
- Toda cefalea en trueno ("la peor de mi vida", con acmé en < **1 minuto**) es una sospecha formal de hemorragia subaracnoidea hasta demostrar lo contrario.
- El estudio inicial mandatario es un TAC de encéfalo sin contraste inmediato (sensibilidad > **98%** en las primeras **6 horas**).
- Si el TAC de cerebro es normal pero la sospecha de HSA persiste, la Punción Lumbar diagnóstica es OBLIGATORIA (buscar xantocromía tras **6-12 horas**).
- La parálisis aislada del III par craneal (midriasis + ptosis + oftalmoplejia) sugiere compresión por aneurisma de la arteria comunicante posterior.
- El resangrado aneurismático es la complicación más letal de las primeras **24 horas**; se previene con la exclusión precoz del aneurisma (coils o clipaje) en **≤ 24-72 horas**.
- El vasoespasmo e isquemia cerebral tardía ocurren típicamente entre los días 4 y 14 post-HSA; se previenen con Nimodipino oral (**60 mg** c/**4h** x **21 días**) y euvolemia estricta.
- La escala de Fisher modificada predice el riesgo de vasoespasmo según la cantidad de sangre subaracnoidea e intraventricular en el TAC.



LOCALIZACIÓN DE ANEURISMAS
Manual CTO Neurología 14.ª ed., p. 43

ALGORITMO · HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA ANEURISMÁTICA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **16–17** (pág. 12) · solucionario pág. 27.

Clase 10.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR Y URGENCIAS NEUROVASCULARES

10.4 Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino

PRIORIDAD MEDIA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 10.4 · ESCALAS PRONÓSTICAS EN HSA: ESCALA CLÍNICA DE HUNT & HESS VS ESCALA TOMOGRÁFICA DE FISHER

GRADO / ESCALA	HUNT & HESS (ESTADO CLÍNICO BASAL)	FISHER MODIFICADA (HALLAZGOS EN TAC)	RIESGO / IMPLICANCIA CLÍNICA
Grado I	Asintomático o cefalea leve con rigidez de nuca mínima	HSA focal o difusa fina < 1 mm de espesor, sin HIV	Excelente pronóstico quirúrgico; mortalidad < 5%
Grado II	Cefalea moderada a severa, rigidez marcada, sin focalidad (salvo par craneal)	HSA fina < 1 mm con hemorragia intraventricular bilateral (HIV)	Bajo riesgo de vasoespasmo en Fisher 1; moderado en Fisher 2
Grado III	Somnolencia, confusión o leve déficit focal motor/sensitivo	Coágulo grueso subaracnoideo > 1 mm de espesor, sin HIV	Riesgo elevado de vasoespasmo sintomático en Fisher 3
Grado IV	Estupor, hemiparesia moderada a severa, signos de rigidez vegetativa	Coágulo grueso subaracnoideo > 1 mm CON hemorragia intraventricular (HIV)	Riesgo MÁXIMO de vasoespasmo e isquemia tardía; mortalidad > 40%
Grado V	Coma profundo, rigidez de descerebración, apariencia moribunda	—	Mortalidad superior al 70-80%; rescate neuroquirúrgico urgente

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Cefalea en trueno	TAC sin contraste inmediato	Analgesia o triptán y alta
Cefalea en trueno, TAC normal	Punción lumbar a las 6–12 h	Alta porque el TAC salió normal
Sin signos meníngeos en la 1ª hora	No descarta HSA	Descartarla por el examen

REGLA DE ORO **Cefalea en trueno: TAC sin contraste** — Signos meníngeos tardan 6–12 h

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La hemorragia subaracnoidea aneurismática (HSA) es una de las emergencias médicas más temidas y evaluadas en el EUNACOM. El 85% se debe a la rotura de aneurismas saculares en las bifurcaciones del polígono de Willis. La regla diagnóstica de oro es inviolable: ante toda cefalea en trueno ("la peor de mi vida"), el primer paso es un TAC de encéfalo sin contraste inmediato; si el TAC es normal, es mandatorio realizar una punción lumbar para confirmar o descartar xantocromía. El pronóstico depende del aseguramiento precoz del aneurisma y de la prevención del vasoespasmo con Nimodipino.

PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **16–17** (pág. 12) · solucionario pág. 27.

Clase 10.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR Y URGENCIAS NEUROVASCULARES

10.5 Trombosis Venosa Cerebral: Factores Protrombóticos, Sospecha Clínica, Neuroimagen y Anticoagulación Plena

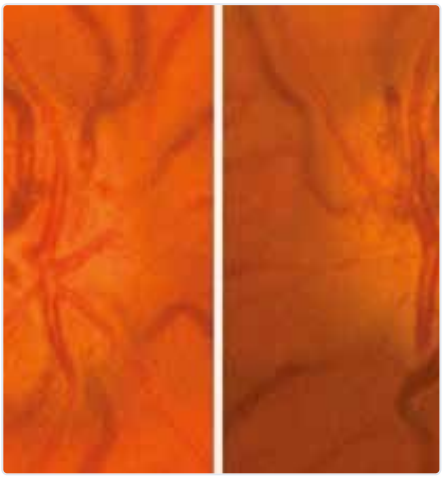
★★★ PRIORIDAD ALTA
16 preguntas reales 2013–2025

1.10.2.007 **Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)** Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Síndrome de hipertensión endocraneana · Resonancia magnética de encéfalo y columna

LO QUE TE PREGUNTAN

- La trombosis venosa cerebral afecta con mayor frecuencia a mujeres jóvenes en edad fértil con factores protrombóticos (ACO, puerperio, embarazo, SAF).
- **La cefalea es el síntoma cardinal en más del 90% de los casos**: típicamente progresiva, rebelde a analgésicos y empeora en decúbito supino.
- Las crisis convulsivas (focales o generalizadas) ocurren en el **35-40%** de los pacientes, una frecuencia sustancialmente mayor que en el ACV isquémico arterial.
- El examen diagnóstico de elección no invasivo es la Angio-Resonancia Magnética venosa (secuencia TOF venosa) o la AngioTAC en fase venosa.
- El signo del delta vacío en el TAC contrastado corresponde al trombo intraluminal rodeado de realce dural en el seno sagital superior.
- **Regla de Oro EUNACOM**: El tratamiento de elección es la Anticoagulación Plena Inmediata con Heparina de Bajo Peso Molecular (Enoxaparina **1 mg/kg** c/**12h** SC).



PAPILEDEMA
Manual CTO Oftalmología 14.ª ed., p. 88

ALGORITMO · TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 10.5 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL VS ACV ISQUÉMICO ARTERIAL VS HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL IDIOPÁTICA

CARACTERÍSTICA CLÍNICA / DIAGNÓSTICA	TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL (TVC)	ACV ISQUÉMICO ARTERIAL CLÁSICO	HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL IDIOPÁTICA (PSEUDOTUMOR)
Perfil Epidemiológico Típico	Mujer joven (20 – 45 años) con ACO, puerperio, embarazo o SAF	Adulto mayor (> 60 años) con factores aterotrombóticos (HTA, DM, FA, tabaquismo)	Mujer joven con obesidad o sobrepeso, sin factores trombóticos específicos
Forma de Instalación Temporal	Progresiva y subaguda (días a semanas); cefalea insidiosa en crescendo	Súbita e hiperaguda (segundos a minutos); déficit máximo desde el inicio	Crónica y progresiva (semanas a meses); cefalea matinal continua
Síntomas Cardinales Asociados	Cefalea gravativa que empeora en decúbito supino + Papiledema + Convulsiones (40%)	Déficit focal motor/sensitivo estricto a un territorio arterial · Convulsiones infrecuentes (< 5%)	Cefalea + Papiledema bilateral + Tinnitus pulsátil · SIN déficit focal (salvo paresia del VI par)
Hallazgos en Neuroimagen	Signo del delta vacío en AngioTAC venoso · Ausencia de flujo en Angio-RM · Infartos hemorrágicos atípicos	Hipodensidad delimitada estrictamente a territorio vascular arterial (ACM, ACA, ACP)	Ventrículos pequeños, silla turca vacía, distensión de vainas del nervio óptico · Senos venosos permeables
Tratamiento de Elección Inmediato	Anticoagulación parenteral plena (HBPM Enoxaparina 1 mg/kg c/12h SC) obligatoria	Reperfusión (Trombolisis IV si ≤ 4.5 h / Trombectomía si ≤ 24 h) o Antiagregación	Punción lumbar evacuadora diagnóstica/terapéutica · Acetazolamida · Pérdida ponderal

REGLA DE ORO **Mujer joven con ACO, embarazo o puerperio** — Cefalea progresiva + HTEC + convulsiones

PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, pregunta **18** (pág. 12) · solucionario pág. 27.

Clase 10.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · CEFALEAS, SÍNDROMES CONVULSIVOS Y EPILEPSIA

10.6 Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional

PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

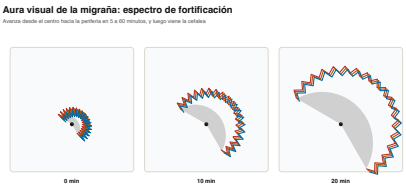
Máxima rentabilidad · Motivo de consulta neurológica ambulatoria N° 1 en población joven y mujeres en edad fértil

1.10.1.012 Migraña — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Cefalea tensional · Cefalea aguda en urgencia · Cefalea · Hipertensión endocraneana · Status migrañoso

LO QUE TE PREGUNTAN

- El diagnóstico de migraña y cefalea tensional es eminentemente clínico; en ausencia de banderas rojas (regla SNOOP10), la neuroimagen de rutina no está indicada.
- La migraña sin aura requiere al menos 5 crisis de **4 a 72 horas** de dolor pulsátil unilateral moderado-severo que empeora con el ejercicio y asocia náuseas o foto/fonofobia.
- La cefalea tensional es bilateral, opresiva ("en banda o casco"), leve-moderada, no empeora con la actividad rutinaria y NUNCA cursa con náuseas ni vómitos.
- Los triptanes (agonistas 5-HT 1B/1D) son el tratamiento abortivo de elección en crisis moderadas a severas, pero están estrictamente contraindicados en cardiopatía coronaria, ACV previo e HTA descontrolada.
- La profilaxis farmacológica está indicada con **≥ 3**-4 crisis mensuales o dolor discapacitante: Propranolol (primera línea general), Flunarizina (vértigo), Topiramato (obesidad) o Amitriptilina (insomnio/dolor miofascial).
- Para evitar la cefalea por sobreuso de medicamentos (MOH), el uso de AINEs debe limitarse a menos de **15 días** al mes y el de triptanes o combinados a menos de **10 días** al mes.



ESPECTRO DE FORTIFICACIÓN
Dibujo propio (esquema)

ALGORITMO · MIGRAÑA Y CEFALEA TENSIONAL

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

S · Sistémico Fiebre, baja de peso, cáncer, VIH	**Imagen con contraste + PL** Meningitis, absceso, metástasis
N · Neurológico Déficit focal, conciencia, crisis	**TAC sin contraste urgente** ACV, hematoma, masa
O · Onset: en trueno Máximo en menos de 1 minuto	**TAC; si es normal, PL** Hemorragia subaracnoidea
O · Older: mayor de 50 Cefalea nueva	**VHS y PCR** Arteritis de la temporal
P · Patrón, posición, papiledema Progresiva, Valsalva, ortostática	**Fondo de ojo y RM** HTEC, fístula de LCR, TVC

PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **22–30** (págs. 13–14) · solucionario págs. 28–29.

Clase 10.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · CEFALEAS, SÍNDROMES CONVULSIVOS Y EPILEPSIA

10.6 Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★☆ PRIORIDAD MEDIA

TABLA 10.6 · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS IHS (ICHD-3): MIGRAÑA VS CEFALEA TENSIONAL

CARACTERÍSTICA CLÍNICA	MIGRAÑA SIN AURA (ICHD-3 1.1)	MIGRAÑA CON AURA (ICHD-3 1.2)	CEFALEA TENSIONAL EPISÓDICA (ICHD-3 2.1)
Duración del dolor	4 a 72 horas (sin tratamiento o tratada sin éxito)	Aura de 5 a 60 minutos; cefalea sigue en < 60 min y dura 4-72 h	30 minutos a 7 días continuos
Localización anatómica	Unilateral / Hemicránea en 60-70% (puede ser bilateral)	Unilateral, típicamente contralateral al lado del aura	Bilateral estricta, en banda u holocraneana en casco
Cualidad del dolor	Pulsátil, martillante, latiente	Pulsátil tras resolución del fenómeno focal	Opresiva, pesadez, "como un casco o cinta apretada" (no pulsátil)
Intensidad del dolor	Moderada a severa (impide actividades habituales)	Moderada a severa (incapacitante)	Leve a moderada (permite mantener actividad habitual)
Efecto de la actividad física	Se agrava francamente con caminar o subir escaleras; busca reposo a oscuras	Se intensifica con esfuerzo; paciente encamado inmóvil	NO empeora con la actividad física rutinaria ni el ejercicio leve
Síntomas asociados	Náuseas y/o vómitos frecuentes; fotofobia Y fonofobia simultáneas	Náuseas, fotofobia y fonofobia tras el cese del aura	Sin náuseas ni vómitos; puede haber fotofobia O fonofobia (nunca ambas)
Fenómeno de Aura	Ausente por definición	Presente: escotoma centellante, espectro fortificación, parestesias cheiro-orales	Ausente por definición

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Cefalea típica, examen normal, sin banderas rojas	Diagnóstico clínico	Pedir TAC de rutina
Bilateral opresiva, sin náuseas, no empeora al caminar	Cefalea tensional	Llamarla migraña
Cefalea en trueno con TAC normal	Punción lumbar	Dar de alta con analgesia

REGLA DE ORO **Banderas rojas antes que todo** — Trueno, focalidad, mayor de 50, cambio de patrón

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La migraña y la cefalea tensional representan más del 90% de las consultas ambulatorias por dolor de cabeza en atención primaria. La migraña es una enfermedad neurovascular compleja caracterizada por hiperexcitabilidad cortical y activación del sistema trigéminovascular, con liberación del neuropéptido CGRP. La regla de oro en el EUNACOM radica en saber descartar con rigor las banderas rojas de cefaleas secundarias potencialmente letales mediante la regla SNOOP10 (como la hemorragia subaracnoidea en cefaleas en trueno), seleccionar el tratamiento abortivo escalonado precoz (AINEs vs Triptanes) y prescribir profilaxis oportuna para evitar la cefalea por abuso de medicación.

PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **22–30** (págs. 13–14) · solucionario págs. 28–29.

Clase 10.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · CEFALEAS, SÍNDROMES CONVULSIVOS Y EPILEPSIA

10.7 Cefalea en Racimos (Cluster) y Neuralgia del Trigémino: Diagnóstico Diferencial, Manejo Agudo y Preventivo

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
3 preguntas reales 2013–2025

1.10.1.013 Neuralgia esencial del trigémino — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- La Cefalea en Racimos es una cefalea trigémino-autonómica de predominio en varones jóvenes fumadores, caracterizada por dolor periorbitario unilateral insoportable de **15 a 180 min** con agitación psicomotora.
- El ataque de cluster asocia obligatoriamente signos autonómicos ipsilaterales: inyección conjuntival, lagrimeo, congestión/rinorrea y síndrome de Horner transitorio (ptosis y miosis).
- El tratamiento abortivo de primera línea para el cluster es Oxígeno al **100%** en mascarilla con reservorio a **12-15 L**/min por **15 min** más Sumatriptán **6 mg** subcutáneo; el Verapamilo es la profilaxis de mantenimiento de elección.
- La Neuralgia del Trigémino se caracteriza por paroxismos lancinantes ultra-breves (segundos) en territorio V2-V3, desencadenados por el roce de zonas gatillo cutáneas o mucosas, sin cortejo autonómico.
- El tratamiento médico de primera línea de la Neuralgia del Trigémino es la Carbamazepina (control con hemograma y natremia); la descompresión microvascular de Jannetta es la técnica quirúrgica curativa de elección.

ALGORITMO · CEFALEA EN RACIMOS Y NEURALGIA DEL TRIGÉMINO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

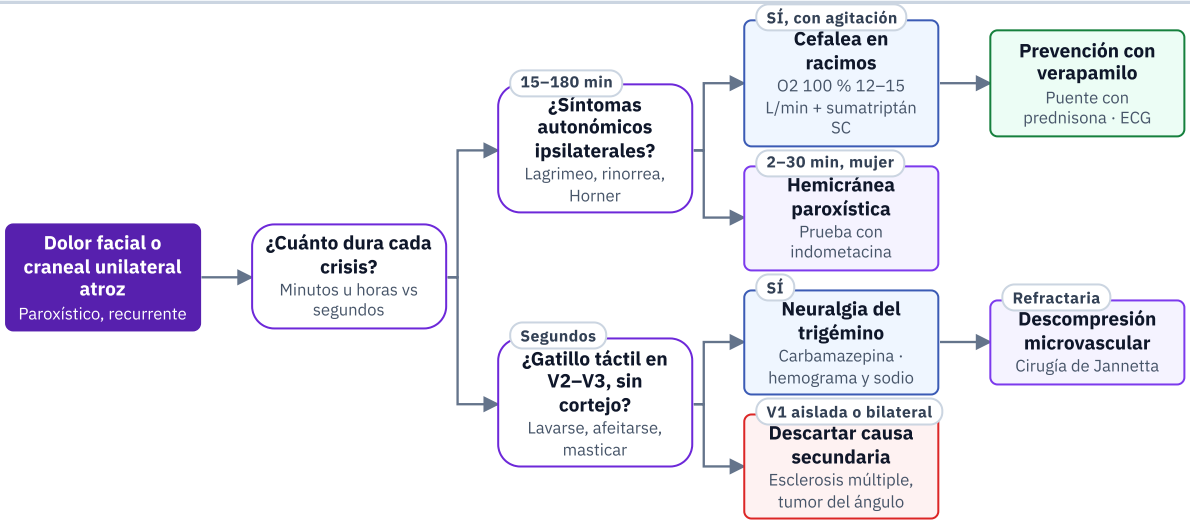


TABLA 10.7 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL INTEGRAL: CEFALEA EN RACIMOS (CLUSTER) VS NEURALGIA DEL TRIGÉMINO

PARÁMETRO CLÍNICO	CEFALEA EN RACIMOS / CLUSTER (ICHD-3 3.1)	NEURALGIA DEL TRIGÉMINO CLÁSICA (ICHD-3 13.1.1)
Demografía y factores de riesgo	Predominio masculino marcado (varones 20-50 años; relación 3-4:1); > 80% fumadores	Predominio femenino (relación 2:1); adultos mayores (> 50-60 años); bilateral en esclerosis múltiple
Duración de cada ataque	15 a 180 minutos de dolor continuo insoportable	Fracciones de segundo a máximo 2 minutos (paroxismos ultra-breves en salvas)
Localización topográfica	Estrictamente unilateral; peri y retroorbitaria, temporal ("detrás del ojo")	Estrictamente unilateral; ramas V2 (maxilar) y/o V3 (mandibular) del trigémino; V1 excepcional (< 5%)
Carácter e intensidad del dolor	Taladrante, penetrante, atroz, continuo ("cefalea suicida")	Punzante, lancinante, como "corriente o choque eléctrico de alto voltaje"
Síntomas autonómicos craneales	OBLIGATORIOS ipsilaterales: ptosis, miosis (Horner transitorio), lagrimeo, inyección conjuntival, rinorrea	AUSENTES; si existen síntomas autonómicos notorios obliga a descartar SUNCT o masa compresiva
Factores gatillantes	Consumo de alcohol (precipita crisis en minutos durante racimo), siestas diurnas	Estímulos táctiles inocuos en zonas gatillo: lavarse cara, afeitarse, cepillarse dientes, masticar, viento

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

PARÁMETRO	CEFALEA EN RACIMOS	NEURALGIA DEL TRIGÉMINO
Gatillante y conducta	Alcohol · agitación	Zonas gatillo · inmovilidad

REGLA DE ORO **Hombre fumador, dolor orbitario nocturno** — 15–180 min, lagrimeo, rinorrea, Horner, agitación

PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **31–32** (pág. 14) · solucionario págs. 29–30.

Clase 10.7 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · CEFALEAS, SÍNDROMES CONVULSIVOS Y EPILEPSIA

10.8 Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES

★★☆ **PRIORIDAD MEDIA**
4 preguntas reales 2013–2025

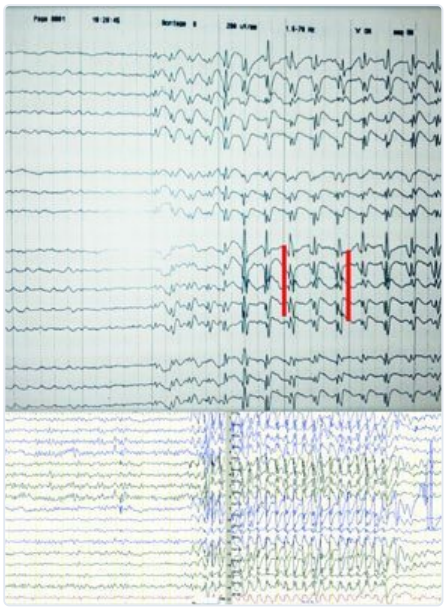
Máxima rentabilidad · Pregunta obligada en todos los exámenes históricos de neurología y medicina interna

1.10.1.007 **Epilepsia** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Electroencefalograma

LO QUE TE PREGUNTAN

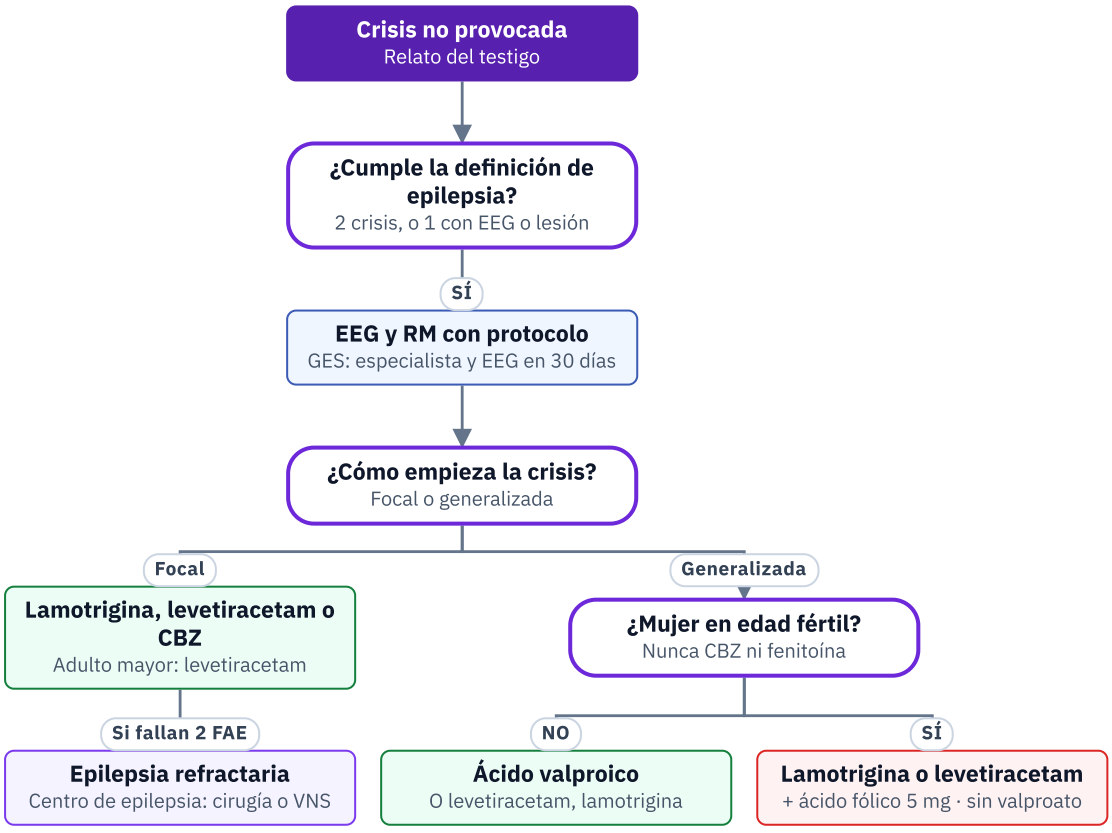
- La ILAE clasifica las crisis según su inicio en Focales (conciencia preservada o alterada) y Generalizadas (motoras y no motoras/ausencias).
- El GES N° 28 garantiza confirmación diagnóstica con especialista y EEG en **≤ 30 días**, y tratamiento farmacológico gratuito de por vida.
- La Lamotrigina y el Levetiracetam son los FAEs de elección en mujeres en edad fértil y embarazo; el Ácido Valproico está formalmente proscrito por teratogenicidad mayor.
- La Carbamazepina y la Fenitoína bloquean canales de sodio de forma estrecha y están contraindicadas en crisis generalizadas idiopáticas (empeoran ausencias y mioclonías).
- El Levetiracetam es ideal en adultos mayores y polimedicados por nula interacción con citocromo P450, pero puede inducir alteraciones psiquiátricas e irritabilidad.
- La epilepsia refractaria se define como la persistencia de crisis tras el ensayo adecuado de 2 FAEs tolerados y apropiados, obligando a derivar a cirugía de epilepsia.



PUNTA ONDA A TRES HERTZ
Manual CTO Neurología 14.ª ed., p. 73

ALGORITMO · EPILEPSIA DEL ADULTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **33–34** (pág. 15) · solucionario pág. 30.

Clase 10.8 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · CEFALEAS, SÍNDROMES CONVULSIVOS Y EPILEPSIA

10.8 Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★☆ PRIORIDAD MEDIA

TABLA 10.8 · CLASIFICACIÓN OPERATIVA ILAE 2017 DE LAS CRISIS EPILÉPTICAS: SEMIOLOGÍA Y CORRELATO NEUROANATÓMICO

CATEGORÍA ILAE	SUBTIPO CLÍNICO	SEMIOLOGÍA CARDINAL Y NIVEL DE CONCIENCIA	HALLAZGOS CLAVE DE EXAMEN / EEG
Inicio Focal: Conciencia Preservada	Focal Motora o Sensitiva (antigua Focal Simple)	Conciencia intacta; interactúa y recuerda. Paroxismos motores clónicos focales (marcha jacksoniana), parestesias o auras	Descargas focales limitadas a corteza somatotópica contralateral
Inicio Focal: Conciencia Alterada	Focal Discognitiva (antigua Focal Compleja)	Desconexión del medio, mirada fija, amnesia del evento y automatismos oromasticatorios (chupeteo) o manuales	Ondas agudas focales de origen temporal anterior o frontobasal
Inicio Focal con progresión Bilateral	Focal a Tónico-Clónica Bilateral	Inicia con semiología focal motora o sensitiva, propagándose rápidamente a contracción tónica y clonías bilaterales	Foco epileptiforme inicial que se propaga y sincroniza bilateralmente
Inicio Generalizado: Motoras Mayores	Tónico-Clónica Generalizada (GTC)	Pérdida brusca de conciencia, grito ictal, fase tónica (10-20 s) con cianosis, fase clónica simétrica (30-60 s) y relajación esfínteres	Paroxismos bilaterales simétricos y sincrónicos de polipunta-onda generalizada
Inicio Generalizado: No Motoras	Crisis de Ausencia Típicas	Detención motora y del habla súbita (5-15 s) con mirada fija; sin caída ni confusión postictal; retoma actividad previa de inmediato	Patognomónico: descargas generalizadas de punta-onda a 3 Hz sincrónicas
Inicio Generalizado: Motoras Breves	Crisis Mioclónicas	Sacudidas musculares bruscas e involuntarias bilaterales breves ("sacudida eléctrica") en brazos, matinales al despertar	Polipunta-onda generalizada; sello de la Epilepsia Mioclónica Juvenil

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Mioclonías matinales + convulsión tras trasnochar	Epilepsia mioclónica juvenil: valproato (hombre)	Carbamazepina
Mujer en edad fértil con epilepsia generalizada	Lamotrigina o levetiracetam + ácido fólico 5 mg	Mantener o iniciar valproato
Adulto mayor polimedicado	Levetiracetam en dosis bajas	Carbamazepina o fenitoína

REGLA DE ORO **2 crisis no provocadas, o 1 con alto riesgo** — EEG normal no descarta · RM busca la causa

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas crónicas más prevalentes en Chile y una patología prioritaria cubierta por las Garantías Explícitas en Salud (GES N° 28). La definición operacional de la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) establece que el diagnóstico se confirma con: 1) Al menos dos crisis no provocadas separadas por más de 24 horas; o 2) Una sola crisis no provocada cuando el riesgo de recurrencia a 10 años es superior al 60% (respaldado por un EEG epileptiforme o una lesión estructural causal en la neuroimagen). El éxito terapéutico exige dominar la clasificación de las crisis (focales vs generalizadas), seleccionar el FAE adecuado y vigilar estrictamente las contraindicaciones críticas, destacando la proscripción absoluta del ácido valproico en mujeres en edad fértil.

PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **33–34** (pág. 15) · solucionario pág. 30.

Clase 10.8 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · CEFALEAS, SÍNDROMES CONVULSIVOS Y EPILEPSIA

10.9 Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo

★☆☆
PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

Máxima rentabilidad clínica · Emergencia médica tiempo-dependiente con elevada morbimortalidad neuronal y sistémica

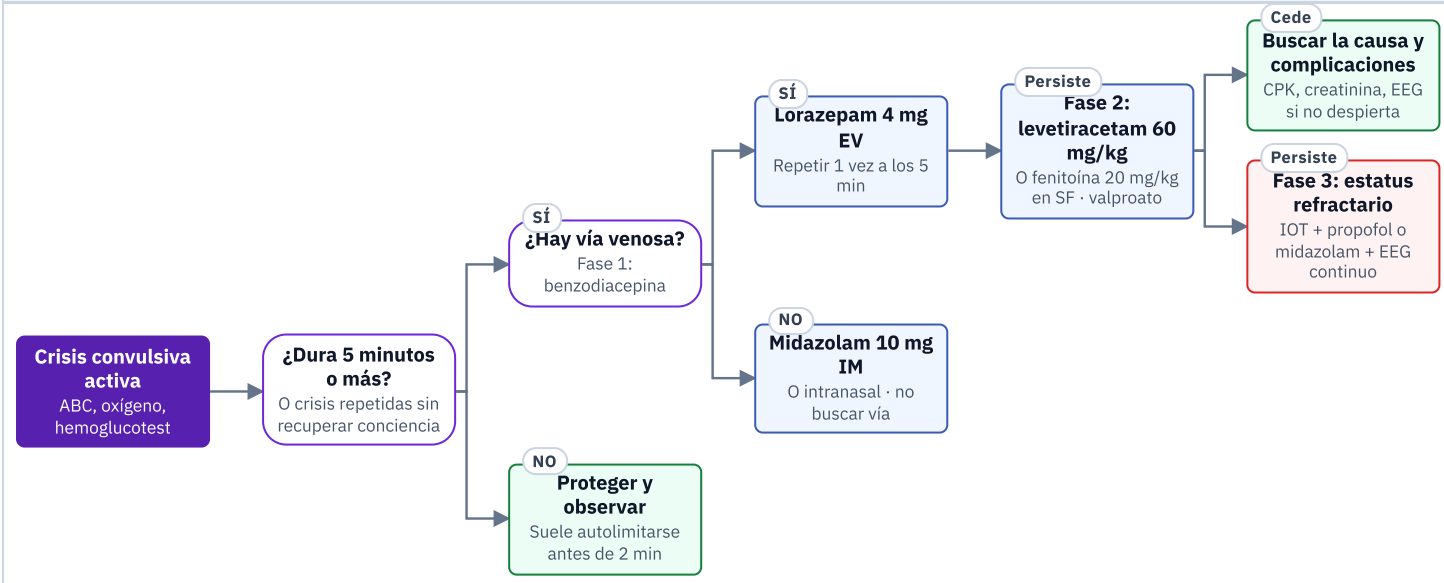
1.10.2.017 **Status convulsivo** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Crisis convulsiva · Estatus convulsivo en el niño

LO QUE TE PREGUNTAN

- El status epiléptico convulsivo generalizado se define operacionalmente como una crisis de **≥ 5 minutos** (t1: momento de rescate obligado) o crisis repetidas sin recuperación de conciencia entre ellas.
- A los **30 minutos** (t2) se produce necrosis neuronal irreversible por excitotoxicidad mediada por glutamato y falla de autorregulación cerebral.
- **Fase 1 (0 a 10 min)**: Lorazepam **4 mg** EV (o Midazolam **10 mg** IM si no hay vía venosa) administrado precozmente; repetir una sola vez a los **5 minutos** si persiste.
- **Fase 2 (10 a 30 min)**: Levetiracetam **60 mg/kg** EV, Fenitoína **20 mg/kg** EV (en suero fisiológico a **≤ 50 mg/min** con monitor ECG) o Ácido Valproico **40 mg/kg** EV.
- **Fase 3 (> 30 min - Status Refractario)**: Intubación orotraqueal inmediata, inducción de coma anestésico con Propofol o Midazolam y monitorización EEG continua en UCI con meta de supresión de brotes.
- La complicación sistémica renal más frecuente es la rabdomiolisis con falla renal aguda por mioglobinuria, requiriendo hidratación masiva y control seriado de CPK y creatinina.

ALGORITMO · ESTATUS EPILÉPTICO CONVULSIVO



PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **20, 35–36** (págs. 13, 15) · solucionario págs. 28, 30.

Clase 10.9 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · CEFALEAS, SÍNDROMES CONVULSIVOS Y EPILEPSIA

10.9 Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo

PRIORIDAD BAJA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 10.9 · DEFINICIONES OPERATIVAS ILAE 2015 DEL STATUS EPILÉPTICO: TIEMPOS CRÍTICOS T1 Y T2

TIPO DE STATUS EPILÉPTICO	TIEMPO T1 (INICIO DE TRATAMIENTO INMEDIATO)	TIEMPO T2 (INICIO DE DAÑO NEURONAL IRREVERSIBLE)	MECANISMO FISIOPATOLÓGICO Y RIESGO BIOLÓGICO
Status Convulsivo Tónico-Clónico Generalizado	5 minutos	30 minutos	Fracaso de la terminación espontánea; internalización de receptores GABA-A. A los 30 min: excitotoxicidad por glutamato, necrosis neuronal irreversible, rabdomiolisis y acidosis.
Status Focal con Alteración de Conciencia	10 minutos	> 60 minutos	Descargas focales continuas temporales o frontales con desconexión. Riesgo de secuelas cognitivas y lesión mesial hipocámpica a largo plazo.
Status de Ausencia	10 a 15 minutos	Indeterminado (sin lesión neuronal letal demostrada)	Estado crepuscular continuo con punta-onda a 3 Hz generalizada en EEG. No produce necrosis neuronal pero requiere reversión farmacológica con benzodiacepinas.

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Crisis activa de 5 minutos o más	Benzodiacepina de inmediato	Esperar a que ceda sola
Estatus sin vía venosa	Midazolam 10 mg IM	Retrasar el fármaco buscando vía
Primer fármaco del estatus	Lorazepam EV	Fenitoína o valproato de entrada

REGLA DE ORO **5 minutos: tratar ya** — O crisis repetidas sin recuperar conciencia

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El status epiléptico convulsivo es una de las emergencias neurológicas más letales y tiempo-dependientes de la medicina interna y la urgencia. La ILAE 2015 estableció las definiciones operativas de tiempo: t1 (5 minutos), momento en el cual una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada se torna anormalmente prolongada y debe iniciarse tratamiento farmacológico de rescate de inmediato; y t2 (30 minutos), momento a partir del cual se produce daño neuronal irreversible por excitotoxicidad y complicaciones sistémicas catastróficas (rabdomiolisis, falla renal aguda, acidosis láctica e hipertermia maligna). El pronóstico funcional y vital del paciente depende directamente de la rapidez con que se aplique el protocolo escalonado por fases.

PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **20, 35–36** (págs. 13, 15) · solucionario págs. 28, 30.

Clase 10.9 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · CEFALEAS, SÍNDROMES CONVULSIVOS Y EPILEPSIA

10.10 Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
5 preguntas reales 2013–2025

1.10.2.003 Crisis convulsiva — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Síndromes convulsivos sintomáticos (traumático, por tumores del sistema nervioso central, metabólico, urémico, etc) · Epilepsia · Electroencefalograma · Síncope · Muerte súbita-ALTE, BRUE · Síndromes convulsivos sintomáticos (traumático, tumores SNC, metabólico, etc)

LO QUE TE PREGUNTAN

- El diagnóstico diferencial entre síncope y crisis epiléptica se basa en la anamnesis a testigos presenciales: pródromos, movimientos motores y período postictal.
- La mordedura profunda en el borde lateral de la lengua y la confusión postictal prolongada (**15-60 min**) son altamente específicas y patognomónicas de crisis epiléptica.
- El síncope convulsivo cursa con mioclonías asincrónicas breves (< 15 s) por hipoxia de tronco encefálico y recuperación de conciencia inmediata y lúcida sin postictal.
- Las crisis sintomáticas agudas provocadas (por hipoglicemia, hiponatremia, abstinencia alcohólica o ACV agudo) no constituyen epilepsia y no requieren FAEs a permanencia.

ALGORITMO · PRIMERA PÉRDIDA DE CONCIENCIA CON MOVIMIENTOS

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

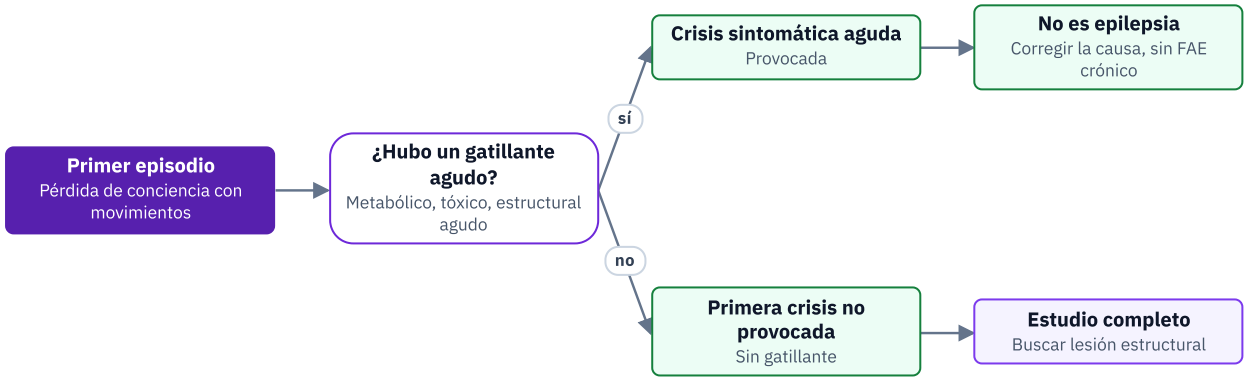


TABLA 10.10 · TABLA DIAGNÓSTICA COMPARATIVA: SÍNCOPE (VASOVAGAL / CARDIOGÉNICO) VS CRISIS EPILÉPTICA CONVULSIVA

PARÁMETRO SEMIOLÓGICO	SÍNCOPE VASOVAGAL / REFLEJO	SÍNCOPE CARDIOGÉNICO / ARRÍTMICO	CRISIS EPILÉPTICA CONVULSIVA (TÓNICO-CLÓNICA)
Factores desencadenantes	Bipedestación prolongada, calor ambiental, estrés emocional, aglomeraciones, fobia a agujas/sangre	Esfuerzo físico súbito, palpitaciones previas, cambios posturales bruscos o sin pródromos	Privación de sueño, consumo/abstinencia de alcohol o drogas, fotoestimulación, o sin gatillante (espontáneo)
Pródromos autonómicos	Presentes y graduales (segundos a minutos): mareo, visión borrosa en túnel, diaforesis fría, palidez	Breves (< 3-5 segundos) o ausentes ("apagón súbito" o caída en plomo instantánea)	Presentes en inicio focal (aura epigástrica ascendente, deja vu, parestesias); ausentes en inicio generalizado
Duración de la inconsciencia	Muy breve: < 15 a 30 segundos (rara vez > 1 minuto tras decúbito supino)	Extremadamente breve (segundos a 1 min), con colapso cardiovascular inmediato	Prolongada: típicamente 1 a 3 minutos continuos de actividad ictal motora
Movimientos motores anormales	Mioclonías sincopales breves: sacudidas asincrónicas, arrítmicas, inician TRAS el colapso (< 15 s)	Ausentes o mioclonías anóxicas breves por hipoperfusión cerebral difusa	Secuencia estereotipada: Fase tónica generalizada (10-20 s) seguida de clonías rítmicas sincrónicas (30-60 s)
Mordedura de lengua	Poco común; si ocurre, se localiza invariablemente en la PUNTA de la lengua por traumatismo al caer	Rara; en la punta si hay traumatismo facial por impacto de la caída	PATOGNOMÓNICA y profunda en el BORDE LATERAL de la lengua (contracción del pterigoideo)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Sacudidas breves tras desmayo con pródromos	Síncope convulsivo: educar	Llamarlo epilepsia e iniciar FAE

REGLA DE ORO **Síncope: pródromos y recuperación lúcida** — Mioclonías breves no son epilepsia

PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, pregunta **21** (pág. 13) · solucionario pág. 28.

Clase 10.10 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

10.11 Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras

★★★ PRIORIDAD ALTA
9 preguntas reales 2013–2025

Máxima rentabilidad · Pregunta angular de trastornos del movimiento y neurología ambulatoria

1.10.1.006 **Enfermedad de Parkinson y parkinsonismos** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

También: Trastornos del sueño

LO QUE TE PREGUNTAN

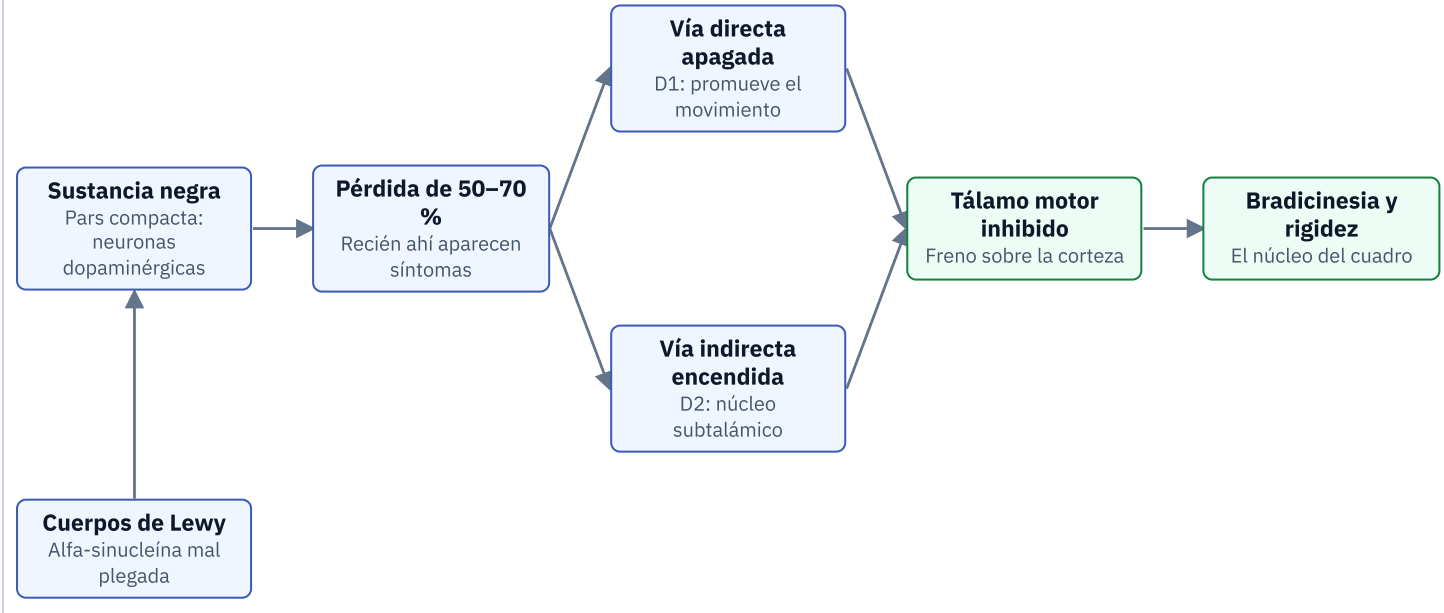
- El diagnóstico de la Enfermedad de Parkinson es estrictamente clínico: requiere la presencia obligatoria de Bradicinesia sumada a Temblor de Reposo (4-6 Hz) y/o Rigidez en rueda dentada.
- El temblor parkinsoniano característico es de reposo, asimétrico al inicio ("cuenta monedas") y disminuye o desaparece transitoriamente con el movimiento voluntario.
- Los síntomas no motores premotores (hiposmia, trastorno conductual del sueño REM y constipación severa) preceden por años o décadas al inicio de las manifestaciones motoras.
- La presencia de caídas tempranas (< **3 años**), parálisis de la mirada vertical hacia abajo o disautonomía severa precoz son banderas rojas que obligan a sospechar síndromes Parkinson-Plus.
- En pacientes mayores de **65-70 años**, el tratamiento de inicio de elección es Levodopa/Carbidopa; en menores de **65 años** se pueden considerar agonistas dopaminérgicos para retrasar fluctuaciones motoras.
- El fenómeno de fin de dosis ("wearing-off") se maneja fraccionando las tomas de Levodopa o asociando un inhibidor de la COMT como Entacapona (**200 mg** con cada toma).



MICROGRAFÍA
Dibujo propio (esquema)

ALGORITMO · ENFERMEDAD DE PARKINSON

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **40–45** (pág. 16) · solucionario págs. 31–32.

Clase 10.11 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

10.11 Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras

★★★ PRIORIDAD ALTA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 10.11 · TABLA 10.11A: CRITERIOS DIAGNÓSTICOS CARDINALES Y BANDERAS ROJAS MDS

CATEGORÍA DIAGNÓSTICA MDS	MANIFESTACIONES CLÍNICAS ESPECÍFICAS	HALLAZGO SEMIOLÓGICO CLAVE	INTERPRETACIÓN Y CONDUCTA
Bradicinesia (Signo Obligatorio)	Lentitud motora para iniciar y ejecutar movimientos + decremento progresivo	Fatiga y disminución de amplitud en golpeteo de dedos (finger tapping) y pronosupinación	Condición sine qua non para definir síndrome parkinsoniano; si falta, no es Parkinson
Temblor de Reposo Cardinal	Frecuencia de 4 a 6 Hz, característicamente asimétrico al debut	Movimiento en "cuenta monedas" (pill-rolling) en manos; disminuye con la acción voluntaria	Presente en 70-80% de los pacientes; respeta típicamente la cabeza (a diferencia del esencial)
Rigidez en Rueda Dentada	Resistencia plástica involuntaria constante en todo el rango pasivo	Fenómeno de Negro (resaltes sucesivos al combinar rigidez con temblor subclínico)	Afecta flexores y extensores; se incrementa al mover la extremidad contralateral (Froment)
Inestabilidad Postural Tardía	Falla de reflejos posturales con tendencia a la retropulsión / propulsión	Prueba del tirón (pull test) anormal con retropulsión > 2 pasos o caída al suelo	Signo de etapa avanzada en EP; si ocurre en el primer año de evolución, es bandera roja
Criterios de Apoyo (MDS)	Respuesta dramática y sostenida a Levodopa, disquinesias inducidas por L-Dopa	Pérdida asimétrica de braceo, hiposmia objetivada por test olfatorio, trastorno REM (RBD)	Confirman el diagnóstico de Enfermedad de Parkinson Clínicamente Establecida
Banderas Rojas y Exclusión	Caídas tempranas (< 3 años), parálisis de mirada vertical, disautonomía severa precoz	Marcha en silla de ruedas en < 5 años, nula respuesta motora a dosis altas de L-Dopa	Obligan a descartar síndromes Parkinson-Plus (PSP, AMS) o causas secundarias

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Temblor sin bradicinesia	No es Parkinson	Iniciar levodopa
Parkinson en mayor de 65	Levodopa/carbidopa	Agonista dopaminérgico
Ludopatía o compras tras iniciar tratamiento	Sospechar el agonista	Derivar solo a psiquiatría

REGLA DE ORO **Bradicinesia + temblor o rigidez** — Asimétrico al inicio

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La Enfermedad de Parkinson (EP) es la segunda patología neurodegenerativa más frecuente en el adulto mayor tras el Alzheimer y una patología priorizada en Chile mediante la Garantía GES N° 67. El diagnóstico es estrictamente clínico y exige la presencia obligatoria de bradicinesia acompañada de temblor de reposo o rigidez en rueda dentada con asimetría al debut. Reconocer precozmente los síntomas no motores prodrómicos (hiposmia, trastorno conductual del sueño REM y constipación pertinaz), diferenciarla de los parkinsonismos atípicos y dominar el ajuste escalonado de Levodopa frente al desarrollo de fluctuaciones motoras (wearing-off y disquinesias) constituyen competencias médicas esenciales evaluadas de manera constante en el EUNACOM.

PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **40–45** (pág. 16) · solucionario págs. 31–32.

Clase 10.11 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

10.12 Parkinsonismos Secundarios, Farmacológicos y Síndromes Parkinson-Plus

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
7 preguntas reales 2013–2025

1.10.1.006 **Enfermedad de Parkinson y parkinsonismos** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

También: Movimientos anormales inducidos por fármacos

LO QUE TE PREGUNTAN

- El parkinsonismo inducido por fármacos es la causa más común de parkinsonismo secundario y se caracteriza por debut subagudo, rigidez y bradicinesia bilaterales y simétricas.
- Los fármacos más frecuentemente implicados en la clínica chilena son Metoclopramida, Sulpirida, Haloperidol, Risperidona y los vasodilatadores Cinarizina y Flunarizina.
- La Parálisis Supranuclear Progresiva (PSP) se reconoce por la tríada de parálisis de la mirada vertical hacia abajo, caídas precoces hacia atrás en el primer año y rigidez axial.
- La Atrofia Multisistémica (AMS) cursa con disautonomía severa precoz (hipotensión ortostática grave, vejiga neurogénica), estridor laríngeo nocturno y signos cerebelosos o parkinsonianos refractarios.

ALGORITMO · PARKINSONISMO: IDIOPÁTICO, FARMACOLÓGICO O ATÍPICO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

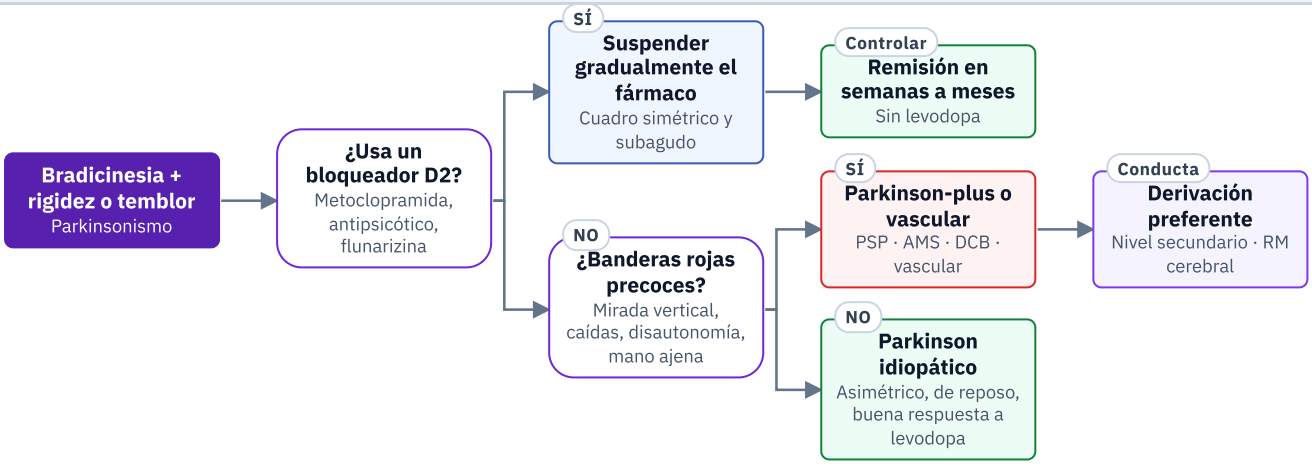


TABLA 10.12 · TABLA 10.12: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE PARKINSONISMOS SECUNDARIOS, FARMACOLÓGICOS Y PARKINSON-PLUS

ENTIDAD CLÍNICA	ETIOLOGÍA / MECANISMO	PRESENTACIÓN MOTORA CARDINAL	BANDERAS ROJAS Y SIGNOS ESPECÍFICOS	RESPUESTA A L-DOPA
Parkinson Inducido por Fármacos	Bloqueo D2 estriatal (Metoclopramida, Haloperidol, Flunarizina, Risperidona)	Bilateral, rigidez y bradicinesia simétricas; temblor postural/acción	Antecedente farmacológico claro · Ausencia de hiposmia · Remisión al suspender	Nula / contraindicada (tratamiento: suspender fármaco causal)
Parálisis Supranuclear Progresiva (PSP)	Tauopatía (4R-tau) en mesencéfalo, ganglios basales y núcleos subtalámicos	Rigidez axial prominente en extensión (retrocollis); marcha rígida	Parálisis de mirada vertical hacia abajo · Caídas tempranas hacia atrás · Signo colibrí en RM	Mala / nula (< 10-15% transitoria leve)
Atrofia Multisistémica (AMS)	Alfa-sinucleinopatía en células gliales oligodendrogliales (inclusiones GCI)	Parkinsonismo rígido (AMS-P) o ataxia cerebelosa progresiva (AMS-C)	Disautonomía severa precoz (hipotensión ortostática grave, vejiga neurogénica) · Estridor laríngeo · Signo cruz caliente	Escasa / transitoria
Degeneración Corticobasal (DCB)	Tauopatía cortical y subcortical asimétrica	Parkinsonismo marcadamente asimétrico con distonía focal fija de la mano	Apraxia ideomotora severa · Fenómeno de mano ajena (alien limb) · Mioclonías corticales reflejas	Completamente nula

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

PISTA CLÍNICA	PENSAR EN	ERROR FRECUENTE
Bilateral y simétrico + flunarizina o metoclopramida	Parkinsonismo por fármacos	Iniciar levodopa

REGLA DE ORO **Simétrico, subagudo, sin pródromos** — Revisar siempre la receta

PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **46–47** (pág. 16) · solucionario págs. 32–33.

Clase 10.12 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

10.13 Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
3 preguntas reales 2013–2025

1.10.1.026 Temblor esencial — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

También: Distonía aguda por fármacos (ejemplo antieméticos) · Temblor

LO QUE TE PREGUNTAN

- El Temblor Esencial es postural y de acción, bilateral y simétrico, de 8 a 12 Hz, con fuerte agregación familiar y mejoría característica con el alcohol.
- A diferencia de la enfermedad de Parkinson, el Temblor Esencial afecta con frecuencia la cabeza (titubeo cefálico) y la voz, pero NUNCA afecta las piernas en reposo ni presenta bradicinesia.
- El tratamiento farmacológico de primera línea del Temblor Esencial sintomático e invalidante es el Propranolol o la Primidona.
- La distonía aguda por fármacos es una emergencia extrapiramidal desencadenada por bloqueo D2 (Metoclopramida, Haloperidol), manifestándose como tortícolis, crisis oculógira y trismus.
- La conducta de elección inmediata en la distonía aguda es Biperideno **2.5 a 5 mg** IM o EV lento, seguido de mantención oral por **24 a 48 horas**.

ALGORITMO · TEMBLOR Y DISTONÍA AGUDA

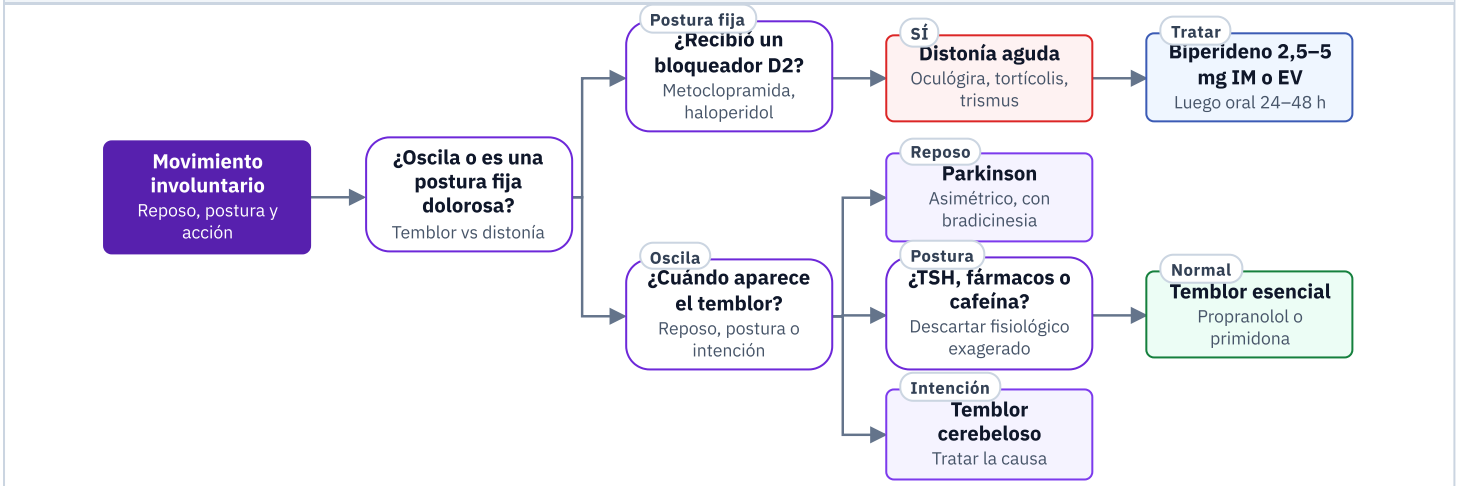


TABLA 10.13 · TABLA 10.13: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TEMBLOR ESENCIAL, PARKINSONIANO Y EMERGENCIAS EXTRAPIRAMIDALES

CARACTERÍSTICA CLÍNICA	TEMBLOR ESENCIAL	TEMBLOR PARKINSONIANO	TEMBLOR CEREBELOSO	DISTONÍA AGUDA POR FÁRMACOS
Condición de Activación	Postural y Cinético (aparece al sostener objetos o postura)	Reposo (aparece con extremidad completamente relajada)	Intencional / Cinético terminal (al aproximarse al objetivo)	Contracción tónica sostenida involuntaria (postura fija dolorosa)
Distribución Anatómica	Bilateral, manos (manos y cabeza; cuerdas vocales)	Asimétrico, manos ("cuenta monedas"); respeta cabeza	Unilateral o bilateral en extremidades; dismetría ipsilateral	Focal o segmentario: cuello (tortícolis), ojos (crisis oculógira), lengua
Frecuencia Oscilatoria	8 a 12 Hz (rápido y fino)	4 a 6 Hz (lento y de mayor amplitud)	< 4 Hz (lento, grosero y ataxia)	No oscilatorio rítmico; postura fija espástica distónica
Efecto del Alcohol	Mejoría transitoria notable (70% de los pacientes)	Sin efecto significativo	Sin efecto / puede empeorar ataxia	Sin efecto
Signos Acompañantes	Ninguno; examen neurológico rigurosamente normal	Bradicinesia, rigidez en rueda dentada, marcha a pequeños pasos	Ataxia de la marcha, dismetría, disdiadococinesia, nistagmo	Dolor intenso por espasmo, angustia; sin fiebre ni rigidez generalizada

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	DIAGNÓSTICO Y CONDUCTA	ERROR FRECUENTE
Temblor postural bilateral, cabeza, madre igual	Temblor esencial · propranolol	Dar levodopa

REGLA DE ORO **Reposo: Parkinson · Postural: esencial** — Intención: cerebelo

PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **48–51** (págs. 16–17) · solucionario págs. 33–34.

Clase 10.13 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

10.14 Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve

★★★ PRIORIDAD ALTA
12 preguntas reales 2013–2025

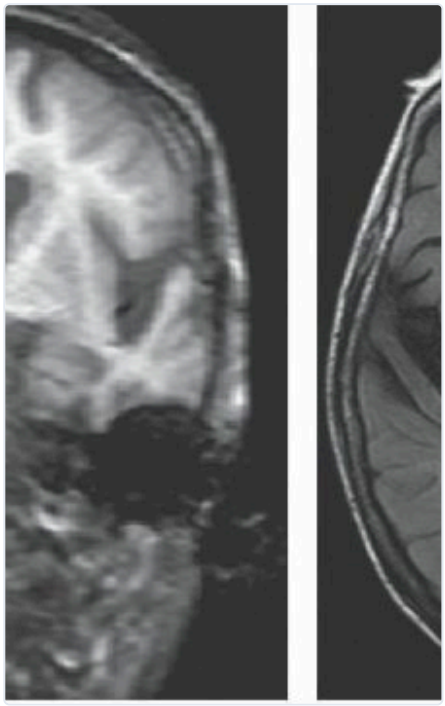
Máxima rentabilidad · Pregunta obligatoria de neurología, medicina interna y geriatría

1.10.1.005 **Demencia (Enfermedad de Alzheimer, enfermedad cerebrovascular, VIH, etc)** Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Demencia · Cuadros de deterioro orgánico cerebral potencialmente reversibles (hipotiroidismos, déficit de vitamina B12, etc.) · Aplicación de tests neurocognitivos de screening (MoCA, Mini-Cog, Mini-Mental) · Trastornos neurocognitivos · Mini mental test, MoCA test · Agitación y agresividad · Envejecimiento saludable y promoción del autocuidado · Valoración cognitiva

LO QUE TE PREGUNTAN

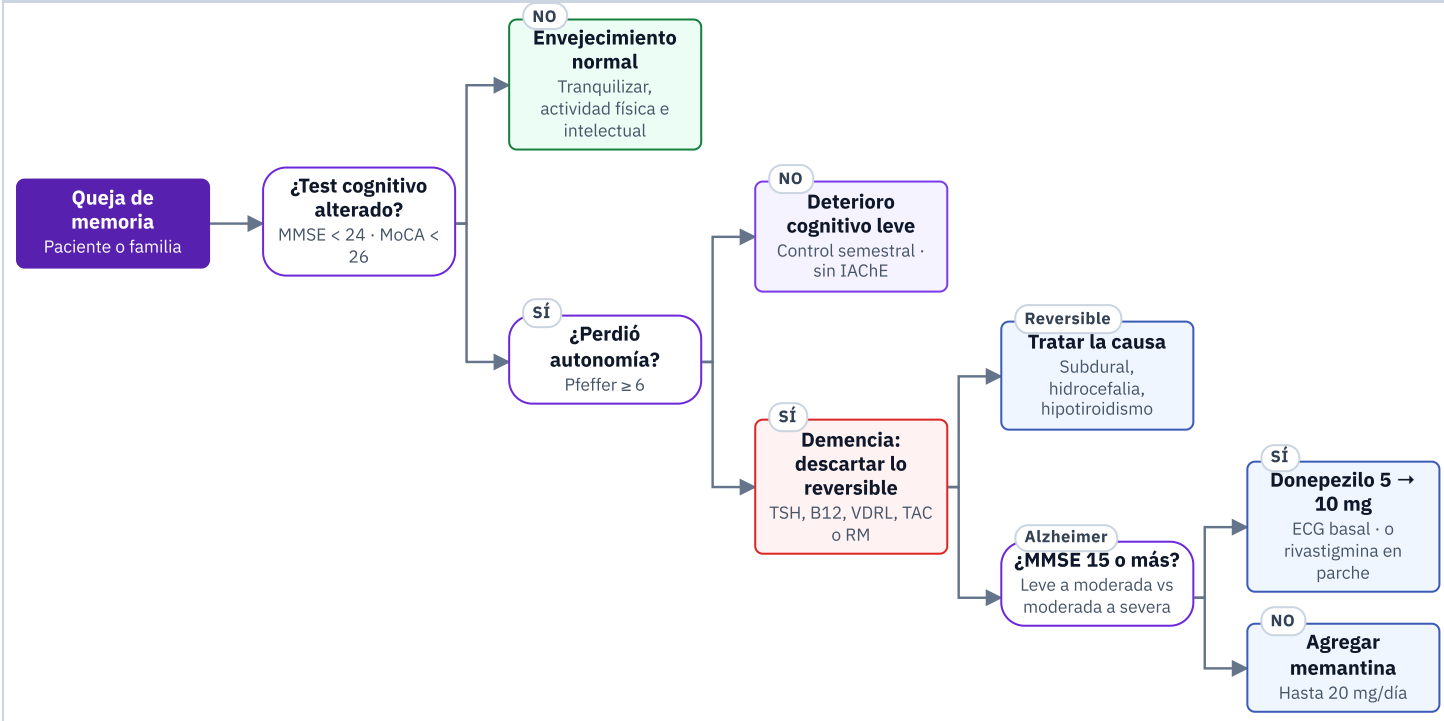
- La Enfermedad de Alzheimer es la causa más prevalente de demencia (> **60-70%**) y su manifestación inicial cardinal es la amnesia anterógrada (pérdida de memoria episódica reciente).
- La frontera clínica cardinal entre el Deterioro Cognitivo Leve (DCL) y la Demencia es la pérdida de autonomía funcional en las actividades de la vida diaria (Índice de Pfeffer **≥ 6**).
- El estudio diagnóstico inicial de toda demencia exige descartar causas potencialmente reversibles mediante TSH (hipotiroidismo), Vitamina B12, VDRL y TAC o RM cerebral sin contraste.
- La Hidrocefalia Normotensiva (Hakim-Adams) es una causa reversible que se presenta con la tríada clásica de apraxia de la marcha magnética, incontinencia urinaria y demencia.
- El tratamiento farmacológico de elección en la EA leve a moderada (Garantía GES N° 85) son los Inhibidores de la Acetilcolinesterasa (Donepezilo, Rivastigmina, Galantamina).
- En la fase moderada a severa (MMSE < 15) se debe incorporar Memantina (antagonista NMDA), fármaco que también puede asociarse en terapia dual combinada con IAChE.



ATROFIA HIPOCAMPAL
CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 102

ALGORITMO · DETERIORO COGNITIVO Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **52–54** (pág. 17) · solucionario pág. 34.

Clase 10.14 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

10.14 Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★★ PRIORIDAD ALTA

TABLA 10.14 · TABLA 10.14A: CRITERIOS NIA-AA DE DETERIORO COGNITIVO LEVE VS DEMENCIA TIPO ALZHEIMER

CRITERIO / CARACTERÍSTICA	ENVEJECIMIENTO NORMAL	DETERIORO COGNITIVO LEVE (DCL)	ENFERMEDAD DE ALZHEIMER (DEMENCIA)
Queja Subjetiva de Memoria	Olvidos ocasionales de nombres; recupera información con pistas o tiempo	Queja constante referida por el paciente y confirmada por informante clave	Frecuentemente el paciente tiene anosognosia (no es consciente del déficit); la familia consulta
Rendimiento en Test Cognitivos	Normal para edad y nivel de escolaridad (MMSE ≥ 27, MoCA ≥ 26)	Déficit objetivo demostrado en pruebas neuropsicológicas (MoCA < 26, MMSE 24-27)	Déficit multidominio significativo en test cognitivos (MMSE < 24, Test del Reloj alterado)
Autonomía en Actividades de la Vida Diaria	Completamente preservada e independiente en todas las esferas	PRESERVADA: Realiza actividades instrumentales (dinero, compras, medicación; Pfeffer < 6)	PERDIDA: Dependencia progresiva de terceros para AVD instrumentales y básicas (Pfeffer ≥ 6)
Perfil de Memoria Afectado	Dificultad leve en recuperación; almacenamiento y consolidación intactos	Afectación selectiva de consolidación episódica reciente (DCL amnésico)	Amnesia episódica anterógrada severa (olvida conversaciones recientes, citas y eventos del día)
Tasa de Progresión Anual a Demencia	1% a 2% por año (riesgo basal de la población general)	10% a 15% por año evolucionan hacia demencia franca tipo Alzheimer	Enfermedad neurodegenerativa progresiva irreversible; sobrevida media 8-10 años
Conducta Terapéutica Normada	Tranquilizar al paciente; fomentar actividad física e intelectual	Control cognitivo semestral, ejercicio aeróbico, dieta mediterránea; NO usar fármacos IAChE	Tratamiento específico con Donepezilo / Rivastigmina + Memantina (Garantía GES N° 85)

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Olvida nombres, recuerda con pistas, test normal	Envejecimiento normal: tranquilizar	Rotularlo como demencia
Test alterado, pero autónomo	Deterioro cognitivo leve: control semestral	Iniciar donepezilo
Olvidos + dependencia para dinero y remedios	Demencia: estudiar causas reversibles	Tratar sin exámenes

REGLA DE ORO **Amnesia anterógrada** — Hipocampo primero; consulta la familia

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La Enfermedad de Alzheimer (EA) es la principal causa de demencia en Chile y el mundo, representando entre el 60% y el 70% de los casos de trastorno neurocognitivo mayor. Con la promulgación de la Garantía GES N° 85, el diagnóstico y abordaje integral de las demencias se consolidó como una prioridad sanitaria nacional. El sello distintivo de la enfermedad es el deterioro insidioso, progresivo e irreversible de la memoria episódica reciente (amnesia anterógrada), conservando durante etapas prolongadas la memoria remota y el nivel de vigilia. La frontera diagnóstica crucial frente al Deterioro Cognitivo Leve (DCL) radica en la pérdida de la independencia funcional para las actividades de la vida diaria. El rol del médico general comprende la aplicación de escalas diagnósticas breves (MMSE, MoCA, Test del Reloj), el descarte sistemático de causas potencialmente reversibles (B12, TSH, VDRL, hidrocefalia) y la titulación oportuna de inhibidores de la acetilcolinesterasa y memantina.

BLOQUE 03 · TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

10.15 Demencia Vascular, Demencia por Cuerpos de Lewy y Demencia Frontotemporal

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
6 preguntas reales 2013–2025

1.10.1.005 **Demencia (Enfermedad de Alzheimer, enfermedad cerebrovascular, VIH, etc)** Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Demencia

LO QUE TE PREGUNTAN

- La Demencia Vascular se caracteriza por un curso de deterioro escalonado (stepwise), disfunción ejecutiva y presencia de signos neurológicos focales al examen físico.
- La Demencia por Cuerpos de Lewy se define por la tríada nuclear de fluctuación cognitiva circadiana, alucinaciones visuales tempranas estructuradas y parkinsonismo espontáneo.
- **Regla de Oro Vital EUNACOM**: Los antipsicóticos típicos (Haloperidol) están contraindicados en la Demencia por Cuerpos de Lewy por generar hipersensibilidad severa con rigidez extrema y muerte.
- La regla del año diferencia la DCL (demencia previa o dentro del primer año del parkinsonismo) de la Demencia en Enfermedad de Parkinson (parkinsonismo precede a la demencia por años).
- La Demencia Frontotemporal es la principal causa de demencia presenil (< **65 años**) y se manifiesta con desinhibición social, apatía, hiperoralidad y pérdida de empatía con memoria conservada.

ALGORITMO · DEMENCIA NO ALZHEIMER: QUÉ PERFIL TIENE

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

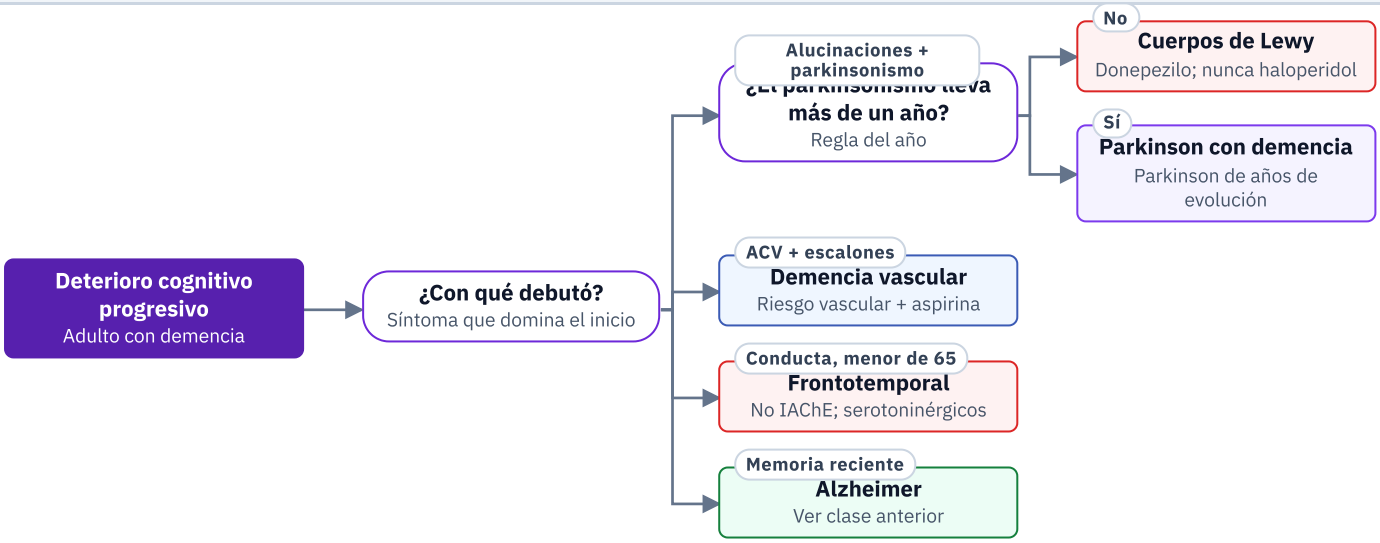


TABLA 10.15 · TABLA 10.15: PERFIL CLÍNICO DIFERENCIAL DE DEMENCIA VASCULAR, CUERPOS DE LEWY Y DEMENCIA FRONTOTEMPORAL

RASGO DIFERENCIAL	DEMENCIA DE ALZHEIMER	DEMENCIA VASCULAR	DEMENCIA POR CUERPOS DE LEWY	DEMENCIA FRONTOTEMPORAL (PICK)
Edad de Inicio Típica	> 65 años (senil tardía)	Cualquier edad con FRCV	> 60-70 años	45 a 65 años (típicamente presenil)
Modo de Inicio y Curso	Insidioso, progresivo continuo y gradual sin mesetas	Fluctuante, deterioro en escalones (stepwise) tras eventos vasculares	Fluctuante circadiano de un día a otro o dentro del mismo día	Insidioso, cambio de personalidad progresivo
Síntoma Clínico Cardinal	Amnesia episódica anterógrada (olvido de hechos recientes)	Disfunción ejecutiva frontal y enlentecimiento psicomotor	Tríada: Alucinaciones visuales + Fluctuaciones + Parkinsonismo	Desinhibición social, apatía, hiperoralidad y pérdida de empatía
Examen Neurológico Físico	Normal en etapas iniciales y moderadas	Signos focales motores: paresias, Babinski (+), reflejos exaltados	Parkinsonismo espontáneo (rigidez, bradicinesia, fascies inexpresiva)	Comportamiento desinhibido; reflejos frontales arcaicos precoces

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

RASGO	VASCULAR	CUERPOS DE LEWY	FRONTOTEMPORAL
Trampa terapéutica	Olvidar la prevención vascular	Dar haloperidol	Dar donepezilo

REGLA DE ORO **Escalones + signos focales** — Demencia vascular

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Neurología**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 10.15 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · PATOLOGÍA NEUROMUSCULAR, DESMIELINIZANTE Y NERVIO PERIFÉRICO

10.16 Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo

★★★ PRIORIDAD ALTA
14 preguntas reales 2013–2025

Máxima rentabilidad · Pregunta angular de urgencias neurológicas y medicina intensiva

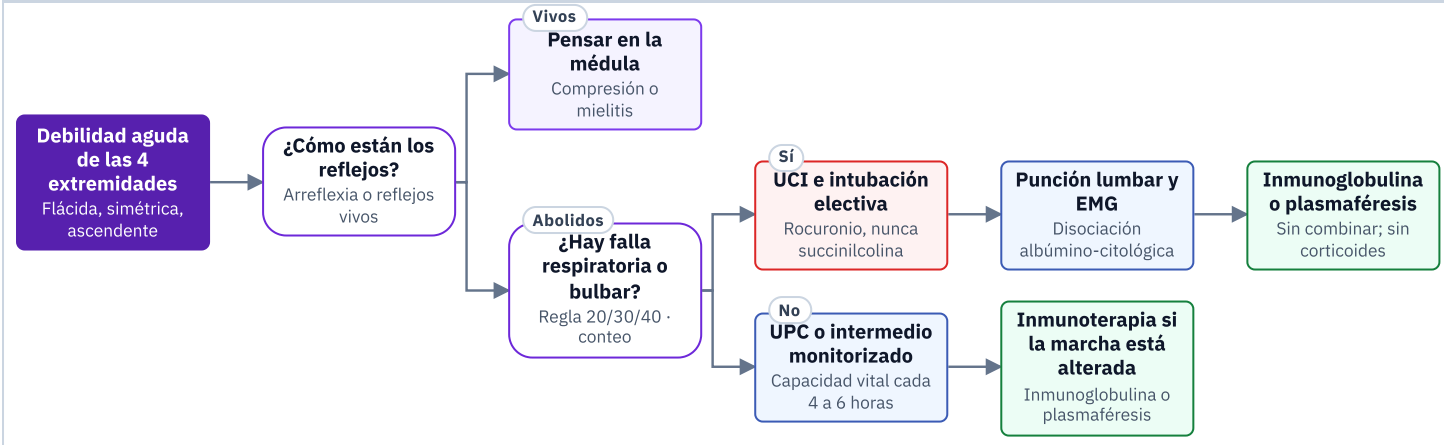
1.10.2.013 **Síndrome cuadriparético fláccido (poliradiculoneurítis aguda, Guillain-Barré)** Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

También: Polineuropatías, radiculopatías, mononeuropatías, etc... · Examen de líquido cefaloraquídeo (citoquímico, bacteriológico) · Electromiografia · Parálisis (tetraparesia, hemiparesia, etc) · Síndrome cuadraplégico agudo

LO QUE TE PREGUNTAN

- El Síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda autoinmune desencadenada por mimetismo molecular post-infeccioso (Campylobacter jejuni, CMV, EBV).
- El hallazgo clínico obligatorio y más constante en el examen físico es la debilidad motora simétrica ascendente con arreflexia osteotendinosa universal (0/4+).
- La complicación mortal más frecuente es la falla respiratoria neuromuscular: se evalúa mediante la regla 20/30/40 (CVF < **20 mL/kg**, PImáx < **30 cm**H2O) o conteo espiratorio simple < 20.
- En caso de requerir intubación orotraqueal, la Succinilcolina está TERMINANTEMENTE CONTRAINDICADA por el riesgo de hiperkalemia masiva letal secundaria a denervación; usar Rocuronio.
- El estudio de LCR revela disociación albúmino-citológica (hiperproteinorraquia marcada con leucocitos normales < 10-50/µL); puede ser normal durante los primeros **7 días** de síntomas.
- El tratamiento de elección consiste en Inmunoglobulina Humana EV (**0.4 g**/kg/día por **5 días**) o Plasmaféresis terapéutica (4-5 sesiones en días alternos); los CORTICOIDES ESTÁN FORMALMENTE CONTRAINDICADOS.

ALGORITMO · GUILLAIN-BARRÉ: DE LA SOSPECHA A LA INMUNOTERAPIA



PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **58–63** (págs. 18–19) · solucionario págs. 35–36.

Clase 10.16 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · PATOLOGÍA NEUROMUSCULAR, DESMIELINIZANTE Y NERVIO PERIFÉRICO

10.16 Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★★ PRIORIDAD ALTA

TABLA 10.16 · CRITERIOS DE ASBURY Y VARIANTES CLÍNICAS DEL SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ

SUBTIPO / VARIANTE	MECANISMO PATOLÓGICO Y ANTICUERPOS	CUADRO CLÍNICO DISTINTIVO	HALLAZGOS NEUROFISIOLÓGICOS
AIDP (Polirradiculoneuropatía Desmielinizante Aguda)	Ataque a vaina de mielina de raíces y troncos · Células T y macrófagos (> 85-90% en Occidente)	Debilidad motora simétrica ascendente + Parestesias distales · Parálisis facial bilateral en 50% · Arreflexia universal	Enlentecimiento de VCN (< 70%), prolongación de latencias distales y ondas F ausentes/retrasadas · Dispersión temporal
AMAN (Neuropatía Axonal Motora Aguda)	Ataque directo a nódulos de Ranvier motores mediado por anti-GM1 y anti-GD1a (tras C. jejuni)	Debilidad motora pura rápida y severa SIN alteraciones sensitivas objetivas · Arreflexia · Alta tasa de soporte ventilatorio	Disminución marcada de la amplitud del CMAP con velocidades de conducción conservadas · Ausencia de dispersión
AMSAN (Neuropatía Axonal Motora y Sensitiva Aguda)	Degeneración axonal masiva de axones motores y sensitivos · Anticuerpos anti-GM1 / GD1a	Tetraparesia flácida severa + Pérdida sensitiva profunda global · Evolución fulminante y recuperación muy lenta con secuelas	Amplitudes de CMAP y SNAP gravemente reducidas o ausentes en todas las extremidades · Marcada denervación en agudo
Síndrome de Miller Fisher (MFS)	Ataque a nervios oculomotores y husos neuromusculares · Anticuerpos patognomónicos anti-GQ1b (> 90%)	Tríada clásica de Miller Fisher: 1) Ataxia sensitiva/cerebelosa, 2) Arreflexia osteotendinosa, 3) Oftalmoplejía bilateral externa	SNAP disminuidos con conducción motora habitualmente preservada · Responde de forma óptima a IgEV o plasmaféresis
Encefalitis de Tallo de Bickerstaff	Espectro común con MFS · Reactividad cruzada anti-GQ1b y anti-GM1b en formación reticular	Oftalmoplejía + Ataxia + Compromiso fluctuante de conciencia (letargia, estupor, coma) · Puede tener signos piramidales	LCR con disociación albúmino-citológica · RMN puede mostrar hiperintensidades en protuberancia/mesencéfalo
Variante Faringo-Cérvico-Braquial	Compromiso focalizado de raíces bulbares y cervicales altas · Asociación con anti-GT1a	Ptosis, disfagia severa, paresia faríngea y debilidad marcada de cuello y hombros; extremidades inferiores respetadas	Conducción alterada en nervios cervicales y pares craneales inferiores · Frecuente confusión con botulismo o miastenia

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Debilidad ascendente con reflejos vivos	Pensar en la médula	Diagnosticar Guillain-Barré
Saturación normal, cuenta hasta 12	UCI e intubación electiva	Tranquilizarse por la oximetría
LCR normal en la primera semana	Mantener la sospecha y tratar	Descartar el diagnóstico

REGLA DE ORO **Debilidad ascendente + arreflexia** — Tras una infección reciente

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El Síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una polirradiculoneuropatía aguda inflamatoria autoinmune que representa la causa más frecuente de parálisis flácida aguda en el adulto y una emergencia médica tiempo-dependiente. Su fisiopatología radica en un mimetismo molecular post-infeccioso (habitualmente tras gastroenteritis por Campylobacter jejuni o infecciones respiratorias virales) donde autoanticuerpos atacan gangliósidos y mielina de raíces nerviosas y nervios periféricos. El sello clínico cardinal es la debilidad muscular bilateral y simétrica, de progresión ascendente, acompañada invariablemente de arreflexia osteotendinosa universal. Hasta un 30% de los pacientes desarrolla insuficiencia respiratoria aguda neuromuscular por paresia diafragmática y de la musculatura intercostal, requiriendo intubación orotraqueal electiva y soporte en UPC. El diagnóstico se confirma mediante disociación albúmino-citológica en el líquido cefalorraquídeo y electromiografía. El tratamiento inmunomodulador de elección es la Inmunoglobulina Humana EV (0.4 g/kg/día por 5 días) o la Plasmaféresis en sesiones alternas (ambas de igual eficacia); los corticoides están formalmente contraindicados.

PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **58–63** (págs. 18–19) · solucionario págs. 35–36.

Clase 10.16 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · PATOLOGÍA NEUROMUSCULAR, DESMIELINIZANTE Y NERVIO PERIFÉRICO

10.17 Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
6 preguntas reales 2013–2025

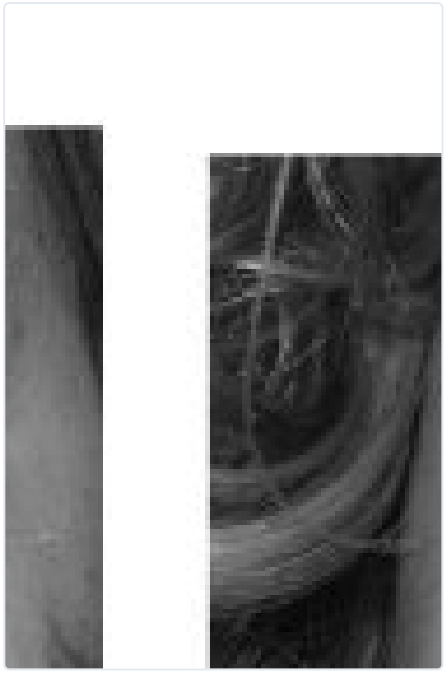
Alta rentabilidad · Pregunta angular de patología de la unión neuromuscular en EUNACOM

1.10.1.020 **Síndrome miasténico** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

También: Electromiografia

LO QUE TE PREGUNTAN

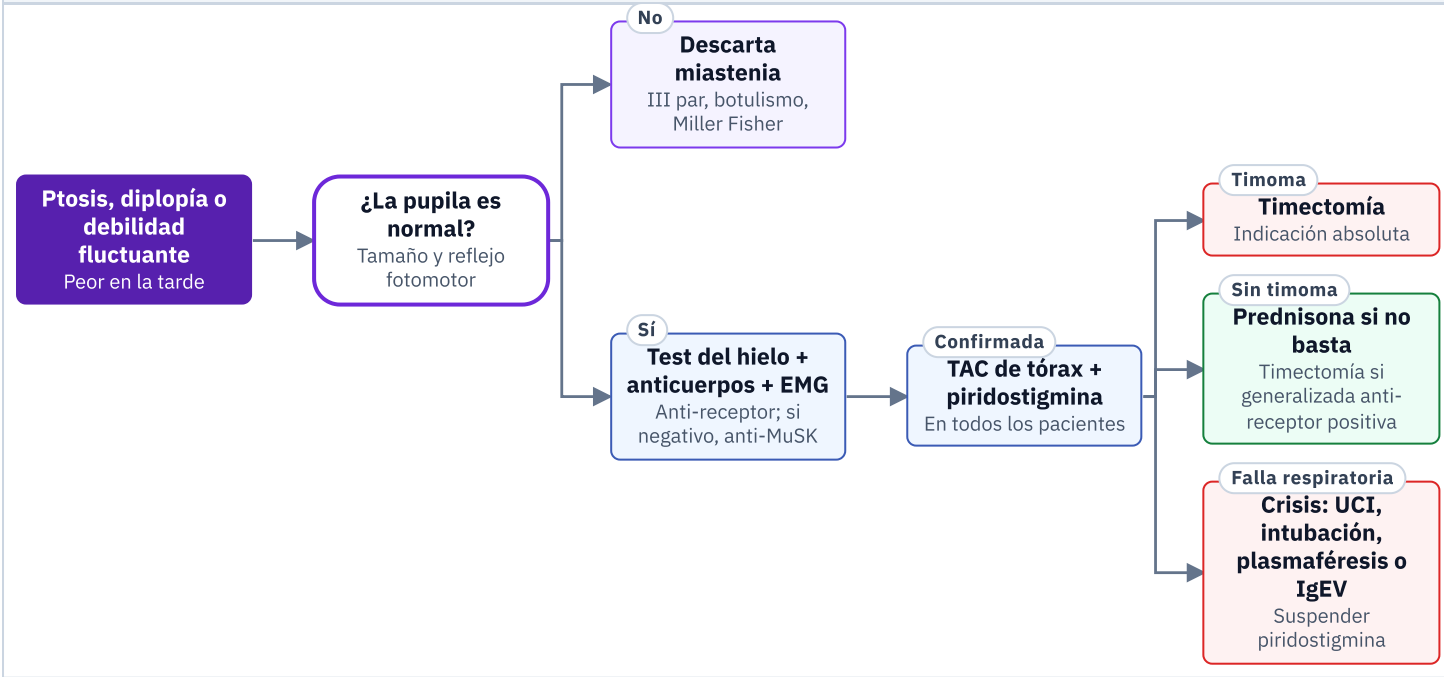
- La Miastenia Gravis es un trastorno autoinmune postsináptico caracterizado por debilidad muscular fluctuante y fatigabilidad (empeora con el uso repetido y mejora con reposo).
- **Signo semiológico de oro en examen físico**: las pupilas son SIEMPRE normales y reactivas a la luz (la musculatura pupilar intrínseca nunca se compromete en miastenia).
- El test del hielo (ice pack test) a pie de cama mejora la ptosis palpebral en **≥ 2 mm** tras **2 minutos** debido a la inhibición térmica de la acetilcolinesterasa.
- El estudio diagnóstico confirmatorio requiere anticuerpos anti-AChR (positivos en **85%**), anti-MuSK en seronegativos, EMG con decremento > **10%** a 3 Hz y TAC de tórax para despistaje de timoma.
- Fármacos absolutamente contraindicados que desencadenan crisis miasténica: aminoglucósidos, fluoroquinolonas, betabloqueadores, sulfato de magnesio EV y relajantes musculares curarizantes.
- El tratamiento crónico se basa en piridostigmina oral (**60 mg** c/**4-6 h**), corticoides e inmunosupresores; la timectomía es obligatoria en timoma y recomendada en MG generalizada anti-AChR (+).



PTOSIS: ANTES Y DESPUÉS
Wikimedia Commons

ALGORITMO · MIASTENIA GRAVIS: DE LA SOSPECHA A LA CRISIS

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **64–67** (pág. 19) · solucionario págs. 36–37.

Clase 10.17 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · PATOLOGÍA NEUROMUSCULAR, DESMIELINIZANTE Y NERVIO PERIFÉRICO

10.17 Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★☆ PRIORIDAD MEDIA

TABLA 10.17 · DIAGNÓSTICO CLÍNICO, PRUEBAS DE CABECERA Y MÉTODOS PARACLÍNICOS EN MIASTENIA GRAVIS

MÉTODO / PRUEBA DIAGNÓSTICA	FUNDAMENTO FISIOPATOLÓGICO	SENSIBILIDAD / ESPECIFICIDAD	UTILIDAD Y CONSIDERACIONES CLÍNICAS
Fatigabilidad Clínica (Semiología)	Agotamiento del pool presináptico de ACh que desciende bajo el umbral de activación postsináptico	Sensibilidad ~85% / Muy específica si es fluctuante	Debilidad que empeora al final de la tarde o tras uso muscular repetido y revierte tras reposo; pupilas estrictamente normales
Test del Hielo (Ice Pack Test)	El frío inhibe localmente la enzima acetilcolinesterasa aumentando la concentración de ACh	Sensibilidad 80-90% / Especificidad > 95%	Mejora de la hendidura palpebral en ≥ 2 mm tras 2-3 min de aplicación de hielo sobre el párpado; simple, rápida e inocua a pie de cama
Anticuerpos anti-AChR	Anticuerpos IgG dirigidos contra el receptor nicotínico postsináptico activadores de complemento	Sensibilidad 85% en generalizada (50% en ocular) / Espec. > 98%	Marcador de confirmación definitivo; no se correlaciona necesariamente con la severidad exacta de los síntomas
Anticuerpos anti-MuSK	Anticuerpos contra tirosina quinasa muscular esencial para el clustering de receptores AChR	Presentes en 35-40% de pacientes con anti-AChR negativos	Fenotipo clínico con predominio bulbar severo, disartria, disfagia, debilidad facial y atrofia lingual; respuesta excelente a Rituximab
Estimulación Repetitiva (ENR 3 Hz)	Caída progresiva del potencial de acción muscular compuesto por falla en fibras agotadas	Sensibilidad 75% en generalizada (menor en ocular)	Patrón patológico de decremento > 10% entre el 1° y 4°-5° potencial del CMAP; altamente orientador
EMG de Fibra Aislada (Single-Fiber)	Medición de la variabilidad temporal entre dos fibras inervadas por la misma unidad motora	Sensibilidad > 95-99% (la prueba más sensible disponible)	Gold standard neurofisiológico; demuestra aumento del jitter y bloqueo de potenciales; altamente técnico
TAC de Tórax con Contraste	Visualización de masas mediastínicas anteriores en el espacio retroesternal	Sensibilidad > 95% para timoma	Obligatorio en el 100% de los pacientes diagnosticados de MG; pesquisa timoma en 10-15% e hiperplasia tímica en 70%

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Ptosis fluctuante con pupila normal	Miastenia: test del hielo y anticuerpos	Pensar en el tercer par
Ptosis con midriasis	Buscar compresión del III par	Diagnosticar miastenia
Miastenia recién diagnosticada	TAC de tórax siempre	Pedirlo solo si hay síntomas

REGLA DE ORO **Peor con el uso, mejor con reposo** — Ocular, bulbar y proximal

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La Miastenia Gravis (MG) es una enfermedad autoinmune crónica mediada por anticuerpos contra componentes de la membrana postsináptica de la placa motora, predominantemente contra el receptor nicotínico de acetilcolina (AChR, 85% de los casos generalizados) y la tirosina quinasa específica del músculo (MuSK). Su sello clínico patognomónico es la debilidad muscular fluctuante caracterizada por fatigabilidad: la fuerza empeora con el ejercicio repetido o al final del día y mejora sustancialmente tras el reposo o la aplicación local de frío. Afecta típicamente la musculatura ocular extrínseca (ptosis y diplopía con preservación rigurosa de los reflejos pupilares), la musculatura bulbar (disfagia, disartria, voz nasal) y la musculatura proximal de extremidades. La complicación más grave es la Crisis Miasténica (falla ventilatoria por debilidad diafragmática), desencadenada frecuentemente por infecciones o fármacos que bloquean la transmisión neuromuscular. El timo desempeña un papel patogénico central: 65% presenta hiperplasia tímica y 10-15% un timoma (obligando a solicitar TAC de tórax). El tratamiento escalonado incluye inhibidores de la acetilcolinesterasa (piridostigmina), inmunosupresores, timectomía y plasmaféresis o inmunoglobulina EV en las crisis.

PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **64–67** (pág. 19) · solucionario págs. 36–37.

Clase 10.17 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · PATOLOGÍA NEUROMUSCULAR, DESMIELINIZANTE Y NERVIO PERIFÉRICO

10.18 Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
2 preguntas reales 2013–2025

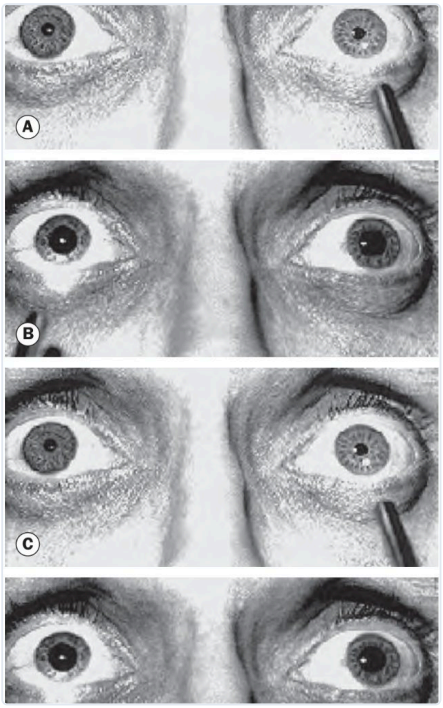
Alta rentabilidad · Enfermedad desmielinizante prototípica del SNC en adultos jóvenes

1.10.1.008 Esclerosis múltiple — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

También: Resonancia magnética de encéfalo y columna · Examen de líquido cefaloraquídeo (citoquímico, bacteriológico)

LO QUE TE PREGUNTAN

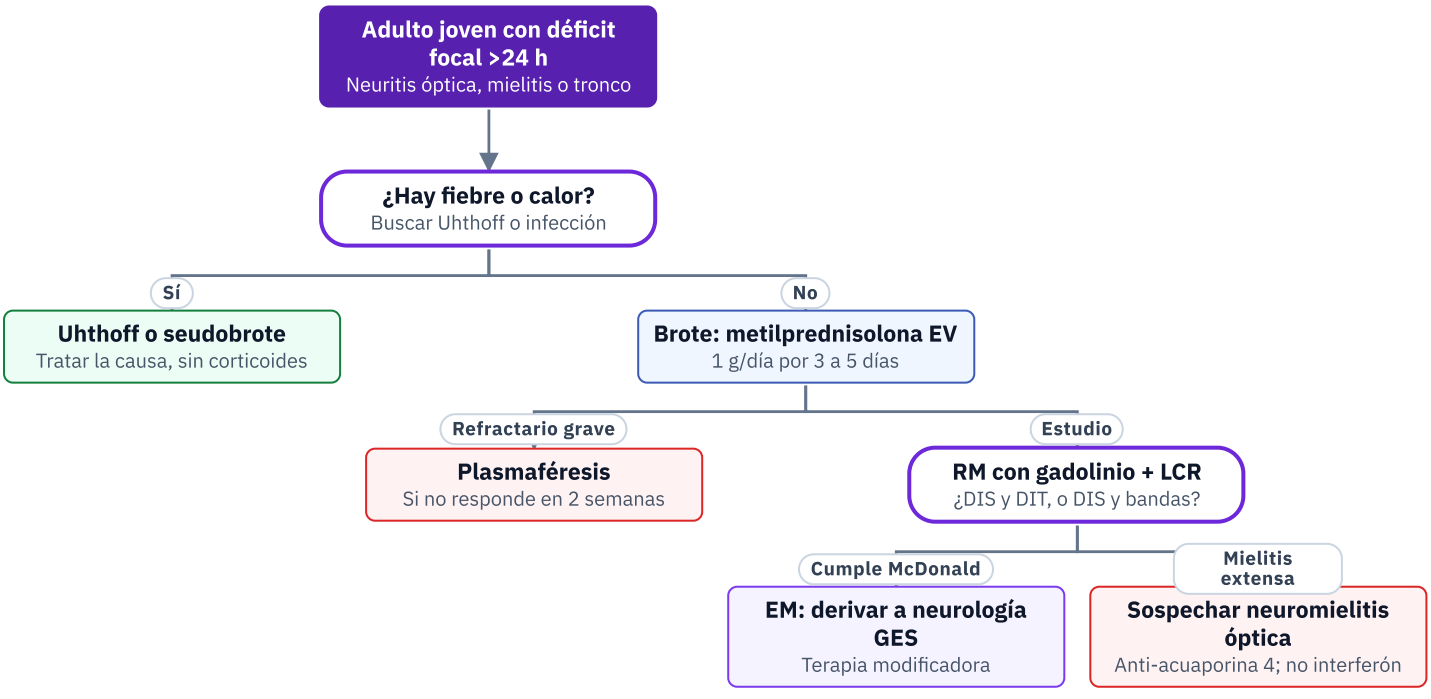
- La Esclerosis Múltiple es una afección autoinmune crónica desmielinizante del SNC típica de mujeres de **20-45 años**; la forma Remitente-Recurrente (EMRR) representa el **85%** de los debuts.
- **Presentaciones clínicas clásicas**: neuritis óptica monocular dolorosa con Marcus Gunn (DPAR), mielitis transversa parcial y oftalmoplejía internuclear bilateral (lesión del FLM).
- El fenómeno de Uhthoff (empeoramiento transitorio de síntomas con el calor/fiebre) y el signo de Lhermitte (descarga eléctrica al flectar el cuello) son sellos semiológicos cardinales.
- **Criterios de McDonald (2017)**: exigen Diseminación en Espacio (DIS en **≥ 2 de** 4 territorios: periventricular, yuxtacortical, infratentorial, médula) y Diseminación en Tiempo (DIT).
- Las Bandas Oligoclonales IgG en LCR (patrón 2) reflejan síntesis intratecal autónoma de anticuerpos y según McDonald 2017 SUSTITUYEN el criterio de DIT ante un primer brote con DIS.
- El tratamiento del brote agudo consiste en Metilprednisolona EV **1 g**/día por **3 a 5 días**; la mantención se efectúa con FME (GES 69): dimetilfumarato, natalizumab (riesgo LMP por virus JC) u ocrelizumab.



DEFECTO PUPILAR AFERENTE
Kanski, Oftalmología clínica 8.ª ed., p. 820

ALGORITMO · ESCLEROSIS MÚLTIPLE: DEL PRIMER BROTE AL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, pregunta **68** (pág. 19) · solucionario pág. 37.

Clase 10.18 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · PATOLOGÍA NEUROMUSCULAR, DESMIELINIZANTE Y NERVIO PERIFÉRICO

10.18 Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★☆☆ PRIORIDAD BAJA

TABLA 10.18 · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE MCDONALD (REVISIÓN 2017) Y HALLAZGOS EN RESONANCIA MAGNÉTICA

CRITERIO / TERRITORIO	DEFINICIÓN RADIOLÓGICA / BIOMARCADOR	REGIONES CARDINALES DEL SNC	IMPLICANCIA CLÍNICA EN EUNACOM
Diseminación en Espacio (DIS)	Presencia de ≥ 1 lesión hiperintensa en T2 en ≥ 2 de las 4 localizaciones típicas del SNC	1) Periventricular (Dedos de Dawson), 2) Cortical / Yuxtacortical, 3) Infratentorial (tronco/cerebelo), 4) Médula espinal	Demuestra que el proceso inflamatorio desmielinizante afecta múltiples áreas no contiguas del neuroeje
Diseminación en Tiempo (DIT - RMN)	Coexistencia de lesiones captantes y no captantes de gadolinio en RMN basal, o nueva lesión T2/Gd+ en control	Cualquier territorio típico cerebral o médula espinal	Evidencia que la actividad patológica se genera en momentos cronológicos temporalmente separados
Bandas Oligoclonales (BOC en LCR)	Presencia de ≥ 2 bandas oligoclonales de IgG en LCR ausentes en suero (Patrón Tipo 2 de isoelectroenfoque)	Síntesis intratecal de inmunoglobulinas por clones de células plasmáticas en el SNC	APORTE CLAVE McDONALD 2017: En un paciente con un primer brote (CIS) y DIS en RMN, las BOC positivas SUSTITUYEN la DIT
Lesiones Periventriculares	Lesiones ovoideas con eje mayor perpendicular a los ventrículos laterales (Dedos de Dawson)	Cuerpo calloso, sustancia blanca periventricular y comisuras	Reflejan inflamación venulocéntrica profunda; altamente sugestivas de esclerosis múltiple
Lesiones Medulares Típicas	Lesiones asimétricas, periféricas (posterolaterales), de menos de 2 cuerpos vertebrales de extensión	Médula cervical (frecuente) o torácica	Permiten diferenciar de Neuromielitis Óptica (NMOSD), cuyas lesiones son centrales y continuas ≥ 3 vértebras (LETM)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	RESPUESTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Joven con déficits focales en distintos momentos	Esclerosis múltiple	Guillain-Barré o polineuropatía
Visión baja en días, dolor al mover el ojo, DPAR	Neuritis óptica	Neuropatía óptica isquémica
Empeora en un baño caliente	Fenómeno de Uhthoff	Tratarlo como brote

REGLA DE ORO **Mujer joven, déficits que van y vienen** — En distintos lugares y momentos

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune crónica, inflamatoria y desmielinizante del Sistema Nervioso Central (SNC), caracterizada por daño axonal progresivo, pérdida de oligodendrocitos y gliosis reactiva (placas de desmielinización). Representa la primera causa de discapacidad neurológica no traumática en adultos jóvenes, con clara predilección por mujeres (proporción 3:1) entre los 20 y 45 años. Su curso evolutivo clásico es la forma Remitente-Recurrente (EMRR, 85% de los casos), definida por la aparición recurrente de "brotes" neurológicos agudos (neuritis óptica dolorosa unilateral con defecto pupilar aferente relativo, mielitis transversa incompleta, síndrome de tronco con oftalmoplejía internuclear) separados por remisiones clínicas. El diagnóstico se basa en los Criterios de McDonald (revisión 2017), que exigen demostrar Diseminación en Espacio (DIS) y Diseminación en Tiempo (DIT) en la Resonancia Magnética o mediante la presencia de Bandas Oligoclonales IgG en el líquido cefalorraquídeo. El brote agudo se trata con megadosis de Metilprednisolona EV (1 g/día por 3 a 5 días) y la prevención de progresión con terapias modificadoras de la enfermedad garantizadas por el GES N° 69.

PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, pregunta **68** (pág. 19) · solucionario pág. 37.

Clase 10.18 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · PATOLOGÍA NEUROMUSCULAR, DESMIELINIZANTE Y NERVIO PERIFÉRICO

10.19 Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
6 preguntas reales 2013–2025

1.10.1.016 **Parálisis facial periférica** — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

También: Neuropatías por atrapamiento · Síndrome de túnel carpiano · Electromiografía

LO QUE TE PREGUNTAN

- La parálisis facial periférica (Bell) afecta TODA la hemicara ipsilateral, incluyendo frente y ceja, con imposibilidad de cerrar el ojo (lagoftalmos y Signo de Bell).
- La parálisis facial central respeta rigurosamente la frente y el cierre ocular (conserva la capacidad de arrugar la frente) debido a la inervación cortical bilateral del núcleo superior.
- El tratamiento de elección en la Parálisis de Bell es Prednisona oral **1 mg/kg**/día (**60 mg**/día) iniciada precozmente (< **72 horas**) durante **7 a 10 días**.
- La protección ocular activa es obligatoria en parálisis periférica (lágrimas artificiales de día, ungüento lubricante y oclusión nocturna) para evitar queratitis por exposición.
- El Síndrome del Túnel Carpiano produce parestesias nocturnas en los primeros 3 dedos y medio; se diagnostica con Phalen y Tinel y se trata con férula neutra o cirugía si hay atrofia tenar.

ALGORITMO · PARÁLISIS FACIAL AGUDA: CENTRAL, BELL O ALGO MÁS

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

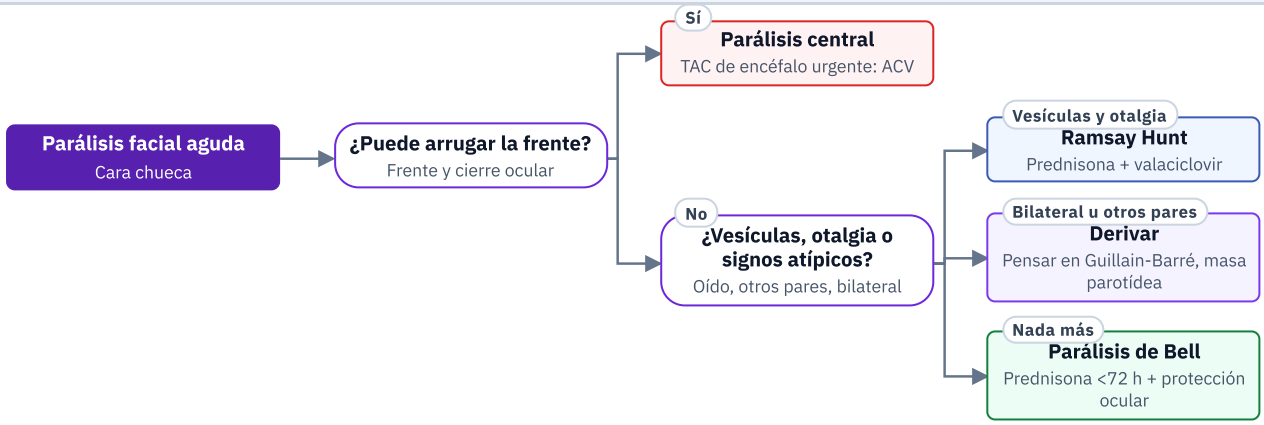


TABLA 10.19 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE PARÁLISIS FACIAL Y NEUROPATÍAS POR ATRAPAMIENTO

ENTIDAD CLÍNICA	LOCALIZACIÓN LESIONAL Y MECANISMO	MANIFESTACIONES CLÍNICAS CARDINALES	HALLAZGOS DE EXAMEN FÍSICO Y CONDUCTA EUNACOM
Parálisis Facial Periférica (Bell)	Lesión del nervio facial en el canal de Falopio (edema viral VHS-1)	Paresia COMPLETA de toda la hemicara ipsilateral: frente, ojo, mejilla y boca	Imposibilidad de arrugar la frente · Signo de Bell (+) y lagoftalmos · Prednisona 60 mg x 7 d + Protección ocular
Parálisis Facial Central	Lesión de vía córtico-nuclear supranuclear contralateral (ACV isquémico/hemorrágico)	Paresia circunscrita a los DOS TERCIOS INFERIORES de la cara contralateral	CAPACIDAD DE ARRUGAR LA FRENTE Y CERRAR EL OJO ESTRICTAMENTE PRESERVADA · TAC de encéfalo urgente (GES 37)
Síndrome de Ramsay Hunt	Reactivación de Virus Varicela Zóster en el ganglio geniculado del VII par	Parálisis facial periférica completa + Otalgia severa + Erupción vesicular en CAE	Vesículas herpéticas en concha auricular y tímpano · Hipoacusia/vértigo · Prednisona + Valaciclovir / Aciclovir precoz
Síndrome del Túnel Carpiano	Compresión del nervio mediano bajo el retináculo flexor en la muñeca	Parestesias y dolor nocturno en 1°, 2°, 3° y mitad radial del 4° dedo; signo de Flick	Signo de Phalen (+) y Tinel (+) · Atrofia tenar tardía · Férula nocturna neutra; cirugía descompresiva si atrofia
Atrapamiento del Nervio Ulnar	Compresión del nervio ulnar en el túnel cubital (codo) o canal de Guyón (muñeca)	Parestesias en 5° dedo y mitad medial del 4° dedo; debilidad de músculos intrínsecos	Signo de Froment (+) por debilidad del aductor del pulgar · Atrofia hipotenar · Mano en garra ulnar

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	RESPUESTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Toda la hemicara, sin otros signos	Bell: prednisona <72 h + protección ocular	Aciclovir de rutina

REGLA DE ORO — **Frente tomada: periférica** — Toda la hemicara, mismo lado

PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **69–71** (págs. 19–20) · solucionario págs. 37–38.

Clase 10.19 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · PATOLOGÍA NEUROMUSCULAR, DESMIELINIZANTE Y NERVIO PERIFÉRICO

10.20 Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central: VPPB, Maniobras de Epley y Protocolo HINTS

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

1.10.1.025 Síndromes vertiginosos periféricos — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Síndromes vertiginosos centrales · Síndrome vertiginoso agudo · Síndrome atáxico

LO QUE TE PREGUNTAN

- El vértigo periférico se caracteriza por inicio brusco, gran cortejo vegetativo (náuseas/vómitos) y nistagmo unidireccional que se inhibe al fijar la mirada y no cambia de sentido.
- **El VPPB es el vértigo más prevalente**: dura segundos (< **1 minuto**), es gatillado por cambios posturales cefálicos, no tiene hipoacusia y se confirma con Dix-Hallpike (+).
- El tratamiento del VPPB es mecánico mediante la Maniobra de Reposición de Epley en la misma consulta; los fármacos antivertiginosos y neuroimágenes NO están indicados.
- El Protocolo HINTS a pie de cama supera a la RMN en las primeras **24-48 h** del síndrome vestibular agudo para descartar ACV de fosa posterior (tronco/cerebelo).

ALGORITMO · VÉRTIGO AGUDO: VPPB, PERIFÉRICO O ACV

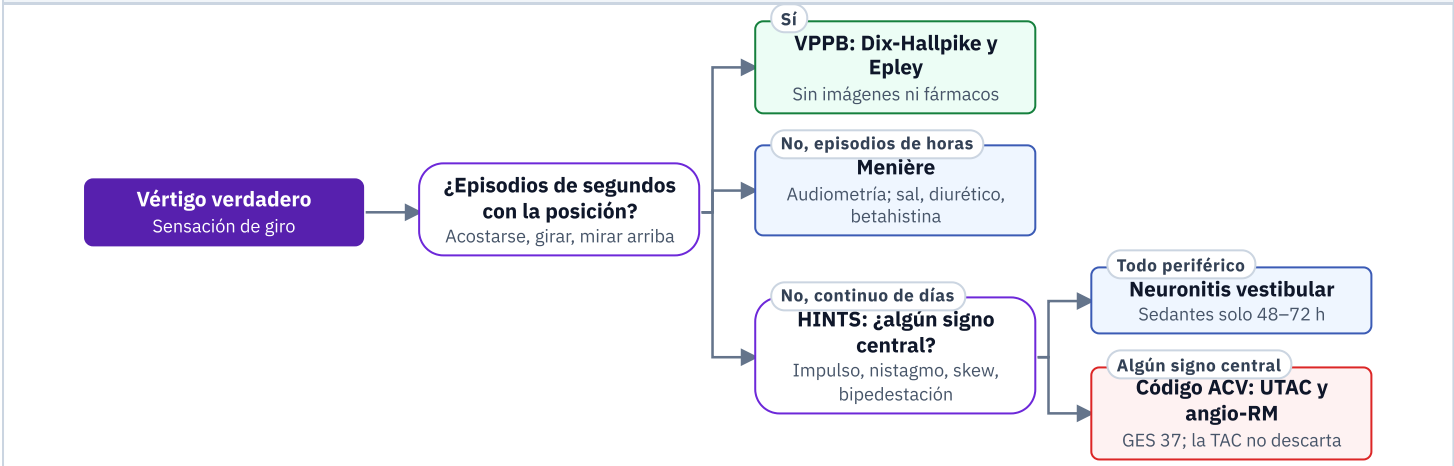


TABLA 10.20 · PROTOCOLO HINTS Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE SÍNDROMES VERTIGINOSOS PERIFÉRICOS VS CENTRALES

ENTIDAD / HALLAZGO	DURACIÓN DEL VÉRTIGO	GATILLANTE / RELACIÓN POSTURAL	SÍNTOMAS AUDITIVOS / FOCALIDAD	EXAMEN FÍSICO Y CONDUCTA EUNACOM
VPPB (Canalitiasis Posterior)	Segundos (< 60 s; típicamente 10-30 s)	SÍ: desencadenado por giros en cama, acostarse o mirar arriba	Ausencia estricta de hipoacusia, tinnitus o focalidad neurológica	Dix-Hallpike (+) con nistagmo torsional y latencia · Curación con Maniobra de Epley · CERO fármacos
Neuronitis Vestibular	Días continuos (2-3 d intensos; cede en 3 sem)	Continuo espontáneo; se intensifica con movimientos cefálicos	SIN hipoacusia ni tinnitus; solo cortejo vegetativo severo	HINTS periférico: Head Impulse (+) con sacada · Sedantes vestibulares solo 48-72 h + rehabilitación
Enfermedad de Menière	Horas (20 min a 12-24 h)	Episódico espontáneo recurrente	Hipoacusia fluctuante tonos graves + Tinnitus + Plenitud ótica	Audiometría confirma hipoacusia sensorial · Restricción de sal (< 2 g/d) + Hidroclorotiazida + Betahistina
ACV Fosa Posterior (PICA/AICA)	Horas a días continuo	Continuo agudo espontáneo; inicio súbito en paciente vascular	Frecuente diplopía, disartria, disfagia, dismetría, ataxia de tronco	HINTS CENTRAL (INFARCT): Head Impulse NORMAL, nistagmo bidireccional o Skew (+) · RMN y UTAC inmediata (GES 37)
H: Head Impulse Test (Halmagyi)	Prueba del reflejo vestíbulo-ocular (RVO) al rotar rápidamente la cabeza	Periférico: ANORMAL (sacada correctiva hacia el centro)	Central: NORMAL (ojos permanecen en la nariz sin sacada)	¡PARADOJA!: Un impulso cefálico NORMAL en vértigo continuo orienta a ACV isquémico de tronco/cerebelo

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	RESPUESTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Días continuos, sin síntomas auditivos	Neuronitis vestibular	Menière o VPPB

REGLA DE ORO **Segundos y posicional: VPPB** — Dix-Hallpike y Epley, sin fármacos

PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, pregunta **72** (pág. 20) · solucionario pág. 38.

Clase 10.20 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · GERIATRÍA CLÍNICA Y GRANDES SÍNDROMES GERIÁTRICOS

10.21 Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente

★★★ PRIORIDAD ALTA
14 preguntas reales 2013–2025

Máxima rentabilidad geriátrica · Pregunta obligada en urgencias, medicina interna y geriatría

1.07.2.005 Síndrome confusional agudo / delirium — Dx Específico | Tx Completo | Seg Derivar

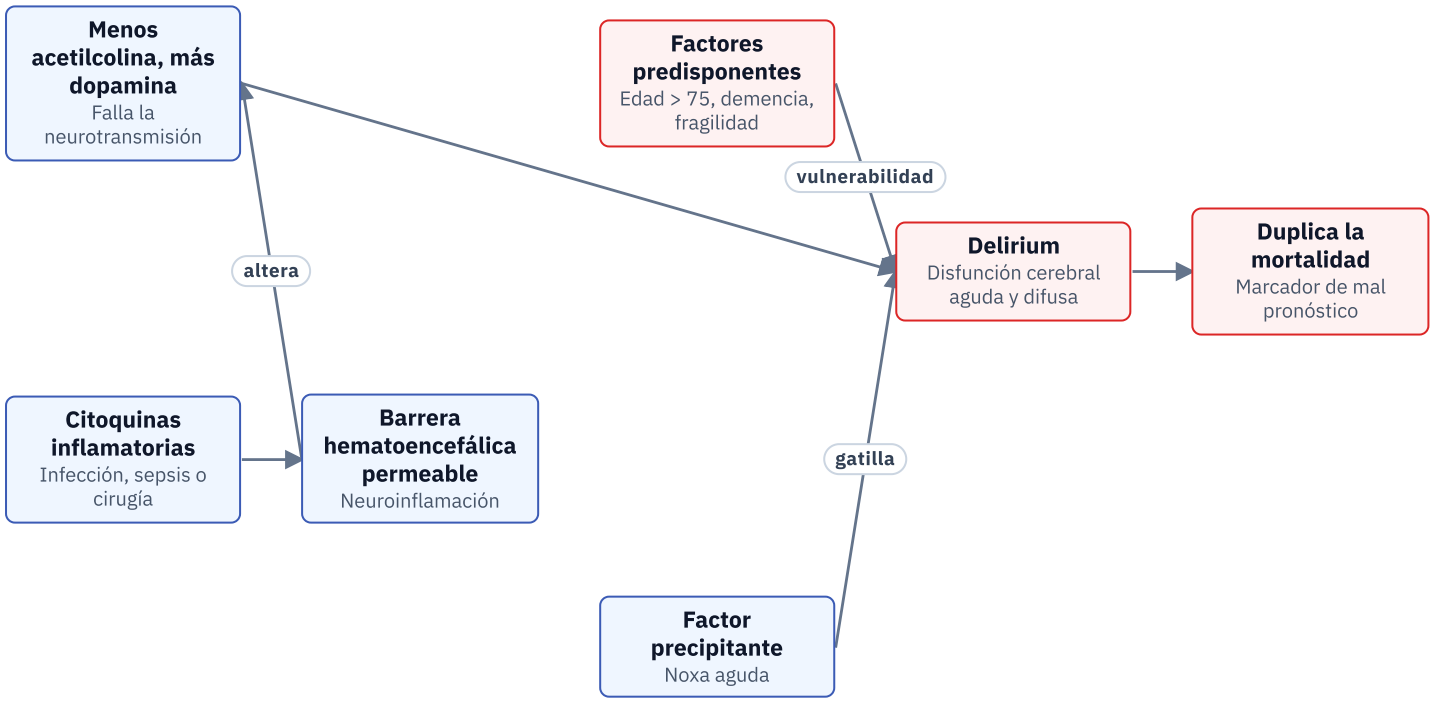
También: Estado confusional agudo (alcohólico, tóxico metabólico) · Complicaciones en el adulto mayor hospitalizado

LO QUE TE PREGUNTAN

- El delirium es una urgencia médica y un marcador pronóstico independiente de mortalidad intrahospitalaria; su diagnóstico es **100%** clínico mediante los criterios CAM.
- Los criterios CAM exigen obligatoriamente inicio agudo y fluctuante (1) + inatención cardinal (2) + pensamiento desorganizado (3) O alteración del nivel de conciencia (4).
- El subtipo hipoactivo (letargia, bradipsiquia, pasividad) es el más frecuente (**50%**), el más inadvertido y el de peor pronóstico vital intrahospitalario.
- Dos causas mecánicas clásicas en EUNACOM que deben descartarse siempre antes de indicar psicofármacos son el globo vesical (retención aguda de orina) y el fecaloma.
- El abordaje no farmacológico multicomponente (HELP: reorientación, audífonos/lentes, sueño natural, presencia familiar) es la primera línea obligatoria; las sujeciones físicas están proscritas.
- La farmacoterapia de rescate (Haloperidol **0.5-1 mg**) se reserva para agitación severa con riesgo vital; en Parkinson y Lewy se usa Quetiapina (Haloperidol está contraindicado); las benzodiacepinas se evitan siempre salvo en Delirium Tremens.

ALGORITMO · ADULTO MAYOR CON CONFUSIÓN AGUDA

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **75–80** (págs. 20–21) · solucionario págs. 39–40.

Clase 10.21 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · GERIATRÍA CLÍNICA Y GRANDES SÍNDROMES GERIÁTRICOS

10.21 Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente

★★★ PRIORIDAD ALTA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 10.21 · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS CAM (CONFUSION ASSESSMENT METHOD) Y PESQUISA CLÍNICA

CRITERIO CAM	DESCRIPCIÓN CLÍNICA OPERATIVA	MÉTODO DE EVALUACIÓN AL LADO DE LA CAMA	INTERPRETACIÓN Y RENDIMIENTO
1. Inicio Agudo y Curso Fluctuante	Cambio súbito respecto al estado cognitivo basal previo (horas o días) con fluctuación diurna y acentuación vespertina/nocturna (sundowning)	Anamnesis rigurosa con familiares y registro de cambios conductuales turno a turno por el personal de enfermería	Requisito OBLIGATORIO (debe estar presente siempre para diagnóstico positivo)
2. Inatención Cardinal	Dificultad marcada para enfocar, sostener o cambiar la atención; el paciente se distrae con estímulos irrelevantes o no sigue el hilo	Pruebas de atención activa: deletrear M-U-N-D-O al revés, meses del año en orden inverso (diciembre a enero) o restar de 7 en 7	Requisito OBLIGATORIO (marca la diferencia biológica con demencias puras)
3. Pensamiento Desorganizado	Discurso incoherente, divagatorio, saltos ilógicos de tema a tema, ideas delirantes transitorias o desorientación temporoespacial franca	Evaluación durante el diálogo clínico espontáneo; preguntas directas de orientación personal, temporal y geográfica	Requisito VARIABLE (debe cumplirse Criterio 3 O Criterio 4 para confirmar)
4. Alteración del Nivel de Conciencia	Cualquier estado distinto a la alerta lúcida normal: hiperalerta/hipervigilancia, somnolencia, letargia, estupor o coma reactivo	Observación del contacto visual, respuesta al llamado verbal suave, al tacto o a estímulos auditivos ambientales	Requisito VARIABLE (CAM Positivo = Criterio 1 + Criterio 2 + [Criterio 3 ó 4])

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Anciano hospitalizado, agitado de noche y tranquilo de día	Delirium	Demencia o psicosis
Alucinaciones o ideas delirantes de inicio agudo	Delirium	Esquizofrenia o trastorno delirante
Delirium con masa hipogástrica mate	Sonda Foley	Antipsicótico o contención

REGLA DE ORO **Agudo + inatención + 3 o 4** — Clínico, sin exámenes

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El síndrome confusional agudo (delirium) es una disfunción cerebral difusa, aguda y fluctuante que afecta hasta al 30-50% de los pacientes adultos mayores hospitalizados en servicios de medicina, cirugía y cuidados intensivos. No constituye una patología psiquiátrica primaria, sino un síntoma cardinal de descompensación sistémica severa. Su reconocimiento inmediato mediante los criterios estandarizados CAM, la búsqueda meticulosa y resolución del factor precipitante subyacente y la instauración de medidas ambientales no farmacológicas multicomponentes son conductas obligatorias para reducir la mortalidad intrahospitalaria, que duplica a la de pacientes comparables no delirantes.

PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **75–80** (págs. 20–21) · solucionario págs. 39–40.

Clase 10.21 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · GERIATRÍA CLÍNICA Y GRANDES SÍNDROMES GERIÁTRICOS

10.22 Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
5 preguntas reales 2013–2025

1.07.1.008 Fragilidad — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Valoración funcional · Prevención del deterioro funcional · Ejercicio en personas mayores · Maltrato en el adulto mayor · Escaras · Desnutrición · Escaras o úlceras por presión · Inmovilidad · Malnutrición · Nutrición en las personas mayores · Valoración afectiva

LO QUE TE PREGUNTAN

- La fragilidad es un síndrome de vulnerabilidad biológica y pérdida de reserva homeostática frente a estresores; es dinámica, prevenible y reversible.
- **El fenotipo de Fried evalúa 5 criterios**: baja de peso involuntaria, fatiga, debilidad muscular (dinamometría), marcha lenta y baja actividad física (**≥ 3**: Frágil; 1-2: Prefrágil).
- El consenso EWGSOP2 define la Sarcopenia Probable únicamente por baja fuerza muscular (dinamometría < **27 kg** hombres / < **16 kg** mujeres o Chair Stand Test > 15 s), lo que autoriza iniciar tratamiento inmediato.
- **La Valoración Geriátrica Integral (VGI) abarca cuatro esferas**: funcional (Barthel, Lawton-Brody), mental (Pfeiffer, Yesavage), clínica-nutricional (MNA) y social (Gijón).
- La intervención de primera línea con mayor nivel de evidencia para revertir fragilidad y sarcopenia es el ejercicio físico multicomponente (fuerza, equilibrio y marcha: Vivifrail) asociado a nutrición proteica (**1.2-1.5 g**/kg/día).

ALGORITMO · ADULTO MAYOR EN CONTROL PREVENTIVO

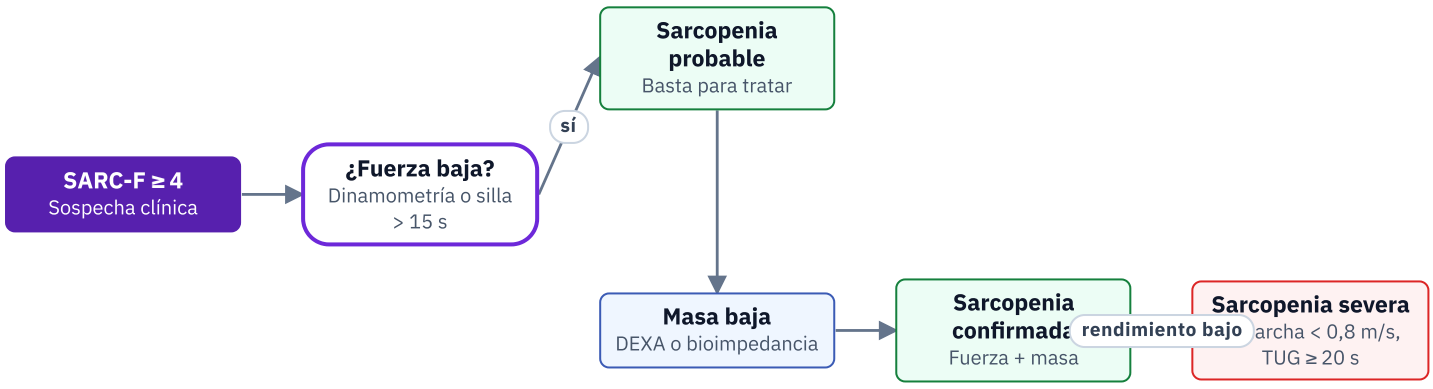


TABLA 10.22 · CRITERIOS DE FRIED DE FRAGILIDAD E INSTRUMENTOS CARDINALES DE LA VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL (VGI)

DOMINIO / CRITERIO	DEFINICIÓN OPERATIVA Y PUNTOS DE CORTE	HERRAMIENTA ESTANDARIZADA / ESCALA	UTILIDAD CLÍNICA EN EUNACOM Y APS
Pérdida Involuntaria de Peso	Pérdida no intencionada ≥ 4.5 kg o ≥ 5% del peso basal en los últimos 12 meses	Registro antropométrico seriado de peso corporal e IMC	Criterio 1 de Fried · Alerta de sarcopenia, desnutrición o neoplasia oculta
Agotamiento / Fatiga Subjetiva	Sensación autorreportada de que todo esfuerzo es insuperable ≥ 3 días/semana	Preguntas estructuradas escala CES-D de depresión	Criterio 2 de Fried · Marcador de declive psicobiológico y anergia
Debilidad Muscular	Fuerza prensil disminuida en dinamometría (< 27 kg hombres, < 16 kg mujeres)	Dinamómetro hidráulico Jamar (o Chair Stand Test > 15 s)	Criterio 3 de Fried · Parámetro cardinal EWGSOP2 para Sarcopenia Probable
Lentitud de la Marcha	Velocidad de marcha habitual reducida: tiempo > 5-6 s para recorrer 4 metros (< 0.8 m/s)	Test de marcha cronometrada de 4 metros a paso usual	Criterio 4 de Fried · Predictor potente de caídas, institucionalización y muerte
Bajo Nivel de Actividad Física	Gasto calórico semanal mínimo (< 383 kcal/sem hombres, < 270 kcal/sem mujeres)	Cuestionario de actividad física para el anciano (Minnesota / IPAQ)	Criterio 5 de Fried · 0 criterios: Robusto; 1-2: Prefrágil; ≥ 3: Frágil

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	RESPUESTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Fuerza de prensión baja, sin imagen	Sarcopenia probable: tratar ya	Esperar DEXA para tratar
Primera función que cae en deterioro cognitivo	Instrumentales (Lawton)	Básicas (Barthel)

REGLA DE ORO **Pérdida de reserva, reversible** — No es edad ni discapacidad

PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **81–84** (pág. 21) · solucionario págs. 40–41.

Clase 10.22 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · GERIATRÍA CLÍNICA Y GRANDES SÍNDROMES GERIÁTRICOS

10.23 Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.07.1.001 Caídas — Dx Específico | Tx Completo | Seg Derivar

También: Trastornos de la marcha · Fractura de cadera · Valoración de la marcha · Hipotensión postural · Adecuación del entorno para personas mayores

LO QUE TE PREGUNTAN

- Más del **90%** de las fracturas de cadera en el adulto mayor son secundarias a caídas a nivel desde su propia altura sobre hueso osteoporótico.
- **La tríada semiológica patognomónica de fractura de cadera es**: extremidad inferior acortada, en rotación externa y con impotencia funcional total para la marcha.
- En fracturas intracapsulares desplazadas (cuello femoral), la ruptura de los vasos retinaculares impone artroplastia protésica (hemiartroplastia/total) por alto riesgo de necrosis avascular.
- En fracturas extracapsulares (pertrocantéricas), la rica vascularización metafisaria permite la consolidación ósea mediante osteosíntesis (clavo cefalomedular o DHS).

ALGORITMO · ADULTO MAYOR QUE SE CAE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

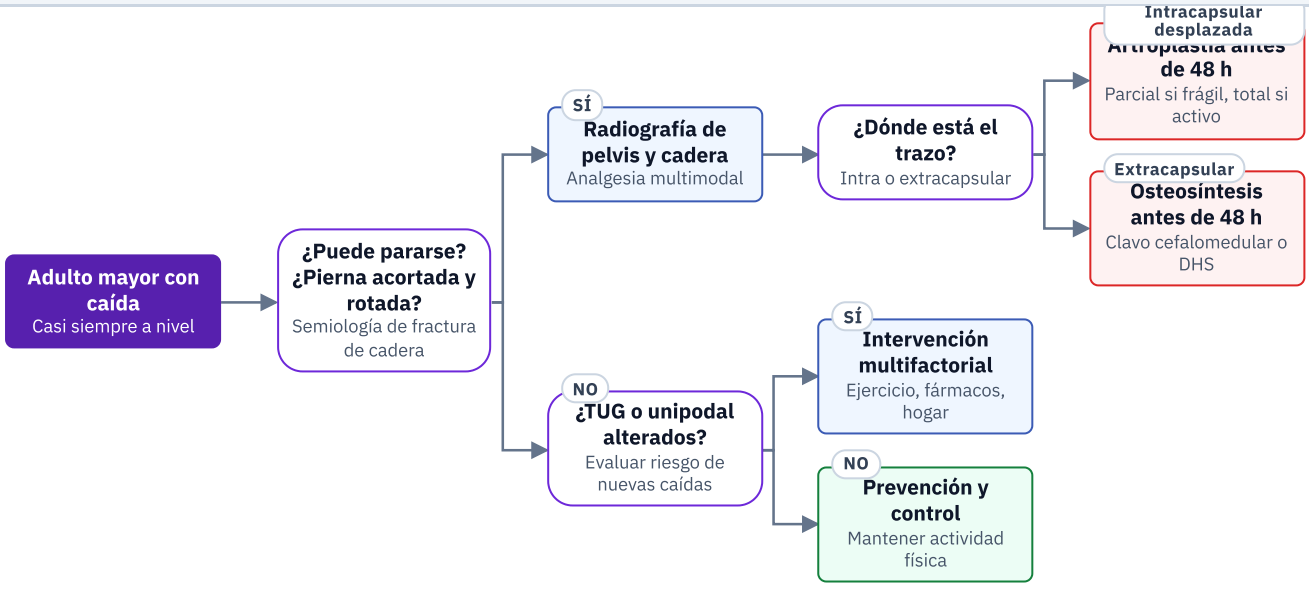


TABLA 10.23 · EVALUACIÓN CLÍNICA DEL RIESGO DE CAÍDAS, FACTORES DETERMINANTES Y PROTOCOLO ORTOGERIÁTRICO DE FRACTURA DE CADERA GES N° 45

COMPONENTE / TEST	CRITERIOS OPERATIVOS Y VALORES DE CORTE	MECANISMO / HALLAZGO CLÍNICO	CONDUCTA MÉDICA INMEDIATA
Test Timed Up and Go (TUG)	Tiempo para levantarse, caminar 3 m, girar y sentarse: > 12-14 s (anormal)	Refleja inestabilidad dinámica, debilidad de cuádriceps y lentitud neuromuscular	Derivar a taller de equilibrio/marcha (Vivifrail) y kinesiología motora
Test Estación Unipodal	Tiempo sosteniéndose en una sola extremidad sin apoyo: < 5 segundos (anormal)	Pérdida de equilibrio estático y respuesta propioceptiva protectora ante tropiezos	Alto riesgo de caída; evaluar uso de bastón o ayuda técnica de marcha
Factores Intrínsecos	Déficit visual, neuropatía periférica, sarcopenia, hipotensión ortostática	Caída de PAS ≥ 20 mmHg o PAD ≥ 10 mmHg a los 3 min de bipedestación	Ajustar dosis antihipertensivas, hidratación, medias de compresión gradual
Factores Fármacos de Riesgo	Benzodiacepinas, antidepresivos, antipsicóticos, betabloqueadores (atenolol)	Causan sedación, ataxia, bradicardia, retardo de reflejos posturales e hipotensión	Conciliación farmacológica y desprescripción gradual de psicotrópicos

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	RESPUESTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Intracapsular desplazada en anciano	Artroplastia	Osteosíntesis

REGLA DE ORO **Fármacos: factor modificable clave** — Psicofármacos, atenolol, diuréticos

PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **85–87** (págs. 21–22) · solucionario pág. 41.

Clase 10.23 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · GERIATRÍA CLÍNICA Y GRANDES SÍNDROMES GERIÁTRICOS

10.24 Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor

★★★ PRIORIDAD ALTA
8 preguntas reales 2013–2025

1.07.3.007 Manejo de fármacos en la persona mayor — Conocimiento general

También: Incontinencia urinaria

LO QUE TE PREGUNTAN

- La polifarmacia (**≥ 5 fármacos**) y los cambios farmacocinéticos (aumento de grasa corporal, declive renal) multiplican el riesgo de RAM y caídas.
- Los Criterios de Beers y STOPP contraindican benzodiacepinas, anticolinérgicos potentes y AINEs crónicos en la persona mayor.
- En adultos mayores diabéticos (> **75 años**), la glibenclamida debe suspenderse de inmediato ante valores de HbA1c < **8%** por riesgo de hipoglicemia severa.
- La incontinencia de urgencia (vejiga hiperactiva) se maneja con ejercicios vesicales y antimuscarínicos (Oxibutinina) o Mirabegrón (preferido si hay riesgo cognitivo).
- La incontinencia por rebose se diagnostica por un residuo postmiccional elevado (> **150-200 mL**); los anticolinérgicos están formalmente contraindicados en este subtipo.

ALGORITMO · ADULTO MAYOR CON INCONTINENCIA URINARIA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

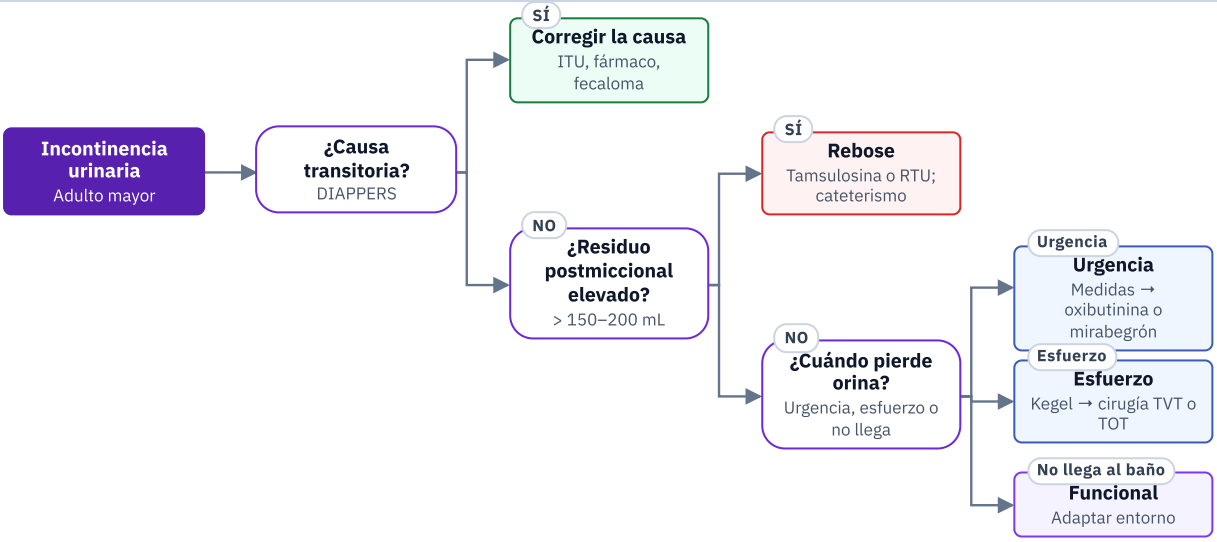


TABLA 10.24 · MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO SEGÚN CRITERIOS DE BEERS / STOPP Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA INCONTINENCIA URINARIA GERIÁTRICA

FÁRMACO / SÍNDROME	RIESGO GERIÁTRICO PRINCIPAL (BEERS/STOPP)	MECANISMO FISIOPATOLÓGICO ADVERSO	RECOMENDACIÓN CLÍNICA Y ALTERNATIVA SEGURA
Benzodiacepinas (Diazepam, Lorazepam, Clonazepam)	Aumento de caídas, fracturas de cadera, delirium y sedación residual diurna	Semivida prolongada por aumento de grasa corporal y sensibilidad GABAérgica aumentada	EVITAR siempre · Retiro gradual y pautado; higiene del sueño no farmacológica
AINEs (Ibuprofeno, Diclofenaco, Ketorolaco, Naproxeno)	Hemorragia digestiva alta, falla renal aguda, hipertensión arterial y descompensación IC	Inhibición de COX-1 gástrica y de prostaglandinas vasodilatadoras renales	EVITAR uso crónico · Analgesia de 1ª línea: Paracetamol (hasta 3 g/d); 2ª línea: Tramadol
Sulfonilureas Prolongadas (Glibenclamida)	Hipoglicemia severa, prolongada e inadvertida con daño neurológico	Aclaramiento renal disminuido y acumulación de metabolitos activos hipoglicemiantes	EVITAR en ancianos · Suspender si HbA1c < 8%; preferir Metformina o iDPP-4
Anticolinérgicos (Clorfenamina, Pargeverina, Amitriptilina)	Constipación, retención urinaria aguda, boca seca, glaucoma agudo y delirium	Bloqueo competitivo no selectivo de receptores muscarínicos centrales y periféricos	EVITAR · En alergias usar antihistamínicos de 2ª generación (Loratadina/Cetirizina)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Anciano con glibenclamida y HbA1c normal	Suspender glibenclamida	Mantener o subir dosis

REGLA DE ORO **Creatinina normal engaña** — Calcular Cockcroft-Gault

PRACTICA **Libro Gordo Neurología**, preguntas **88–90** (pág. 22) · solucionario págs. 41–42.

Clase 10.24 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · GERIATRÍA CLÍNICA Y GRANDES SÍNDROMES GERIÁTRICOS

10.25 Cardiovascular en el Adulto Mayor: Hipertensión Arterial y Evento Coronario

★☆☆
PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

Alta rentabilidad · HTA sistólica aislada, metas individualizadas y ortostatismo, y el infarto del anciano con presentación atípica (disnea, síncope, delirium)

1.07.1.009 **Hipertensión arterial** — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Evento coronario en adulto mayor

LO QUE TE PREGUNTAN

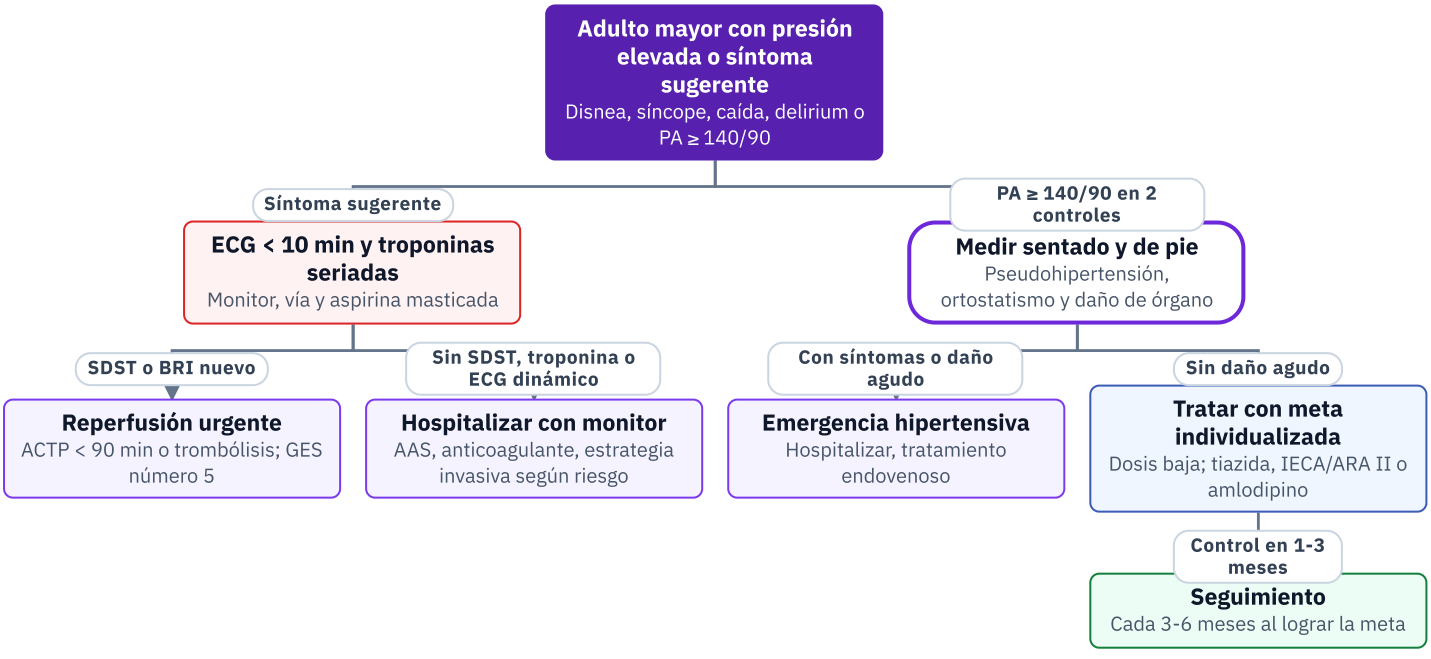
- En el adulto mayor predomina la HTA sistólica aislada; tratarla reduce ACV, insuficiencia cardiaca y mortalidad, incluso después de los **80 años**.
- Meta general menos de 140/**90 mmHg**; en mayores de **80 años** o frágiles, PAS 140 a 150, sin bajar de 120 ni provocar ortostatismo.
- **Se inicia en dosis baja y se sube lento; primera línea**: tiazida o afín, IECA/ARA II y amlodipino. Evitar alfa-bloqueadores, clonidina y metildopa.
- Medir la PA de pie y descartar pseudohipertensión; la hipertensión sin síntomas ni daño agudo no es urgencia y no se baja de forma brusca.
- **El infarto del anciano suele ser atípico**: disnea, síncope, caída, náuseas o delirium; ante la duda, ECG en **10 minutos** y troponinas seriadas.
- **La edad no contraindica la reperfusión**: angioplastia en menos de **90 minutos** o trombólisis, con mitad de dosis de tenecteplasa sobre los **75 años**.
- Ajustar anticoagulantes a la función renal, medir el riesgo de sangrado y acordar objetivos de cuidado según fragilidad y preferencias.



RETINOPATÍA HIPERTENSIVA
Harrison 21.ª ed., Fig. 32-7, p. 263

ALGORITMO · ADULTO MAYOR: PRESIÓN ELEVADA O SÍNTOMA SUGERENTE DE INFARTO

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción



PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Neurología**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 10.25 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · GERIATRÍA CLÍNICA Y GRANDES SÍNDROMES GERIÁTRICOS

10.25 Cardiovascular en el Adulto Mayor: Hipertensión Arterial y Evento Coronario

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★☆☆ PRIORIDAD BAJA

TABLA 10.25 · HTA Y SÍNDROME CORONARIO EN EL ADULTO MAYOR: CLAVES DE DIAGNÓSTICO Y CONDUCTA

SITUACIÓN	DATO CLÍNICO CLAVE	CONDUCTA DEL MÉDICO GENERAL	PRECAUCIÓN O DERIVACIÓN
HTA sistólica aislada	PAS 140 mmHg o más con PAD menor de 90; presión de pulso amplia	Tiazida, IECA/ARA II o amlodipino en dosis baja; sal menor de 5 g	Medir de pie: evitar el ortostatismo y la PAS menor de 120
Meta de presión	Autovalente 65-79 años: menos de 140/90; mayor de 80 años o frágil: PAS 140-150	Individualizar según fragilidad y tolerancia	No bajar la PA de forma brusca en el asintomático
Fármacos que se evitan	Alfa-bloqueadores, clonidina, metildopa, AINE	Preferir los de primera línea	Beers: riesgo de hipotensión, sedación y daño renal
Infarto atípico	Disnea, síncope, caída, delirium o dolor epigástrico	ECG en menos de 10 minutos y troponinas seriadas	La edad no contraindica el estudio ni el tratamiento
IAM con SDST	Supradesnivel del ST o BRI nuevo	AAS + reperfusión (ACTP en 90 min o trombólisis)	Mayor de 75 años: mitad de dosis de tenecteplasa, sin bolo de enoxaparina
Seguimiento posinfarto	Estatina, antiagregantes, betabloqueador, IECA	Rehabilitación cardiaca, control de factores de riesgo	Ajustar a función renal, riesgo de sangrado y fragilidad

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

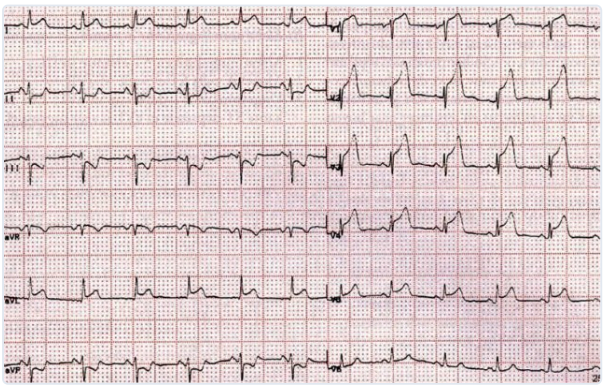
SITUACIÓN	CONDUCTA	ERROR TÍPICO
85 años, PA 145/75 con tratamiento	Mantener: meta PAS 140-150	Intensificar el tratamiento
PA elevada sin síntomas ni daño agudo	Fármacos orales, en horas o días	Bajarla de golpe, como emergencia
Hipotensión o IAM de VD	Sin nitroglicerina	Nitrato sublingual de rutina

REGLA DE ORO **Meta < 140/90; > 80 años o frágil: PAS 140-150** — No bajar PAS < 120 ni PAD < 60

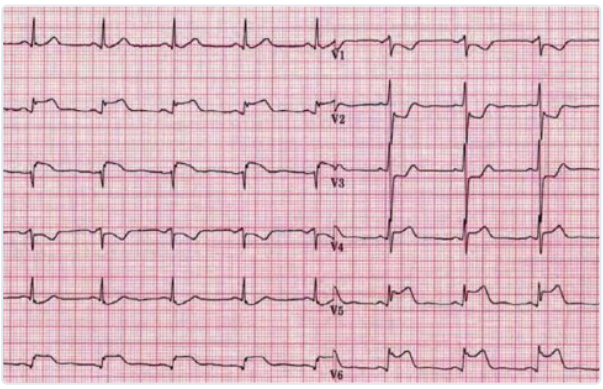
¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La hipertensión arterial afecta a más de 70% de los mayores de 65 años y es el principal factor de riesgo modificable de ACV, insuficiencia cardiaca, fibrilación auricular y demencia vascular. En el anciano predomina la hipertensión sistólica aislada por rigidez arterial, y el tratamiento debe ser cuidadoso: dosis bajas, metas individualizadas y vigilancia del ortostatismo. El síndrome coronario agudo en el adulto mayor suele presentarse sin dolor típico, con disnea, síncope, delirium o caída, tiene mayor mortalidad y más complicaciones, y por eso exige un ECG ante cualquier síntoma sugerente y un manejo inicial sin demoras ni prejuicio por la edad.

ASÍ SE VE · FOTOS DE LA CLASE



IAM ANTERIOR CON SDST
ECG from Basics to Essentials, ejemplo 28



IAM INFERIOR CON SDST
ECG from Basics to Essentials, ejemplo 11

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Neurología**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 10.25 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · GERIATRÍA CLÍNICA Y GRANDES SÍNDROMES GERIÁTRICOS

10.26 Cuidados Paliativos, Dolor Crónico y Final de Vida

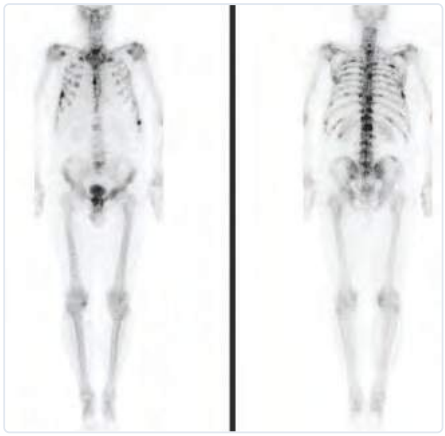
★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.07.3.003 **Manejo, cuidado y acompañamiento de final de vida** — Conocimiento general

También: Manejo del dolor crónico y paliativo · Manejo del paciente terminal oncológico

LO QUE TE PREGUNTAN

- Los cuidados paliativos no se limitan al cáncer ni a los últimos días: abarcan lo físico, psicológico, social y espiritual (dolor total) y se integran al tratamiento de la enfermedad.
- **Escalera analgésica de la OMS**: no opioides, opioide débil y opioide potente, con adyuvantes; la morfina oral se titula con dosis de rescate.
- Todo paciente con opioide recibe laxante regular desde el inicio; el temor a la adicción no debe limitar su uso en dolor oncológico.
- En insuficiencia renal se evita la morfina; la dosis subcutánea de morfina es la mitad de la oral.
- **Dolor neuropático**: gabapentinoides, antidepresivos o duloxetina; dolor óseo: AINE, dexametasona y radioterapia.



METÁSTASIS ÓSEAS MÚLTIPLES
Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 75.27b (gammagrafía)

ALGORITMO · PACIENTE CON ENFERMEDAD AVANZADA Y DOLOR: CONDUCTA PALIATIVA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

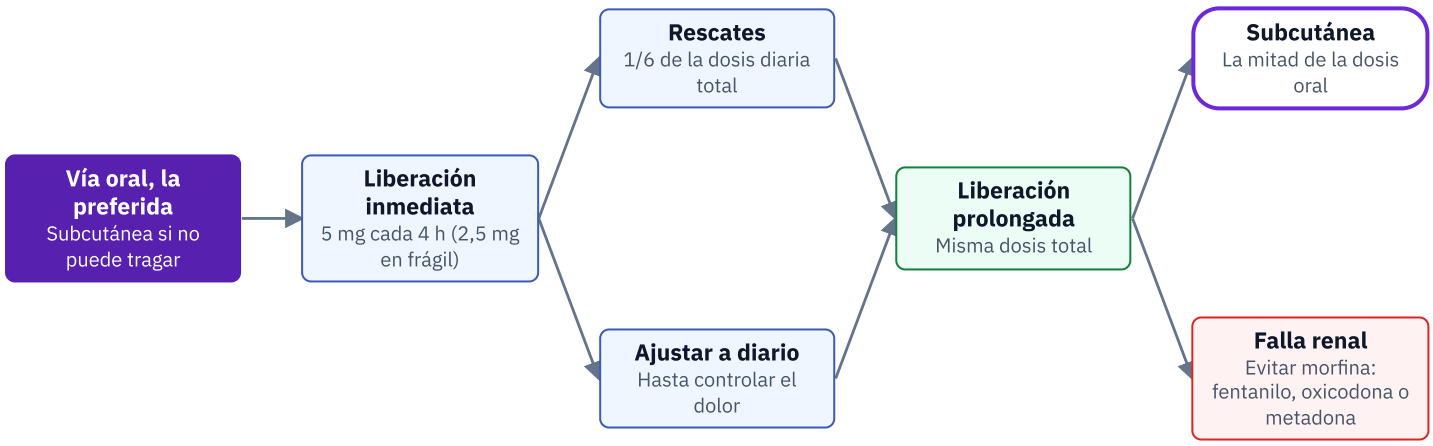


TABLA 10.26 · MANEJO DEL DOLOR Y DE LOS SÍNTOMAS EN CUIDADOS PALIATIVOS

PROBLEMA	PRIMERA ELECCIÓN	ALTERNATIVA O ADYUVANTE	PRECAUCIÓN O CLAVE
Dolor leve (1-3)	Paracetamol hasta 3 g al día	AINE por corto plazo con gastroprotección	AINE en anciano: función renal y riesgo digestivo
Dolor moderado (4-6)	Opioide débil (tramadol, codeína) + paracetamol	Morfina en dosis bajas	Tramadol: hiponatremia, convulsiones y serotoninérgico
Dolor intenso (7-10)	Morfina oral de liberación inmediata, rescates y titulación	Fentanilo transdérmico si el dolor es estable	Laxante siempre; en insuficiencia renal evitar morfina
Dolor neuropático	Gabapentina o pregabalina	Amitriptilina, nortriptilina o duloxetina	Dosis bajas en el anciano; la carbamazepina sirve en trigémino
Dolor óseo	AINE + opioide	Dexametasona, radioterapia, bifosfonatos	Radioterapia es muy eficaz en metástasis dolorosas
Disnea	Morfina en dosis baja	Ventilador, oxígeno si hay hipoxemia, benzodiacepina	La disnea refractaria puede requerir sedación paliativa
Estertores de la agonía	Butilbromuro de hioscina o escopolamina SC	Cambio de posición	No aspirar secreciones profundas
Agitación terminal	Tratar causas reversibles + haloperidol	Midazolam SC si no cede	La indicación es el síntoma, no acortar la vida

REGLA DE ORO **Paliativos: dolor total, no solo cáncer** — Eutanasia no; limitar el esfuerzo sí

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Neurología**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 10.26 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

Números que tienes que saber

Cortes, dosis, tiempos y metas de los 26 temas, tal como aparecen en el libro y en las clases. Las cifras van en negrita.

DATO	TIPO
BLOQUE 01 · ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR Y URGENCIAS NEUROVASCULARES	
10.1 Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES	pág. 4
< 180/105 por **24 horas** — Para evitar la hemorragia	CORTE
PA < 185/110 antes de partir — Si no, bajarla primero	CORTE
Normotermia y $SatO_2$ > **94 %** — Paracetamol si T° > **37,5 °C**	CORTE
10.2 Ataque Isquémico Transitorio (AIT): Score ABCD2, Estratificación de Riesgo Precoz y Prevención Secundaria	pág. 6
A · Edad **≥ 60 años** — 1 punto	CORTE
Duran < **60 min** — Típicamente **5 a 20 minutos**	CORTE
Duración **≥ 60 min**: 2 — **10 a 59 min**: 1 · < **10 min**: 0	CORTE
10.3 Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos	pág. 7
Volumen **≥ 30 mL**: 1 — Sangre intraventricular: 1	DOSIS
Infratentorial: 1 — Edad **≥ 80 años**: 1	CORTE
Vía aérea y oxigenación — Intubar si Glasgow **≤ 8**	CORTE
10.4 Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino	pág. 9
PAS < **160 mmHg** — Labetalol o nicardipino EV	CORTE
Asegurar en **24–72 h** — Coils de elección · PAS < 160	CORTE
10.5 Trombosis Venosa Cerebral: Factores Protrombóticos, Sospecha Clínica, Neuroimagen y Anticoagulación Plena	pág. 11
Enoxaparina plena aunque haya sangre — **1 mg/kg** cada **12 horas**	DOSIS
Mujer de **20 a 45 años** — Más del **75–80 %** de los casos	CORTE
Convulsiones en **35–40 %** — Mucho más que en el infarto arterial	CORTE
BLOQUE 02 · CEFALEAS, SÍNDROMES CONVULSIVOS Y EPILEPSIA	
10.6 Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional	pág. 12
Amitriptilina **10–25 mg** de noche — Titular hasta **50–75 mg**	DOSIS
Sumatriptán **50–100 mg** VO — O **6 mg** SC, actúa en **10–15 min**	DOSIS
10.7 Cefalea en Racimos (Cluster) y Neuralgia del Trigémino: Diagnóstico Diferencial, Manejo Agudo y Preventivo	pág. 14
+ Sumatriptán **6 mg** SC — O zolmitriptán **5 mg** nasal	DOSIS
Verapamilo **240–960 mg**/día — ECG seriado: bloqueo AV, bradicardia	DOSIS
10.8 Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES	pág. 15
Rash y Stevens-Johnson — Iniciar **25 mg**/día, subir cada **2 semanas**	DOSIS
Cinética no lineal · **10–20 mcg**/mL — Un pequeño aumento dispara el nivel	DOSIS
10.9 Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo	pág. 17
20 mg/kg EV — En adulto: **1.250 a 1.500 mg**	DOSIS
40 mg/kg EV · máximo **3.000 mg** — En **10 minutos**	DOSIS
10.10 Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas	pág. 19
Abstinencia alcohólica — A las **24–48 h** del cese	TIEMPO
Todo normal: sin FAE, sin manejar — Por **6 a 12 meses**	TIEMPO
BLOQUE 03 · TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS	
10.11 Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras	pág. 20
Inicio: 100/**25 mg** cada **8 h** — Titular de a poco	DOSIS
Fraccionar las tomas — Entacapona **200 mg** con cada toma	DOSIS

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
10.25 Cardiovascular en el Adulto Mayor: Hipertensión Arterial y Evento Coronario (cont.)	pág. 40
Hiposmia o anosmia — En más del **80–90 %**	CORTE
10.12 Parkinsonismos Secundarios, Farmacológicos y Síndromes Parkinson-Plus	pág. 22
Haloperidol, clorpromazina, flufenazina — Risperidona en dosis > **2–4 mg**/día	DOSIS
10.13 Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos	pág. 23
Propranolol **40–160 mg**/día — En 2 a 3 tomas	DOSIS
Ambos reducen la amplitud — Entre 50 y **70 %**	CORTE
10.14 Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve	pág. 24
Déficit objetivo — Típicamente memoria · MoCA < 26	META
Autónomo: DCL · Dependiente: demencia — Pfeffer **≥ 6**	CORTE
Galantamina **8–24 mg**/día — Liberación prolongada	DOSIS
10.15 Demencia Vascular, Demencia por Cuerpos de Lewy y Demencia Frontotemporal	pág. 26
Aspirina **100 mg** al día — Anticoagular si hay fibrilación auricular	DOSIS
Segunda demencia degenerativa — **10 a 15 %** de los casos	CORTE
Debut entre 45 y **65 años** — Primera causa de demencia bajo 65	CORTE
BLOQUE 04 · PATOLOGÍA NEUROMUSCULAR, DESMIELINIZANTE Y NERVIO PERIFÉRICO	
10.16 Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo	pág. 27
Plasmaféresis — **200 a 250 mL/kg** en 4 a 5 sesiones	DOSIS
CVF menor de **15 mL/kg** — Intubación electiva inmediata	DOSIS
Enoxaparina **40 mg** SC al día — Más compresión neumática	DOSIS
10.17 Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma	pág. 29
Piridostigmina **30 a 60 mg** c/**4-6 h** — Máximo **360 mg** al día	DOSIS
Anti-MuSK — **30 a 40 %** de los seronegativos	CORTE
Hombre de **50 a 60 años** — Más asociado a timoma	CORTE
10.18 Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad	pág. 31
Déficit nuevo o agravado >**24 h** — Sin fiebre ni infección	CORTE
≥2 bandas IgG en LCR, no en suero — Patrón tipo 2; positivas en **85–95%**	CORTE
10.19 Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento	pág. 33
>**85%** mejora en **3 semanas** — Recuperación completa a los **3–6 meses**	CORTE
Prednisona <**72 h** + proteger el ojo — Antiviral solo en Ramsay Hunt	CORTE
Prednisona + valaciclovir — **1 g** c/**8 h** por **7 a 10 días**	DOSIS
10.20 Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central: VPPB, Maniobras de Epley y Protocolo HINTS	pág. 34
Poca sal, diurético y betahistina — Sal <**2 g**/día; betahistina **24 mg** c/**12 h**	DOSIS
Sedantes vestibulares solo **48–72 h** — Dimenhidrinato **50 mg** c/**8 h**	DOSIS
BLOQUE 05 · GERIATRÍA CLÍNICA Y GRANDES SÍNDROMES GERIÁTRICOS	
10.21 Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente	pág. 35
Hipoactivo: **50 %** — El más frecuente y el más grave	CORTE
Hiperactivo y mixto: **25 %** cada uno — Agitación y alucinaciones visuales	CORTE
10.22 Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)	pág. 37
Yesavage GDS-15: **≥ 5** — Sugiere depresión	CORTE
MNA: < 17 desnutrición — 17 a 23,5: riesgo	CORTE
10.23 Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES	pág. 38
Enoxaparina **40 mg** SC al día — Por **28 a 35 días**	DOSIS

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
10.25 Cardiovascular en el Adulto Mayor: Hipertensión Arterial y Evento Coronario (cont.)	pág. 40
< 10 s normal · > 12–14 s riesgo — > 20 s: fragilidad marcada	CORTE
10.24 Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor	pág. 39
HbA1c normal o < **7–7,5 %**: suspender — Meta en > **75 años**: < **8–8,5 %**	META
Mirabegrón **25–50 mg**/día — Elección si hay riesgo cognitivo	DOSIS
Antimuscarínicos — Oxibutinina **2,5–5 mg** c/**8–12 h**, tolterodina	DOSIS
10.25 Cardiovascular en el Adulto Mayor: Hipertensión Arterial y Evento Coronario	pág. 40
Angioplastia primaria < **90 min** — Desde el primer contacto	CORTE
Autovalente: < 140/90 — **65-79 años**: PAS 130-139 si lo tolera	CORTE

Fármacos de primera línea

Esquemas de elección por enfermedad, tomados de las tarjetas de tratamiento de cada clase. Al final de la sección, las garantías GES.

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE
10.1 Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES		pág. 4
Antitrombóticos · NIHSS ≤ 3: doble antiagregación	**AAS + clopidogrel por 21 días**	
Antitrombóticos	**Atorvastatina 80 mg**	Independiente del colesterol
10.4 Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino		pág. 9
Primer objetivo · Antes de asegurar	**Analgesia y antieméticos**	Opioides, ondansetrón: evitar Valsalva
10.5 Trombosis Venosa Cerebral: Factores Protrombóticos, Sospecha Clínica, Neuroimagen y Anticoagulación Plena		pág. 11
Después de la fase aguda · Anticoagulación oral	**Acenocumarol o warfarina**	INR 2 a 3 · o dabigatrán, rivaroxabán
10.6 Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional		pág. 12
Cefalea tensional · La crisis	**Paracetamol, AINE o aspirina**	Paracetamol **1 g** · ibuprofeno **400 mg** · naproxeno **500 mg**
La crisis · Crisis leve a moderada	**+ Metoclopramida 10 mg**	O domperidona: por la gastroparesia
Status migrañoso · Parenteral	**Suero, metoclopramida, ketorolaco**	Metoclopramida **10 mg** EV · ketorolaco **30 mg** EV
Status migrañoso · Parenteral	**Dexametasona y magnesio**	Dexametasona **8–10 mg** · sulfato de Mg **1–2 g**
10.7 Cefalea en Racimos (Cluster) y Neuralgia del Trigémino: Diagnóstico Diferencial, Manejo Agudo y Preventivo		pág. 14
Crisis aguda · Nada oral	**Analgésicos, opioides y triptán oral: inútiles**	
10.8 Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES		pág. 15
Los clásicos y sus toxicidades · Carbamazepina	**Baja anticonceptivos, warfarina, estatinas**	
10.9 Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo		pág. 17
Estatus refractario · Anestésicos	**Midazolam en infusión**	Más estable hemodinámicamente
Las mismas fases, con dosis por peso · Fases 1 y 2	**Midazolam IM 0,2 mg/kg**	Máx. **10 mg** · bucal o IN **0,2–0,5 mg/kg**
10.13 Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos		pág. 23
Temblor esencial · Primera línea	**Propranolol 40–160 mg/día**	En 2 a 3 tomas
10.15 Demencia Vascular, Demencia por Cuerpos de Lewy y Demencia Frontotemporal		pág. 26
Prevenir el próximo escalón · Control agresivo del riesgo vascular	**Presión, diabetes y estatina de alta potencia**	
Prevenir el próximo escalón	**Aspirina 100 mg al día**	Anticoagular si hay fibrilación auricular
10.16 Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo		pág. 27
Inmunoterapia · Las dos opciones	**Inmunoglobulina EV**	**0,4 g**/kg/día por **5 días** (total **2 g**/kg)
10.17 Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma		pág. 29
Otros fármacos	**Betabloqueadores y antiarrítmicos**	Propranolol, procainamida, quinidina
10.18 Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad		pág. 31
El brote · Metilprednisolona EV	**Proteger el estómago con omeprazol**	
10.19 Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento		pág. 33
Parálisis central y Ramsay Hunt · Síndrome de Ramsay Hunt	**Prednisona + valaciclovir**	**1 g** c/**8 h** por **7 a 10 días**

Fármacos de primera línea · continuación

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE	
10.26 Cuidados Paliativos, Dolor Crónico y Final de Vida (cont.)			pág. 42
Parálisis de Bell · Corticoide precoz	**Prednisona 60 mg/día por 7 días**	O **1 mg/kg**/día; luego descenso	
Parálisis de Bell · Corticoide precoz	**Antivirales: no de rutina**	Solo en Ramsay Hunt	
10.20 Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central: VPPB, Maniobras de Epley y Protocolo HINTS			pág. 34
Enfermedad de Menière	**Poca sal, diurético y betahistina**	Sal <**2 g**/día; betahistina **24 mg** c/**12 h**	
10.21 Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente			pág. 35
I WATCH DEATH · La causa más prevenible	**Benzodiacepinas y opioides**	También corticoides, digoxina, anticonvulsivantes	
10.22 Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)			pág. 37
Nutrición	**Vitamina D si está baja**	Colecalciferol **800–2000 UI**/día	
Desnutrición en la persona mayor · Escalonado	**Realimentar lento: riesgo de hipofosfemia; tiamina previa**		
10.23 Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES			pág. 38
El factor modificable más potente · Psicofármacos	**Benzodiacepinas, antidepresivos, antipsicóticos, hipnóticos Z**		
El factor modificable más potente · Antihipertensivos e hipoglicemiantes	**Atenolol, diuréticos, sulfonilureas**		
Fractura de cadera en mayores de 65 · Manejo perioperatorio	**Bloqueo de fascia ilíaca + paracetamol**		
Fractura de cadera en mayores de 65 · Manejo perioperatorio	**Enoxaparina 40 mg SC al día**	Por **28 a 35 días**	
10.24 Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor			pág. 39
Los fármacos que se evitan · AINE	**Paracetamol, luego tramadol**	En HTA o IC, antes que un AINE	
10.25 Cardiovascular en el Adulto Mayor: Hipertensión Arterial y Evento Coronario			pág. 40
Fármacos · Primera línea	**Tiazida o afín**	HCTZ **12,5-25 mg** · hiponatremia, hipoK, ↑ úrico	
Monitor, aspirina y traslado · Lo que haces tú	**Aspirina 250-500 mg masticada**	Si no hay contraindicación	
Monitor, aspirina y traslado · Lo que haces tú	**Morfina en dosis bajas si persiste dolor**		
Seguimiento completo	**Estatina de alta intensidad**	Betabloqueador, IECA o ARA II	
10.26 Cuidados Paliativos, Dolor Crónico y Final de Vida			pág. 42
Evaluar el dolor y subir la escalera · Escalera de la OMS	**1. No opioides**	Paracetamol, AINE	
Evaluar el dolor y subir la escalera · Escalera de la OMS	**2. Opioides débiles**	Tramadol, codeína ± no opioides	
Evaluar el dolor y subir la escalera · Escalera de la OMS	**3. Opioides potentes**	Morfina, fentanilo, oxicodona, metadona	
Adyuvantes según el tipo de dolor · Neuropático	**Antidepresivos: amitriptilina, nortriptilina, duloxetina**		

GES de Neurología y Geriatría

Garantías Explícitas en Salud que aparecen en los temas de esta especialidad: el EUNACOM pregunta la edad, el examen y el plazo que garantizan.

Fármacos de primera línea · continuación

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 37): Ataque Cerebrovascular Isquémico en personas de 15 años y más · Sospecha con atención de urgencia inmediata, confirmación diagnóstica con neuroimagen en ≤ 30 minutos desde el ingreso, trombolisis endovenosa dentro de 4.5 horas y trombectomía mecánica en centros terciarios de referencia.**

Tema **10.1** · Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES
1.10.2.007 · 1.10.4.001 · 1.10.3.002
pág. 4

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 37): Accidente Isquémico Transitorio · Hospitalización inmediata de pacientes con riesgo moderado a alto (ABCD² ≥ 4) para neuroimagen urgente, ecocardiograma, dúplex carotídeo y prevención secundaria precoz.**

Tema **10.2** · Ataque Isquémico Transitorio (AIT): Score ABCD2, Estratificación de Riesgo Precoz y Prevención Secundaria
1.10.2.007 · 1.10.3.002 · 4.01.1.046
pág. 6

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Manejo de Emergencias Neuroquirúrgicas y Cuidados Intensivos en Accidente Cerebrovascular Hemorrágico · Derivación inmediata a UCI/Neurocirugía.**

Tema **10.3** · Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos
1.10.2.007 · 1.10.2.009 · 1.10.4.001
pág. 7

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 37 / Urgencias Neuroquirúrgicas): Hemorragia Subaracnoidea por Rotura de Aneurisma Cerebral · Confirmación con angioTAC o panangiografía y exclusión aneurismática (coils vs clip) urgente.**

Tema **10.4** · Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino
1.10.2.008 · 1.10.2.001 · 1.10.5.002
pág. 9

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 28): Epilepsia no refractaria en personas de 15 años y más · Sospecha con atención médica y solicitud de EEG en ≤ 30 días, confirmación diagnóstica con especialista e inicio inmediato de FAE garantizado por canasta pública/privada.**

Tema **10.8** · Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES
1.10.1.007 · 1.10.4.005
pág. 15

GES **Urgencia Médica GES / Riesgo Vital Inmediato · Rescate de urgencia prehospitalario y hospitalario en Unidad de Paciente Crítico (UPC) con monitorización electroencefalográfica continua.**

Tema **10.9** · Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo
1.10.2.017 · 1.10.2.003 · 2.01.2.027
pág. 17

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 67): Enfermedad de Parkinson en personas de todas las edades · Diagnóstico integral por especialista (neurólogo) dentro de 60 días desde la sospecha clínica, confirmación diagnóstica, acceso garantizado a tratamiento farmacológico (Levodopa/Carbidopa, agonistas dopaminérgicos, inhibidores COMT y MAO-B) dentro de 20 días desde confirmación, rehabilitación motora multidisciplinaria y acceso a Cirugía de Estimulación Cerebral Profunda (DBS) en centros terciarios de referencia.**

Tema **10.11** · Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras
1.10.1.006 · 1.10.1.027
pág. 20

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 85): Enfermedad de Alzheimer y otras demencias · Evaluación diagnóstica médica integral dentro de 60 días desde la sospecha, test cognitivos estandarizados (MMSE, MoCA, Pfeffer), acceso garantizado a fármacos específicos (Donepezilo, Memantina), plan de cuidados multidisciplinario y apoyo psicosocial al cuidador para prevenir el síndrome de sobrecarga.**

Tema **10.14** · Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve
1.10.1.005 · 1.07.1.003 · 1.10.1.003
pág. 24

Fármacos de primera línea · continuación

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 85): Cobertura integral para demencias no Alzheimer en personas de cualquier edad · Abordaje multidisciplinario y manejo de síntomas conductuales.**

Tema **10.15** · Demencia Vascular, Demencia por Cuerpos de Lewy y Demencia Frontotemporal
`1.10.1.005` · `1.07.1.003`
pág. **26**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 69): Esclerosis Múltiple Remitente Recurrente (EMRR) · Garantiza acceso a diagnóstico confirmatorio por Resonancia Magnética y punción lumbar en ≤ 60 días, tratamiento del brote agudo y terapia modificadora de la enfermedad (FME) de primera y segunda línea. Cobertura complementaria de fármacos biológicos de alta eficacia por Ley Ricarte Soto.**

Tema **10.18** · Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad
`1.10.1.008` · `1.10.4.002` · `1.10.4.007`
pág. **31**

GES **Atención en Servicio de Urgencia y APS · En caso de confirmación de Vértigo Central o ACV de fosa posterior (troncoencéfalo / cerebelo) ingresa de inmediato a Garantía GES N° 37.**

Tema **10.20** · Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central: VPPB, Maniobras de Epley y Protocolo HINTS
`1.10.1.025` · `1.10.1.024` · `6.03.2.017`
pág. **34**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 45): Tratamiento Quirúrgico de la Fractura de Cadera en personas de 65 años y más · Confirmación diagnóstica y resolución quirúrgica dentro de 48 horas desde el ingreso hospitalario, profilaxis tromboembólica obligatoria y rehabilitación precoz.**

Tema **10.23** · Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES
`1.07.1.001` · `1.07.1.017` · `1.07.2.003`
pág. **38**

GES **GES N° 1 (Hipertensión arterial primaria o esencial, desde los 15 años) y GES N° 5 (Infarto agudo del miocardio con supradesnivel ST: acceso a trombólisis o angioplastia) · Programa de Salud Cardiovascular en APS**

Tema **10.25** · Cardiovascular en el Adulto Mayor: Hipertensión Arterial y Evento Coronario
`1.07.1.009` · `1.07.2.002`
pág. **40**

GES **GES N° 4 (Alivio del dolor por cáncer avanzado y cuidados paliativos) · Ley 21.375 de cuidados paliativos universales y Ley 20.584 de derechos y deberes de los pacientes**

Tema **10.26** · Cuidados Paliativos, Dolor Crónico y Final de Vida
`1.07.3.003` · `1.08.3.007` · `1.08.3.008`
pág. **42**

Sin garantía GES específica (12 temas): 10.5 · 10.6 · 10.7 · 10.10 · 10.12 · 10.13 · 10.16 · 10.17 · 10.19 · 10.21 · 10.22 · 10.24. Revisa igual la norma MINSAL que cita cada página.

Plan de repaso de 7 días

Los temas van de mayor a menor prioridad (★ según preguntas reales EUNACOM 2013–2025). Cada día: lee la página del tema, recorre su algoritmo y haz sus preguntas del Libro Gordo; corrige con el solucionario.

DÍA 1

5 temas · ★★★

- ★★★ **10.2** Ataque Isquémico Transitorio (AIT): Score ABCD2, Estratificación de Riesgo Precoz y Prevención Secundaria 6
- ★★★ **10.5** Trombosis Venosa Cerebral: Factores Protrombóticos, Sospecha Clínica, Neuroimagen y Anticoagulación Plena 11
- ★★★ **10.1** Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES 4
- ★★★ **10.3** Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos 7
- ★★★ **10.16** Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo 27

Practica: Libro Gordo Neurología, preguntas 1, 3–15, 18, 37, 58–63.

DÍA 2

5 temas · ★★★

- ★★★ **10.21** Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente 35
- ★★★ **10.14** Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve 24
- ★★★ **10.11** Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras 20
- ★★★ **10.24** Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor 39
- ★★☆ **10.12** Parkinsonismos Secundarios, Farmacológicos y Síndromes Parkinson-Plus 22

Practica: Libro Gordo Neurología, preguntas 40–47, 52–54, 75–80, 88–90.

DÍA 3

4 temas · ★★

- ★★☆ **10.15** Demencia Vascular, Demencia por Cuerpos de Lewy y Demencia Frontotemporal 26
- ★★☆ **10.17** Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma 29
- ★★☆ **10.19** Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento 33
- ★★☆ **10.10** Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas 19

Practica: Libro Gordo Neurología, preguntas 21, 64–67, 69–71.

DÍA 4

4 temas · ★★

- ★★☆ **10.22** Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI) 37
- ★★☆ **10.4** Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino 9
- ★★☆ **10.6** Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional 12
- ★★☆ **10.8** Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES 15

Practica: Libro Gordo Neurología, preguntas 16–17, 22–30, 33–34, 81–84.

DÍA 5

4 temas · ★★

- ★★☆ **10.20** Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central: VPPB, Maniobras de Epley y Protocolo HINTS 34
- ★☆☆ **10.7** Cefalea en Racimos (Cluster) y Neuralgia del Trigémino: Diagnóstico Diferencial, Manejo Agudo y Preventivo 14
- ★☆☆ **10.13** Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos 23
- ★☆☆ **10.18** Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad 31

Practica: Libro Gordo Neurología, preguntas 31–32, 48–51, 68, 72.

DÍA 6

4 temas · ★

- ★☆☆ **10.23** Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES 38
- ★☆☆ **10.26** Cuidados Paliativos, Dolor Crónico y Final de Vida 42
- ★☆☆ **10.9** Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo 17
- ★☆☆ **10.25** Cardiovascular en el Adulto Mayor: Hipertensión Arterial y Evento Coronario 40

Practica: Libro Gordo Neurología, preguntas 20, 35–36, 85–87.

DÍA 7

- Relee «**Números que tienes que saber**» y «**Fármacos de primera línea**» pág. 43
- Repasa solo las **Trampas EUNACOM** y la **Regla de oro** de los temas ★★★: 10.1 · 10.2 · 10.3 · 10.5 · 10.11 · 10.14 · 10.16 · 10.21 · 10.24
- Simulacro: las **90 preguntas** del Libro Gordo Neurología en 120 minutos; vuelve a la página de cada tema que falles.

Índice por prioridad ★

El número a la izquierda es la cantidad de preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) en los códigos Perfil V3 del tema.

★★★ Prioridad alta · 9 temas

16 10.2. Ataque Isquémico Transitorio (AIT): Score ABCD2, Estratificación de Riesgo Precoz y Prevención Secundaria GES 6

16 10.5. Trombosis Venosa Cerebral: Factores Protrombóticos, Sospecha Clínica, Neuroimagen y Anticoagulación Plena 11

15 10.1. Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES GES 4

15 10.3. Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos GES 7

14 10.16. Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo 27

14 10.21. Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente 35

12 10.14. Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve GES 24

9 10.11. Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras GES 20

8 10.24. Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor 39

★★ Prioridad media · 10 temas

7 10.12. Parkinsonismos Secundarios, Farmacológicos y Síndromes Parkinson-Plus 22

6 10.15. Demencia Vascular, Demencia por Cuerpos de Lewy y Demencia Frontotemporal GES 26

6 10.17. Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma 29

6 10.19. Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento 33

5 10.10. Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas 19

5 10.22. Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI) 37

4 10.4. Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino GES 9

4 10.6. Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional 12

4 10.8. Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES GES 15

4 10.20. Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central: VPPB, Maniobras de Epley y Protocolo HINTS GES 34

★ Prioridad baja · 7 temas

3 10.7. Cefalea en Racimos (Cluster) y Neuralgia del Trigémino: Diagnóstico Diferencial, Manejo Agudo y Preventivo 14

3 10.13. Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos 23

2 10.18. Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad GES 31

1 10.23. Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES GES 38

1 10.26. Cuidados Paliativos, Dolor Crónico y Final de Vida GES 42

0 10.9. Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo GES 17

0 10.25. Cardiovascular en el Adulto Mayor: Hipertensión Arterial y Evento Coronario GES 40